ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА И ОБЛАСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - МЯГКИЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ

Рахимов Рустам Хакимович, доктор технических наук, заведующий лабораторией №1. Институт Материаловедения Академии наук Республики Узбекистан. E-mail: rustam-shsul@yandex.com

АННОТАЦИЯ. Монография предназначена для широкого круга читателей, как введение в мир узкоспектрального инфракрасного излучения. На доступном читателю языке рассказывается о возможности нового метода терапии с использованием узкоспектральных инфракрасных излучателей.

Ключевые слова: керамические материалы, импульсное излучение, инфракрасные преобразователи, желчный пузырь, печень, почки, сердце, холестерин, кровь, воспаление, иммунитет.

ВЕДЕНИЕ

Мы условно разделяем науку на химию, физику, биологию, медицину с многочисленными разветвлениями их на более мелкие дисциплины. Однако природе безразлично, как мы называем ее законы. Она использует их всегда и все вместе. Даже в элементарной физике мы должны делать ряд упрощений и допущений, создавать идеальные модели, чтобы установить те или иные общие закономерности. Этот прием дает возможность глубже понять процесс, но в то же время настолько упрощает его понимание, что реальные системы не укладываются в наши расчеты, и мы должны их корректировать с помощью разнообразных коэффициентов и функций.

Поиск в науке обычно идет несколькими путями. По мере накопления знаний исследования в каждой из областей человеческого познания становились все более глубокими, а методы исследований все более усложнялись и специализировались. Количество объектов исследований также росло в геометрической прогрессии. Наука дробилась на все более узкие направления, углубление знаний и открытие новых закономерностей позволили открыть такие законы, которые без этого невозможно было бы увидеть. Например, применение метода исследования in vitro в иммунологии привело к поистине гениальным результатам, однако его использование имеет свои ограничения. Живой организм – не пробирка для клеточных культур, он может как восполнять недостающие вещества (за счет ускорения процессов обмена и специфических реакций происходит выработка особых веществ, способствующих поддержанию гомеостаза), так и выводить продукты распада.

Мы можем регулировать процессы на гормональном уровне, на уровне микроорганизмов, ферментов и катализаторов – таких, как витамины и микроэлементы и т.д.; - однако при этом забываем, что, в конечном счете, метаболизм живого организма - это параллельные и последовательные химические и фотохимические процессы. Согласованность их скоростей - решающий фактор в обеспечении гомеостаза и адекватного ответа на изменяющиеся внешние условия. Печально известные онкологические процессы можно рассматривать и как химические, имеющие свои регулирующие факторы, например, количество и тип радикалов, наличие конкурирующих реакций, природа и концентрация ингибиторов и т.д. Их отличительная черта - обычно слишком высокая энергия активации, необходимая для проведения реакции рекомбинации свободных радикалов. Благодаря этому они и остаются «бессмертными».

Не отрицая роли генетического фактора, необходимо подчеркнуть, что он определяет способность организма проводить те или иные процессы в совокупности. Простой пример - высокая концентрация ртути или ионов иного тяжелого металла в организме, - приводит к неминуемой его смерти независимо от генетического фактора. Или диоксин, оказывающий воздействие на любой уровень регуляции. Все это происходит за счет элементарных химических процессов. Другими словами, нарушения на уровне элементарных химических реакций приводят к нарушениям на всех остальных уровнях и, наоборот, нарушения на более высоких уровнях, является также нарушениями и на уровне химических процессов.

Онкопроцессы могут быть обусловлены внешними или внутренними причинами, на которые влияние генетического фактора невелико. Это доказывают данные, приведенные в книгах В.А. Чаклина «Путешествие за тайной» и «Путешествие за тайной продолжается» (М. Наука 1969, 72), где приводится статистика зависимости онкологических поражений от образа жизни и обычаев различных народов. С другой стороны, онкопроцесс может быть остановлен за счет удаления (рекомбинации и элиминирования) радикалов с высокой энергией активации, независимо от того, каким образом они появились в организме - за счет онковирусов, радиации, УФ излучения, окислительного стресса, органических ядов (например, диоксина или бутифоса), ионов тяжелых металлов, ухудшения кровообращения, нарушения работы кишечника и т.д. Другими словами, если мы имеем систему, позволяющую управлять процессами на молекулярном уровне, то мы можем восстанавливать гомеостаз. Если же при этом мы найдем истинную причину заболевания и устраним ее, то можем гарантировать успех лечения.

Другой характерный пример – инфаркт миокарда. Главной его причиной многие годы считалась гипоксия, возникающая обычно за счет атеросклероза. Благодаря кропотливым исследованиям ученых разных специальностей, было установлено, что в этом повинны реакции перекисного окисления липидов. Повышение парциального давления кислорода наряду с устранением гипоксии, приводит к ускорению реакции перекисного окисления липидов. При этом образуются свободные радикалы, которые резко увеличивают энергозатраты и ведут к распаду мембран. Это - главная причина инфаркта миокарда. Для того, чтобы остановить этот процесс, необходимо ингибировать реакцию перекисного окисления липидов. В этой связи много говорится о роли антиоксидантов. Можно принимать их в неограниченном количестве, но не получить никакого положительного эффекта. В большинстве случаев это связано с нарушением

кровообращения или состава микрофлоры кишечника, которые поставляют организму пластические и энергетические материалы, витамины, питательные вещества, антибиотики и т.д. Если микрофлора не может обеспечить усвоение этих веществ, то даже при избытке, например, витамина А или других витаминов в потребляемых продуктах, мы будем иметь выраженный авитаминоз.

Можно приводить бесчисленные примеры нарушения нормального течения процессов на элементарном, молекулярном уровне. Важно учитывать, что любой, даже самый сложный биологический процесс имеет в своей основе и обычные химические процессы, которые должны быть согласованы между собой как по типам процессов, так и по кинетическим параметрам. Регулирующие механизмы нашего организма позволяют управлять этими химическими и фотохимическими процессами, но, как в любой системе, возможности регулирования ограничены. В этих случаях необходимо помогать организму путем направленного воздействия именно на молекулярном, химическом и фотохимическом уровне реакций обмена. Целенаправленные внешние воздействия, позволяющие уничтожить патологическую микрофлору, вирусы, устранить нарушения обменных процессов, рекомбинировать радикалы с высокой энергией активации, управлять реакциями перекисного окисления липидов, нормализовать гормональный баланс в организме и микрофлору кишечника и т.д., позволяет избежать многих заболеваний и жить полноценной жизнью.

МЕХАНИЗМ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ

Известно, что световая энергия распространяется фотонами. Из условия частоты Бора, когда атом меняет свою энергию, разница $\Delta\mathbf{E}$ выделяется в виде фотона с частотой $\boldsymbol{\nu}$.

Квантовая энергия фотона зависит от длины волны света в соответствии с уравнением

$$\Delta E = h\nu = hc/\lambda$$

где:

h - постоянная Планка (1.58 x10-34 кал · сек или 6.626x10-34 Дж·сек),

ν - частота излучения, с - скорость света в вакууме,

λ - длина волны света.

Чем короче длина волны, тем выше энергия. Например, один моль (6.02×10^{23}) фотона красного света (длина волны 635 нм) содержит приблизительно 45 ккал энергии.

Поглощение света – это первый шаг в любом фотохимическом процессе. Когда фотон поглощается, электрон становится энергетически достаточно активным, чтобы быть вытолкнутым с внутренней орбиты на внешнюю. В результате молекула переходит в “возбужденное состояние”.

Вследствие ограниченного числа орбит, имеющих особый энергетический уровень, на которых могут существовать электроны, любой заданный атом или молекула могут абсорбировать свет только определенной длины волны.

Человек излучает фотоны ИК, которые можно обнаружить и определить. Их мощность составляет около 50-100 Вт. Излучение является результатом химических (фотохимических) процессов в организме. Любые патологические процессы влекут за собой изменение энергетического состояния органа, его части или всего организма. Понимая сущность этих процессов, мы можем их корректировать, используя определенные длины волн, в соответствии с вышеприведенной формулой.

Длина волны ИК-излучения для медицинских применений должна иметь квантовую энергию не выше той, которую производит сам человек, так как в противном случае могут произойти нежелательные повреждающие процессы. В то же время, она должна быть такой, чтобы могла использоваться для выравнивания скоростей фотохимических процессов организма, нормализации иммунных процессов, растворения патологических образований (например, коллагена, атеросклеротических бляшек и т.д.), а также уничтожения бактерий, грибков и вирусов.

Наш подход заключается в создании сложных систем преобразования энергии полученных на основе керамических материалов с заданными свойствами, способных поглощать электромагнитное излучение широкого спектра, а испускать в узком длинноволновом спектральном диапазоне ИК.

Керамика изготавливается путем специальной многостадийной и очень сложной технологии при температуре до 3000°C в солнечной печи мощностью 1 миллион Вт, что эквивалентно световому излучению ядерного взрыва. Это позволяет получать сверхчистые материалы, так как для плавки используется лучистая энергия. Полный технологический процесс занимает 1-12 месяцев.

В настоящее время в медицине используется 15 видов керамических преобразователей. Каждый из них испускает строго определенные длины волн.

Керамика наносится на поверхность любого источника световой энергии, например, электрической лампы или другого нагревательного элемента. При включении первичного источника излучения его энергия трансформируется, как было отмечено, в длинноволновое ИК-излучение заданного узкого

спектрального диапазона. Это процесс является автокаталитическим, и происходит всегда, когда мы включаем первичный источник излучения.

Процесс поглощения и излучения протекает непрерывно по всему керамическому слою, в результате чего керамика вырабатывает излучение определенной частоты за счет поглощения “неорганизованной энергии”. Процесс преобразования основан на том, что в керамических материалах в результате поглощения энергии разных длин волн, происходят определенные фотохимические реакции, увеличивающие общую энергию системы. После достижения точки насыщения (энергии активации или энергетического барьера) система возвращается в исходное энергетическое состояние с выделением поглощенной энергии в виде определенного кванта, т. е. мы получаем излучение с необходимой длиной волны. Продолжительность каждого единичного процесса составляет около 1/100 микросекунды.

Таким образом, задавая свойства керамики и изменяя тем самым величину энергетического барьера системы, можно получить излучение с определенной длиной волны. Принимая во внимание, что для практического применения в первую очередь необходимо излучение в диапазоне длин волн от 8 до 50 мкм (1 мкм = 1000 нм = $1x10^{-6}$ м), наши усилия были направлены на создание функциональной керамики, генерирующей монохромное излучение в данной спектральной области. Длина волны определяется только типом керамики.

Индивидуальные реакции похожи на процессы “насоса” внутри активных фотохимических элементов и проходят очень быстро. Характерно, что каждая фотохимическая реакция проходит только за счет определенной «своей» длины волны. Таким образом, достигается более полное использование энергии первичного источника. При возврате системы в первоначальное энергетическое состояние, энергия теперь уже выделяется в узком спектральном диапазоне, который определяется как $\Delta E = h\nu = hc/\lambda$.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕЗОНАНСНОГО ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ

Метод основан на нормализации обменных и устранении патологических процессов ИК-воздействием, находящимся в резонансе с процессами, которые необходимо скорректировать. Иными словами, излучение нормализует процессы обмена и устраняет **причину болезни, а не только ее симптомы.**



Керамические ИК-излучатели (эмиттеры) имеют определенную длину волны в узком спектральном диапазоне, а не в широком, как обычные ИК-излучатели. Кроме того, они имеют различные временные характеристики и могут быть непрерывными, импульсными или излучать энергию в сложной временной последовательности. По конструкции существуют излучатели общего и локального применения. Общие (b) воздействуют на всю поверхность тела, локальные (s) на отдельные органы или участки тела, вовлеченные в патологический процесс. Имеются следующие виды излучателей:

Серия К - иммунно-нормализующие используются:



KL - обычно при пониженных скоростях обменных процессов.

KH - обычно при повышенных скоростях обменных процессов.

KB - для ускорения регенерации костной ткани.

KS – для профилактических целей.

Серия G

GI – оказывает **противовоспалительное и противоинфекционное** действие.

GL, GM, GH - используются при лечении заболеваний эндокринной системы тяжелой и средней степени поражения.

AF – обладает **противоинфекционным,** а также **противогрибковым** действием.

Серия R

RV – оказывает **противовирусное** действие и рекомбинирует свободные радикалы.

RC – **противоонкологическое** действие, рекомбинация свободных радикалов.

Серия Z применяется

ZB – для улучшения микроциркуляции, удаления отложений на стенках сосудов, перевода нерастворимой патологической ткани в растворимое состояние.

ZC - для лечения системных заболеваний соединительной ткани.

АК - для лечения системных заболеваний соединительной ткани, при тяжелых поражениях органов патологической соединительной тканью (цирроз печени и др.), для рассасывания келлоидных рубцов и спаек. Этот излучатель может выполнять все функции **ZB** с эффективностью, примерно, в 10 раз выше (в случае его применения, время воздействия необходимо сократить в 10 раз)

AV - применяется при заболеваниях вен. Кроме того, этот излучатель может выполнять все функции **АК** с эффективностью, примерно, в 10 раз выше (при его использовании вместо **АК** время воздействия необходимо сократить в 10 раз)

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ИХ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Известно, что опухоль представляет собой атипическое органоидное образование, растущее из первоначального зачатка посредством пролиферации своих собственных элементов, для которых размножение является главной целью.

J. Burnet говорит об опухоли как о “генетическом парадоксе”: не совместимые с организмом клетки не только продолжают существовать, но и активно размножаются. Было установлено, что одной из причин роста и размножения опухолевых клеток являются радикалы с высокой энергией активации.

Популяция клеток опухоли гетерогенна, с чем связывают их различную митотическую активность. Данные о митотической активности опухолей важны для рационального проведения химио- и лучевой терапии, применяемой в традиционной медицине. Радиотерапия, применяемая при онкозаболеваниях, оказывает воздействие на опухоль за счет разрушения клеток жестким воздействием очень высокой квантовой энергии (чем короче длина волны, тем выше энергия). Однако при этом разрушаются окружающие нормальные клетки, что приводит к тяжелым осложнениям. Кроме того, высокий уровень энергии используемого излучения приводит к образованию новых радикалов, каждый из которых, в дальнейшем, при определенных условиях может дать начало росту новой опухоли.

Делящиеся опухолевые клетки являются мишенью химиотерапии. Препараты химиотерапии, окружая активный радикал делящейся опухолевой клетки, вступают или не вступают с ним в химическую реакцию, и поэтому только временно приостанавливают рост опухоли. Во-первых, они не обладают необходимой энергией активации для вступления в реакцию с активным радикалом опухолевой клетки и окончательного прекращения ее роста. Во-вторых, они сами являются канцерогенами (так как имеют молекулярную структуру с подвижными П-электронами), которые в будущем с высокой вероятностью дадут новые радикалы и, соответственно, опухоли.

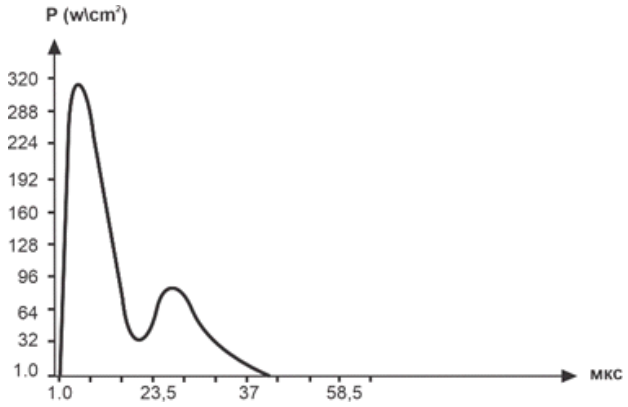
Исходя из этих данных, можно с уверенностью сказать, что химиотерапия не способна к элиминации всех клеток опухоли. Она может лишь довести их количество до определенных критических величин. Кроме того, при этом, практически, не удается сохранить активность клеток иммунной системы, да и иммунитета в целом. Общее цитолитическое и иммунодепрессивное действие лучевой и химиотерапии общеизвестно.

Применение радио- или химиотерапии через определенное время (это может быть месяц, а может быть и два года) в большинстве случаев приводит к более глубокому и серьезному заболеванию, так как вновь образовавшиеся радикалы с высокой энергией активации создают на молекулярном уровне новые центры онкопроцессов в организме.

В отличие от химио- и лучевой терапии, предложенный нами метод влияет только на онкологический процесс, не затрагивая здоровые ткани организма. Механизм антионкологического действия излучателя **RC** заключается в нейтрализации активного радикала атипичной клетки, который способствовал её бесконечному делению и росту. Излучатель **RC** испускает два последовательных импульса за очень короткое время - в миллионные доли секунды. Первый имеет необходимую энергию активации для создания активного радикала из ионизированной воды, составляющей 10^{-14} от общего содержания воды в организме. Второй заставляет активный радикал делящейся онкологической клетки соединиться с образовавшимся радикалом воды (или липидов) и, таким образом, прекратить рост злокачественной опухоли.

Первый импульс длится 10 мкс, при плотности энергии 320 Вт на см^2.

$$H_2O \rightarrow HO\bullet + H\bullet$$



Второй импульс длится приблизительно 13 мкс и стимулирует вновь образованные радикалы вступить в реакцию с радикалом в клетке.

Кроме того, этот импульс приводит к рекомбинации радикалов, образованных из воды.

$$HOOH \rightarrow 2HO\bullet$$

$LOOH \rightarrow LO\bullet + \mathrm{OH}\bullet$ (могут образоваться радикалы и по схеме $LOOH \rightarrow LO\mathrm{O}\bullet + \mathrm{H}\bullet$)

Под действием второго импульса RC они могут рекомбинировать с радикалом или идет обратная рекомбинация в супероксиды и липиды.

$R\bullet + HO\bullet \rightarrow ROH$

$R\bullet + H\bullet \rightarrow RH$

$R\bullet + LO\bullet \rightarrow LOR$

$R\bullet + LO\mathrm{O}\bullet \rightarrow LOOR$

$2HO\bullet \rightarrow HOOH$

$LO\bullet + OH\bullet \rightarrow LOOH$

(радикал молекулы воды долго не существует, т.к. он всегда стремится быть в комбинации H_2O)

В результате воздействия излучателем образуется химически стабильная система, позволяющая остановить развитие онкологического процесса. Применение при этом других видов излучателей позволяет нормализовать микроциркуляцию, укрепить иммунную систему, уничтожить патогенную инфекцию, нормализовать микрофлору кишечника и т. д.

ПРОФИЛАКТИКА РАКА

Все организмы получают энергию для жизнедеятельности за счет сложных окислительно-восстановительных реакций. Освобождающаяся при этих процессах энергия, затрачивается для различной работы в организме: сокращения мышц, нервного возбуждения, образования новых белков и клеток. Осуществляются эти процессы с помощью особых катализаторов – белков.

Спирт, например, окисляется в организме с помощью фермента алкогольдегидразы. Фермент и спирт, взятые по отдельности, не дают сигналов ЭПР (электронного парамагнитного резонанса). В тот момент, когда эти два

вещества соединяются вместе, на экране ЭПР-спектрометра возникает сигнал, свидетельствующий об образовании свободных радикалов. Точно также можно обнаружить свободные радикалы и при клеточном дыхании, когда необходимый для дыхания фермент рибофлавин переходит в свободно радикальное состояние. Какова дальнейшая судьба этих радикалов?

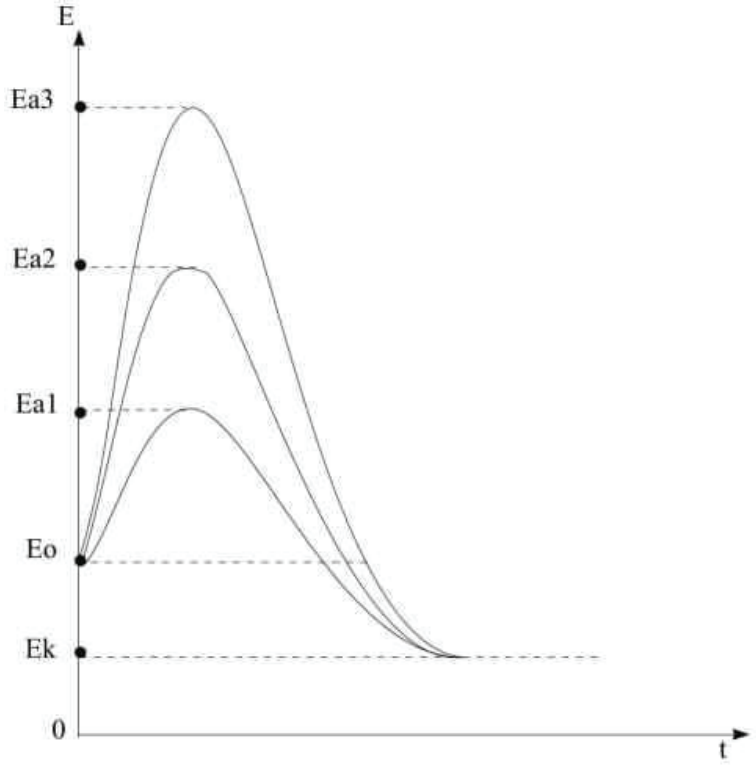
Всякая химическая реакция связана с перестройкой электронных оболочек атомов и молекул. Обычно молекулы реагируют друг с другом либо при прямом столкновении, либо через какое-то промежуточное звено. Если подсчитать, как часто могут сталкиваться в живой клетке (в результате теплового движения) различные молекулы, то окажется, что при температуре теплокровных организмов – примерно 37 градусов Цельсия – реакции должны были бы идти значительно медленнее, чем это наблюдается в действительности. Мы знаем, что их ускоряют ферменты. Но каким образом при этом взаимодействуют молекулы?

Человеческий организм постоянно подвергается воздействию радикалов, попавших извне с пищей или образованных под воздействием различных энергетических полей (например, ультрафиолетовыми лучами) и др. Организм имеет собственный механизм избавления от этих радикалов, в их элиминации участвуют антиоксидантные факторы защиты. Если в результате каких-либо причин в организме появляются радикалы с более высокой энергией активации и антиоксидантные факторы не срабатывают, число свободных радикалов возрастает, при этом появляются радикалы, имеющие высокую энергию активации реакции рекомбинации - их устранение становиться невозможным, что приводит к «неуправляемому» росту опухоли.

Что же такое энергия активации?

Энергетически (термодинамически) выгодно чтобы свободная поверхность была меньше. Поэтому, если поместить рядом 2 капли воды, то они сольются, т.к. энергетический барьер (Ea1) это лишь сила поверхностного натяжения воды. Если поместить рядом 2 таких же шарика пластилина, то также термодинамически выгодно их соединение (т.к. поверхность уменьшается во столько же раз, как и в случае с капельками воды), но необходимо затратить больше усилий для их сжатия (необходимо затратить больше энергии, т.к. энергии активации этого процесса вышеEa2). Если попытаться соединить 2 стальных шарика, такого же размера, то энергия активация (Ea3) этого процесса будет настолько высока, что потребуются громадные усилия для проведения этого термодинамически выгодного процесса. В тоже время стальной шар

может свободно прореагировать с шариком масла или шариком пластилина. Энергия активация этого процесса достаточно низкая.



Так процесс рекомбинация радикалов с высокой энергией активации, подобен процессу соединения двух стальных шаров (энергия активация или энергетический барьер рекомбинации радикалов слишком высок)

Применение ИК-излучателей может предотвратить развитие онкологического процесса, за счет нейтрализации свободных радикалов с высокой энергией активации, еще до появления атипичных онкологических клеток. Таким образом, появилась реальная возможность раннего определения, профилактики и полного излечения, больных онкологическими заболеваниями.

Наша цель – использовать соответствующие ИК-излучатели для профилактики рака, особенно среди детей, для того чтобы снизить заболеваемость у следующего поколения.

ПОДАВЛЕНИЕ РЕПЛИКАЦИИ ВИРУСОВ

Рассмотрим подавление вирусов на примере ретровирусов, к которым относится, например, ВИЧ. Ретровирусы это вирусы, наследственная информация которых может быть записана в клетках в форме ДНК, а в вирусных частицах - в форме РНК, благодаря существованию в жизненном цикле этих вирусов обратной транскрипции (синтез ДНК на матрице РНК). Процесс

обратной транскрипции контролирует вирусный фермент – *ревертаза,* который осуществляет обратный поток информации от РНК к ДНК, собственно, благодаря ей ретровирусы и получили свое название (лат. Retro - “обратно”).

Для ретровирусов характерна высокая частота репродукции и способность к захвату чужих генов (клеточных или вирусных). Естественно, что с захватом нового гена ретровирус приобретает новые свойства. Этот ген в сотни, а иногда и в тысячи раз увеличивает способность вируса к размножению.

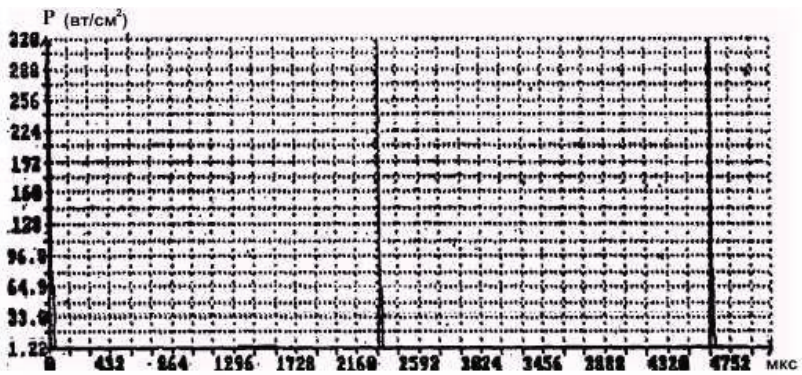
Ретровирусы делятся на три группы:

- онковирусы, имеющие в своей структуре онкогены, которые приводят к быстрому появлению опухоли
- лентивирусы, или “медленные” вирусы
- вирусы Галло, занимающие промежуточное положение между онко- и лентивирусами,

Ретровирусы являются одной из причин развития онкологического заболевания, из-за присутствия в них онкогена. Однако онкогены не всегда приводят к канцерогенезу. Они должны быть активированы, например, вирусным промотером, клеточным промотером, кофактором типа химических канцерогенов или путем взаимодействия с другими онкогенами.

Для большинства ретровирусов характерно отсутствие цитопатического эффекта, то есть вирус и клетка могут мирно сосуществовать сколь угодно долго, постепенно ослабляя организм хозяина. Предполагают, что причина гибели клетки - присутствие в ней множества копий свободного провируса и интенсивное размножение вируса, истощающее клетку.

С помощью керамического ИК-излучения **RV** можно прервать процесс воспроизводства различных типов вирусов, являющихся причиной таких заболеваний, как гепатит, простой герпес, и других вирусных инфекций, путем инактивации главного фермента, в частности, ревертазы.



RV обладает преимущественно антивирусным действием за счет инактивации вирусных ферментов. В отличие от излучателя **RC,** он производит дополнительные импульсы более высокой энергии.

Энергетическая характеристика излучателя RV

Излучатель **TL1** также обладает антивирусным действием, но в отличие от **RC** и **RV** он производит одиночный импульс.

КОРРЕКТИРОВКА СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Физико-химические процессы, происходящие в организме человека, постоянно производят тепло в виде фотонов ИК. Длина волны ИК-излучения человека составляет 9,36 мкм.

Реакции, протекающие в живом организме, в основном фотохимические. Логично предположить, что их скорости зависят от уровня вырабатываемой и поглощаемой энергии. Состояние иммунной системы и интенсивность обменных процессов определяются скоростью химических реакций и зависят от уровня излучаемой энергии. По мере ослабления этого излучения мы наблюдаем снижение защитных (иммунных) свойств организма. Общее ослабление ИК-излучения приводит к снижению скоростей фотохимических реакций. Когда эти скорости снижаются равномерно, все процессы идут медленнее, но в правильном соотношении и последовательности. Так, например, несмотря на то, что мальчик 12 лет и мужчина 80 лет имеют одинаковую температуру тела, при измерении потока излучения у них выявляется, что у молодого организма он в 10-20 раз выше, чем у пожилого. Из этого следует, что процессы восстановления в большинстве случаев идут быстрее у молодых за счет наличия большего потока излучения.

При патологических состояниях скорости различных реакций снижаются неодинаково, в результате, в зоне снижения отмечается накопление продуктов предыдущих реакций. По закону действия масс эти продукты идут на другие конкурирующие реакции. Таким образом, в организме возникает дисбаланс необходимых компонентов, и постепенно развиваются различные патологические состояния.

Например, в здоровом организме протекает ряд последовательных реакций

A+B=AB

AB+C=ABC

ABC+D=CB+AD

Если по какой-либо причине замедлилась реакция A+B=AB, то избыток A будет автоматически расходоваться на другой процесс A+C=AC, что приводит к изменению всей цепочки последовательности нормальных реакций и накоплению излишних компонентов, так или иначе вредно действующих на организм. За счет этих же реакций вырабатывается наше собственное излучение, при дисбалансе процессов происходит снижение его общего уровня.

Согласно разработанной нами теории, если извне подать излучение, соответствующее нашему собственному, то скорости реакций выравниваются, нормализуя обменные процессы, повышая иммунитет. На этом основан механизм действия излучателей серии **К**, чаще устанавливаемых в область чувствительных зон (гипоталамус, тимус, VII шейный позвонок, область пяток, поджелудочная железа).

Излучатели серии **К** используются также для нормализации состояния симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, для лечения аллергических состояний.

Состояние иммунной системы тесно связано с состоянием сосудов и циркулирующией в них жидкости - крови и лимфы, с которыми в органы, ткани и клетки поступают все необходимые для нормальной жизнедеятельности организма компоненты и выводятся отработанные продукты. Поэтому восстановлению циркуляции, особенно в мелких сосудах, при лечении различных заболеваний необходимо придавать первостепенное значение. Мы предлагаем использовать в этом случае излучатели серии **Z**.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЛЛАГЕН И ТРОМБЫ

В процессе жизни человека на стенках его сосудов и в межклеточном пространстве происходит отложение нерастворимых соединений (тромбы, атеросклеротические бляшки, патологический коллаген), приводящих к развитию заболеваний.

Патологический коллаген, образующийся при заболеваниях соединительной ткани, отличается от естественного тем, что имеет незаконченную структуру и большую молекулярную массу. Внутримолекулярные связи патологических отложений менее прочные, т.к. осуществляются за счет водородных связей, сил вандерваальса и др.

Механизм действия излучателей серии **Z** заключается в “расшатывании” этих слабых межмолекулярных связей и переводу нерастворимых соединений в растворимое состояние, с последующим выведением их из организма без опасности тромбирования.

Излучатели серии **Z** применяются при лечении гипертонической болезни, атеросклероза, инсульта, заболеваний позвоночника (под воздействием излучателя восстанавливается его подвижность за счет повышения эластичности межпозвоночных дисков), при лечении больных с диабетической ангиопатией (за счет нормализации микроциркуляции исчезают такие симптомы как онемение, похолодание конечностей, предотвращается развитие язв и гангрены).

Существует 4 вида излучателей серии **Z**. Они отличаются друг от друга мощностью излучения и в порядке возрастания излучаемой энергии располагаются следующим образом: **ZB→ZC→АК→AV.**

ZB чаще используется для очистки сосудистой системы и нормализации микроциркуляции. **ZC** и **АК** применяются при системных коллагенозах, для рассасывания патологической соединительной ткани. **AV** применяется при заболеваниях вен (варикозное расширение, тромбофлебит).

БОРЬБА С МИКРООРГАНИЗМАМИ

Если деление клеток бактерий рассматривать на молекулярном уровне, этот процесс будет выглядеть как цепь последовательных химических реакций, происходящих с определенной скоростью. Если в этой цепи хотя бы один из процессов будет остановлен или подавлен, размножение клетки бактерии прекратится, и она погибнет.

На этом принципе основана работа излучателя **GI**. Точно рассчитанный спектр его излучения направлен на прерывание химических реакций, участвующих в делении клеток патогенной флоры. Микроорганизмы (бактерии, простейшие), не имеющие возможности для дальнейшего деления, погибают, так как цикл их жизнедеятельности очень короткий. На клетки человеческого организма разрушающего влияния излучатель не оказывает, так как спектр излучения делящихся клеток патогенной флоры отличен от спектра поглощения человека.

Применение ИК-излучения с широким спектром действия в медицине нередко может привести к перегреву организма в результате преобладания процессов поглощения над процессами излучения, и наоборот. В связи с этим,

использование его противопоказано в острый период воспалительных заболеваний. Излучатели **GI** не оказывают подобного отрицательного действия, что связано с излучением селективной длины волны, не приводящей к перегреву организма. Добавим, что, во избежание образования при гибели инфекционных агентов большого количества токсинов, способных активизировать биологически активные вещества (что может привести к появлению в организме активных радикалов и спровоцировать воспалительные реакции) в излучателях серии **GI** обычно используется керамика с антионкологическими свойствами типа **RC**. В зависимости от концентрации этих добавок они обозначаются, как, например, **GI** 05 (0.5%), **GI** 5 (5%) и т.д.

Излучатель **AF** также обладает антибактериальным действием, усиленным по сравнению с излучателями **GI** в несколько раз. Если излучатели серии **GI** способны приостановить деление клетки посредством остановки единичных реакций, то **AF** прерывает сразу десятки и сотни реакций деления клеток патогенной флоры. Кроме того, благодаря определенной длине волны, излучатель **AF** «обезвоживает» грибковые клетки, что ведет к их быстрой инактивации. Это позволяет применять излучатель **AF** при лечении микозов.

УСТАНОВКА "СТ"



Актуальной проблемой в медицине является разработка эффективных методов лечение заболеваний органов малого таза.

Для решения этой проблемы на основе метода резонансной терапии разработана принципиально новая установка «СТ» которая позволяет воздействовать непосредственно на промежность, органы малого таза.

В состав установки «СТ» входят излучатели (**KL/GI).**

Эффективна при лечении кольпита, вульвовагинита, проктита, парапроктита, эндометрита, аднексита, простатита, цистита, уретрита, аденомы предстательной железы, миомы, злокачественных и доброкачественных опухолей половых органов, эрозии шейки матки, трещин прямой кишки и т. д. без применения лекарственных препаратов

Воздействуя одновременно на патологический процесс через переднюю брюшную стенку и промежность, значительно укорачивается время необходимое для исчезновения клинических проявлений заболевания. Сочетание излучателей общего и локального действия с установкой «СТ», позволяет добиться положительного результата лечения в короткие сроки.

Установлено, что использование данной установки нормализует также иммунную систему:

Под действием ИК-излучения на прямую кишку, сигму, мочевой пузырь, половые органы и железы, помимо того, что мы снимаем воспаление, уничтожаем вирусы, улучшаем кровоснабжение, достигается повышенная выработка секреторного фрагмента IgA, (который вырабатывается в слизистой оболочке мочеполовых органов и желудочно-кишечного тракта.) Известно, что при уменьшении количества секреторного фрагмента IgA происходит рост количества патогенной микрофлоры в кишечнике и в половых органах. IgA обуславливает местный иммунитет слизистых оболочек, в том числе и женских половых органов, оказывает антивирусное и антибактериальное действие.

При воздействии излучателя KL(s) на область вилочковой железы мы способствуем выработке IgM или *у*-макроглобулина, который синтезируется при участии информационных РНК на рибосомах гранулярной эндоплазматической сети лимфоцитов и плазмоцитов. IgM обладает антивирусной и бактериологической активностью, что немаловажно для нашего организма как ответная реакция на проникновение чужеродного агента через так называемые входные ворота.

Клинические примеры:

Больная Н. 39 лет обратилась с жалобами на боли в области живота, частый жидкий стул в течение 5 часов. При ЭАФ диагностике на БАТ тонкого кишечника показатели колебались от 82-90 и тестировались нозоды b.Streptococcum и b. Salmonella. Получала лечение излучателем GI (“СТ”) в течение 20 минут. Боли в животе исчезли через 10 минут после начала терапии. После первой процедуры стул нормализовался.

Больной Р. 45 лет обратился в клинику с жалобами на бессимптомную гематурию, при обследовании (УЗД, обзорная рентгенография, экскреторная урография, цистоскопия,

обследование per. rectum) обнаружен рак предстательной железы. Лечение: RC(«СТ») на предстательную железу 5 раз в день, RC(b) 1 раз в день ежедневно, RV(«СТ») локальное на область предстательной железы. Под контролем аппарата Фолля проводилось локальное лечение печени, почек, легких, кишечника, головы и позвоночника. Курс терапии продолжался 3 месяца. В результаты лечения размеры простаты нормализовались, данных указывающих на рак предстательной железы не обнаружено. Также прошли сопутствующие заболевания хр. колит, вазомоторный ринит.

Больной С. поступил в клинику с диагнозом обострение хронического простатита, жалобы на боль внизу живота, явления дизурии. Лечение: установка «СТ» GI + KL по 10 мин и ZB(s) на область мочевого пузыря по 10 мин (одновременно) в течение 10 дней. В результате лечения отмечалась полная ремиссия заболевания.

Больная Д. поступила в клинику с признаками острого цистита. После одного сеанса включающего в себя локальное воздействие на мочевой пузырь через переднюю брюшную стенку и промежность установкой «СТ» с использованием излучателей RV+GI+ZB в течение 30 минут были купированы все симптомы острого цистита – учащенное, болезненное мочеиспускание, рези внизу живота, выделение мочи малыми порциями.

Больной К. поступил в клинику с диагнозом аденома предстательной железы. При лечении использовались локальные излучатели RC+ZC+KL на область низа живота и эти же излучатели в установке «СТ». Такие проявления аденомы как затрудненное мочеиспускание, неприятные ощущения внизу живота, беспокоившие больного в течение 5 лет, совершенно прошли через 12 сеансов.

Больная М. 22 лет, в анамнезе имела два самопроизвольных поздних выкидыша с гепатоспленомегалией, анасаркой. В обоих случаях прерывание беременности происходило на 6-7 месяце. При обследовании у женщины обнаружены антитела к цитомегаловирусу. На УЗИ матки и яичников признаки хронического эндометрита. При поступлении больная жаловалась на сильные боли внизу живота, выделения из половых путей с примесью крови, частые головные боли. Женщина получила 12 сеансов с использованием общих и локальных излучателей, таких как

RV+AF+ZC+KL, а также воздействие через промежность с помощью установки «СТ». Действие на матку происходило одновременно через переднюю брюшную стенку и промежность. Через 6 сеансов полностью прекратились выделения из половых путей и боли внизу живота. Через 12 сеансов больная прошла тест на содержание в крови антител к цитомегаловирусу и результат был отрицательный. На УЗИ матка обычной формы, структуры и размеров без признаков эхопатологии.

ТИПЫ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

Типы излучателя	Область применения
Иммунно-нормализующие ИК-излучатели	
KL	Используется при пониженных обменных процессах, снижении иммунитета, для регулирования деятельности эндокринных органов.
KH	Используется при повышенных обменных процессах, повышенном АД, для регулирования деятельности эндокринных органов.
KB	Используются для улучшения регенерации костной ткани
Противовоспалительные ИК - излучатели	
GI	Антибактериальный
AF	Антибактериальный, антимикотический
GL1-GL5, GH	Регулирование деятельности эндокринных органов
ИК-излучатели, применяемые при лечении других заболеваний	
TL1, RV	Противовирусный эффект
RC	Противоонкологическое действие
ZB	Восстановление микроциркуляции и разрушение патологических отложений на стенках сосудов, рассасывание патологического коллагена
ZC	Улучшение кровообращения, рассасывание патологической соединительной ткани, регулирование деятельности эндокринных органов
AK AV	Применяется при лечении заболеваний вен.

Комплект излучателей собирается в формы, называемые локальными и общими лампами. Локальная лампа - это либо обычная, либо галогенная лампа с рефлектором, которая используется при воздействии на отдельные органы. Общая лампа – это длинный кварцевый нагревательный элемент с нихромовой нитью внутри. Кварцевая поверхность покрыта керамическим материалом. Эти лампы предназначены для воздействия на всю поверхность тела.

Имеется множество процессов, которые мы можем нормализовать, подобрав соответствующие излучатели или их комбинацию.

При работе с излучателями рекомендуется проводить диагностическое обследование используя аппарат Фолля. ЭАФ (электроакупунктура Фолля) позволяет проверить электрическую активность в акупунктурной точке, определить скорости и типы химических процессов в органах. Данный метод диагностики, дает возможность увидеть процессы, находящиеся в дисбалансе с остальными, что позволяет выделить причину заболевания и правильно подобрать необходимый для лечения излучатель.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какой материал используется? Кварц? Для изготовления керамического материала используют оксиды редких минералов La, Nd, Ce, Sc и др. Он не содержит кварц, так как кварц не пропускает волны длиннее 3 мкм. Кварц не прозрачен для требуемого нам спектра. Необходимая длина волны начинается от 8 мкм и более.

2.На чем основывается ИК-излучение керамики? ИК излучение происходит на основе процессов энергообмена керамики с внешним источником энергии. Например, для абсолютно черного тела, чем выше температура, тем короче длина волны. Чем ниже частота, тем меньше энергия излучения. Это касается пассивных материалов. Независимо от того, какую температуру имеют наши излучатели, они будут производить излучение с длиной волны, на которую рассчитаны. В нашем случае это активные преобразователи.

3. Какова длина производимой волны? Это не важно (по мнению изобретателя) для конечного пользователя. Можно сказать, что она лежит между 8 и 50 мкм. Для пользователя главное - как правильно применять определенный тип излучателя.

4. Имеем ли мы достаточно ламп для лечения различных болезней? В настоящее время да. На сегодняшний день мы имеем достаточное количество излучателей различных видов, для устранения патологических процессов. По мере надобности новые типы излучателей с необходимыми свойствами могут быть оперативно разработаны в лаборатории.

5. Теряет ли керамика свои свойства в процессе работы? Нет. Она очень стабильна. Действительно, металлы подвержены коррозии, пластмассы - деструкции, а оксиды - это продукты сгорания. Поэтому мы можем сказать, что

керамические материалы максимально устойчивы, особенно, в окислительной среде, каковой является наша атмосфера.

Процессы, происходящие в керамике, - автокаталитические. Действие керамики сравнимо с работой насоса, который поглощает энергию света различных длин волн и, преобразовав ее, испускает, но только в узком инфракрасном спектре через определенные временными промежутки. Независимо от того, какую температуру или длину волны имеет первичный источник, керамика будет производить только излучение с длиной волны в определённом диапазоне. Но главное, - система всегда возвращается в исходное состояние и готова снова к принятию новой порции энергии широкого спектра первичного источника, чтобы преобразовать ее в необходимое излучение.

6. Оказывает ли это излучение неблагоприятное действие на беременность, растущий плод? У нас нет таких данных, за исключением двух женщин, получавших лечение одна в первой, другая во второй половине беременности. Роды у них протекали нормально, и дети родились здоровыми. Изобретатель уверен, что неблагоприятного действия на плод нет, так как спектр излучателей отличен от спектра поглощения человеческого тела или находится в диапазоне, где здоровый человек прозрачен. Взаимодействие излучения происходит только с теми патологическими процессами, которые находятся в резонансе с данным излучением. Патологическая измененная ткань поглощает это излучение, и происходит устранение патологического процесса. Можно сказать, что система устроена так, что сама находит патологические процессы и органы, где автоматически осуществляет правильное лечение. Это открывает широкие перспективы для профилактики многих заболеваний без отрицательных последствий. Ведь вы не будете употреблять радио- или химиотерапию для профилактики рака, так как это - сильнейшие яды и жесткие энергии, приводящие в конечном итоге к онкозаболеваниям.

7. Можем ли мы предотвратить развитие рака данным методом? Определённо да. Для этого необходимо воздействие излучателем в течение нескольких минут в месяц для очищения организма от радикалов с высокой степенью активации.

8. Почему вы уверены, что это защитит организм от онкологических заболеваний? Мы четко представляем механизм онкозаболеваний на молекулярном уровне и считаем, что одним из важнейших факторов, приводящих к появлению и росту опухоли являются радикалы с высокой энергией активации. Применение излучателей, приводящих к их рекомбинации,

не позволит возникнуть и в дальнейшем развиться опухолевому процессу. Естественно предположить, что заметное снижение случаев раковых заболеваний будет наблюдаться через 30-40 лет, среди тех, кто находился с целью профилактики, под воздействием антионкологических ламп.

9. Почему нет побочных отрицательных действий? Лучи имеют длину волны больше 8 мкм и человек является прозрачным для них. Они проходят в тело человека через молекулы воды как световой луч по световоду. Наше тело на 70% состоит из воды. Подобно тому, как зеленый лист использует для синтеза углеводов из H_2O и CO_2 фотоны определенной энергии (следовательно, длины волны), взаимодействие с излучением, проходящим через наши ткани происходит там, где имеется резонансное поглощение. Другими словами, энергия поглощается только патологическими зонами, находящимися в резонансе с излучаемой энергией и не затрагивает здоровые ткани.

10. Существует ли такое понятие, как передозировка? Нет. С того момента, как все процессы нормализовались, дальнейшее воздействие практически не окажет никакого эффекта. Процесс лечения основан на резонансных явлениях. Как только зоны резонанса (патологические процессы, имеющее место в организме) будут ликвидированы, тело становится “прозрачным” для ИК волн наших излучателей. Однако это не относится к обычным ИК-источникам, так как они имеют широкий спектр излучения и не являются резонансными.

11. Можете ли Вы сказать, что нашли панацею? Ни в коем случае. Действительно, наш метод позволяет решить многие проблемы, которые до этого были неразрешимы или решались с выраженными отрицательными побочными эффектами. Это проблемы лечения вирусных заболеваний, нормализация микрофлоры кишечника, уничтожение патогенной микрофлоры, рассасывание патологических тканей, нормализация холестеринового баланса и т.д. Но уверенно можно сказать, что наш метод не дает возможности отрастить потерянные органы, ликвидировать врожденные дефекты. В этих случаях, резонансная терапия может только облегчить состояние больного, например, ускорить заживление ран, снять болевой синдром, нормализовать энергообмен и т.д. Живой организм настолько сложная система, что нарушения его нормальной жизнедеятельности носят комплексный характер. Какую-то часть восстановления … можно осуществить на генетическом уровне, где-то эффективны только фармакологические средства, где-то необходимо хирургическое вмешательство. Наш метод является еще одним дополнением к

общему арсеналу медицины. Только всестороннее видение проблемы и подход к лечению может гарантировать успех.

Наша главная цель, наряду с лечением сложных заболеваний, оказать профилактическое воздействие на человека с момента его рождения или даже раньше. Действительно, в родильных домах человек после рождения приобретает целый букет патогенных микроорганизмов (золотистый стафилококк, синегнойная палочка, протей и т.д.). В дальнейшем простудные или инфекционные заболевания, нарушенная экология, синтетическая еда, ослабляют его организм. Во всех этих и других случаях мы можем помочь больному сохранить здоровье. Наш метод позволяет проводить профилактику онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Только наш метод позволяет реально излечивать эндокринные заболевания, ревматизм, туберкулез.

12. Ваш метод относится к нетрадиционной медицине? Наш метод основан на принципах нормальной медицины. Единственное его отличие – это то, что мы рассматриваем процессы и на молекулярном уровне.

13. Можно ли при использовании вашего метода нормализовать вес? Учитывая, что мы приводим все процессы обмена к норме, естественно ожидать и нормализации веса. В действительности так оно и оказалось. Практически у всех пациентов, прошедших полный курс резонансной терапии, вес приблизился к норме. В качестве примера приводим два случая.

Пример: Больной А. 1950 г.р. поступил в клинику с диагнозом дисбактериоз кишечника. Жалобы при поступлении на частый стул непереваренной пищей после каждого приема пищи, потерю массы тела. Болен в течение 2 лет, неоднократно сдавал кал - патогенная флора не высевалась, лечился лекарственными препаратами, улучшения кратковременные. При осмотре отмечался дефицит массы тела 21% (при росте 188см вес составил 70 кг), кожные покровы бледные, тургор кожи снижен, больной вялый адинамичный. При лечении данного больного использовали излучатель GI(s) на область кишечника в течение 15 мин + GI «CT» 20 мин, GI(b)+KL(b) по схеме общего курса в течение 1 недели. Стул нормализовался после первого сеанса, после 5 сеанса повысилась работоспособность. Больной прошёл курс 2-х недельной терапии, наблюдение в течение года показало, что расстройства кишечника больше не возникали, больной прибавил в весе 14 кг.

Пример: Больной Д. 1960 г.р. поступил в клинику с диагнозом ожирение. При росте 164 см вес составлял 103 кг. В течение 1 месяца получал общий курс терапии ИК-излучателями, после чего стал отмечать снижение массы. Повторные курсы терапии не проводились, после вышеописанного лечения прошло больше 2-х лет. В настоящее время масса тела пациента составляет 72 кг (диету не соблюдает)

Следует учитывать, что многие токсины, в частности диоксин, являются жирорастворимыми. Поэтому при резком похудании наблюдается выброс в кровь токсинов, которые до этого находились в жировой ткани в неактивном состоянии. При потере жировой массы эти токсины переходят в плазму крови и дают сильно выраженный эффект интоксикации. Из этого следует, что процесс похудания должен происходить очень медленно, адекватно возможностям организма. Для быстрого вывода токсинов и их нейтрализации рекомендуется в процессе похудания принимать курс терапии излучателями RC+ZB.

14. Вы считаете Вашу работу вполне завершенной? Мы находимся только на начальном этапе. В действительности только работа ученых разных специальностей может дать значительный рывок, так как данная тематика находится на стыке химии, физики, материаловедения, молекулярной биологии и, конечно, медицины.

15. Что предоставляют собой установка для бытового использования? Основой для установок бытового назначения являются галогенные или осветительные лампы, покрытые функциональной керамикой. Мощность их обычно 5-40 Вт. Для лечения синуситов – это специальная маска. Для лечения аденом предстательной железы, миом, болезней мочеполовой системы – это специальная установка «СТ», оснащенная керамическими излучателями (фотография приводится в тексте). В некоторых случаях – это установки, размером с карманный фонарик.

16.Что представляют собой установки для профилактики инфекционных и воспалительных заболеваний? Это осветительная лампа, покрытая составом **GI**, которая устанавливается так, чтобы получить равномерное освещение помещения. Она может быть включена постоянно, когда люди находятся в помещении или, по мере необходимости. Для больших помещений используется несколько таких ламп или специальная установка, мощностью 100-600 Вт, позволяющая получить равномерное поле освещенности.

17. Как вы считаете, можно ли сочетать ИК-терапию с приемом лекарственных препаратов? В силу привычки, приобретенной в ходе

многолетнего опыта, у врачей часто возникает желание дать больному антибиотики для облегчения его состояния. При отсутствии резонансных ИК-излучателей такие действия оправданы, так как позволяют реально помочь больному, а во многих случаях и сохранить ему жизнь.

При лечении резонансными ИК-излучателями нет необходимости в применении антибиотиков, их использование может даже привести к определенным вредным последствиям.

Дело в том, что необходимые для нормального обмена пластические и энергетические материалы, витамины, питательные вещества, антибиотики и т. д. обеспечиваются нормальной микрофлорой кишечника. Изменение ее состава резко снижает иммунитет и способность сопротивляться внешним и внутренним дестабилизирующим факторам. Применение антибиотиков полностью изменяет состав микрофлоры, поэтому, желательно избегать их параллельного применения с методом лечения ИК-излучателями

Антибиотики (левомицетин, актиномицин Д и др.) и гормоны (метилтестостерон, прогестерон, преднизолон и др.) часто могут явиться причиной образования злокачественных опухолей. За время работы по методу ИК-терапии не было случая, когда положительного результата лечения нельзя было достигнуть без использования гормональных препаратов. Более того, больные, которые до нашего лечения принимали такие препараты, постепенно стали отказываться от них в связи с ненадобностью.

Приведем пример:

Больная З. 1982 г.р., поступила в клинику с диагнозом - дерматомиозит, полимиозит, акт II, стадия II. Из анамнеза: больна с марта 1996 г, когда впервые стала отмечать уплотнение кожи на лице, шее, руках, ногах, животе. В течение 1,5 лет получала гормональную терапию. Объективно отмечается уплотнение кожи на шее, руках, плечах, предплечьях, спине, животе, бедрах, икрах (больше справа и на разгибательных поверхностях). Вес больной составлял 84 кг. при росте 1 м 48 см.

Больная получала лечение излучателями: ZC(b) по 5-15 мин 2 раза в неделю, RC(b) по плавающей схеме + KL(b) по 15 мин ежедневно, GI(s) на область кишечника по 15-20 мин и область почек по 5 мин в течение 1 месяца, KL(s) на тимус и поджелудочную железу в течение 2 месяцев. В результате проведенной терапии уплотнение на коже исчезло, кожа стала нормально окрашена, тургор сохранен,

гормональные препараты пациентка принимать перестала, ее вес снизился до 60 кг. Лечение продолжалось в течение 3,5 мес.

Больной Д. поступил в клинику с диагнозом аллергический ринит. Из анамнеза: болен в течение 25 лет, неоднократно амбулаторно лечился (получал кеналог). Периоды ремиссии продолжались до 4 месяцев, затем сократились до 1 месяца и на момент поступления больного в клинику полностью прекратились. Больной был вынужден постоянно принимать препараты, способствующие улучшению носового дыхания (нафтизин, глазолин, санорин).

Лечение в нашей клинике продолжалось 2 недели. Больной прошел общий курс ИК-терапии, получал GI(s)+ZB(s) на желчный пузырь и надпочечники, GI(s) на область кишечника, ZB(s) на позвоночник с массажем. В результате лечения он отказался от медикаментозных препаратов, дыхание через нос стало свободным.

18. Можно ли также откататься от витаминов при лечении ИК-излучателями? В витаминах люди видят панацею от всех болезней. Они убеждены, что витамины – самое удобное оружие в борьбе против инфаркта, бессонницы, расшатанных нервов, артроза и даже рака. Настолько ли они полезны?

В последнее время медики забили тревогу. Финские ученые срочно прервали опыты с витаминами, которые проводились на добровольцах. Как оказалось, ни таблетки с бета-каротином, ни витамины А, С и Е не защитят нас от рака. Всемирная организация здравоохранения сегодня рекомендует не тратить деньги зря и не глотать витамины в качестве антиракового профилактического средства.

Для осуществления обменных процессов организму необходимо употреблять продукты в связанном состоянии. Это относится и к витаминам, так как они являются чрезвычайно активными веществами, с широким спектром действия на нашу ферментную систему. В пределах нормальных доз рафинированные витамины организм способен связать в комплексы и «держать про запас». Но если их дозы значительно превысят потребности, организм будет не в состоянии перевести избыточное количество в неактивное состояние, что вызовет явления гипервитаминоза. В природных соединениях большая часть витаминов уже находится в неактивной форме, поэтому порог, когда может начаться гипервитаминоз, находится значительно выше.

Искусственно произведенные витамины имеют далеко не те же свойства, что натуральные. Никто из ученых не сомневается, что витамины – важнейшая составная часть продуктов питания. Но факт остается фактом: витамины в таблетках дают отрицательные эффекты, которые практически не наблюдаются при приеме их в натуральных продуктах. Вероятнее всего это связано с тем, что растения содержат до 10000 различных веществ, которые оказывают ингибирующее действие на мгновенную активность витаминов.

Статистика свидетельствует, что в тех случаях, когда больные рахитом дети получали большие дозы витамина D, вместо выздоровления отмечалось усугубление их состояния.

Чем объяснить этот парадокс?

При назначении витамина D в нужном количестве нормальное соотношение солей кальция и фосфора восстанавливается, кальций накапливается в костях. Назначение витамина D в избыточном количестве приводит к выводу кальция из костей, и кости вновь размягчаются. Внешняя картина напоминает авитаминоз, но есть существенное отличие, т.к. при гипервитаминозе кальций не выводится из организма, а откладывается, правда не в костной ткани, а в почках, сердечной мышце, в стенках кровеносных сосудов и в тканях других внутренних органов. Поэтому, если своевременно не отменить введение витамина D, в костях и внутренних органах могут возникнуть необратимые поражения, вызванные декальцинацией костей и обызвествлением внутренних органов и тканей.

При гипервитаминозе А развивается состояние тяжелого отравления, которое сопровождается головной болью, выпадением волос, тошнотой и слабостью. Немецкие специалисты утверждают, что витамин А размягчает кости. Шведские медики установили, что его ежедневный прием даже в количестве 1,5 мг снизит плотность бедренной кости на 12%.

Едва ли можно найти человека, опасающегося избыточного потребления витамина С. Действительно ли он абсолютно безвреден, может ли вызвать реакции гипервитаминоза?

Вредное воздействие витамина С тесно связано с его ролью в физиологическом развитии. Дело в том, что в отличие от других витаминов он обладает широким спектром защитного действия на организм. От снабжения организма витамином С зависит активность многих ферментов: он оказывает непосредственное влияние на синтез коллагена – белка, который составляет подавляющую часть белков организма, на образование гормонов белковой природы и нуклеиновых кислот.

В норме, сколько бы ни вводить витамина С в организм, пусть это будут даже очень большие дозы, содержание его будет соответствовать именно оптимальной для данной ткани концентрации. Избыток витамина С разрушается и выбрасывается из организма. Однако, перестраиваясь на выброс излишка, организм и после перехода на нормальную дозу не сразу восстанавливает нормальный обмен этого витамина. Какое-то время усиленное разрушение и выброс продолжаются, и в результате наступает резкое обеднение всех тканей витамином С.

Гипервитаминоз С, подобно другим гипервитаминозам, переходит в гиповитаминоз, в результате которого патологические нарушения в организме развиваются с большой скоростью.

Гипервитаминоз С может сопровождаться бессонницей, повышенной раздражительностью, чувством беспокойства, учащенным сердцебиением. Если больные принимают барбитураты в сочетании с витамином С в дозе 0,5 грамм, появляются ощущение жара, головная боль, бессонница, нервное возбуждение, холодный пот.

Установлено, что избыток витамина С ухудшает обеспечение сердца энергетическими и пластическими материалами; избыток коллагена (в этом случае он синтезируется в больших количествах) способствует прогрессированию сосудистых заболеваний. Передозировка витамина С ведет к нарушению обмена веществ, в частности углеводного. Особенно сильно при этом страдают больные диабетом, так как он часто сопровождается ангиопатией.

Как оказалось, витамин С отрицательно действует и на ДНК. При ежедневном приеме 500 мг нарушается наследственность и даже возникает опасность заболевания раком. Применение витамина С в составе комбинированных минеральных таблеток, особенно если он попадает в организм с железом, равноценно применению яда. В присутствии ионов трехвалентного железа аскорбиновая кислота способна генерировать свободные гидроксильные радикалы, повышенный уровень содержания которых стимулирует мутагенные эффекты.

Известно, что нитриты, попадая в организм с пищей, взаимодействуют с соляной кислотой желудочного сока и превращаются в азотистую кислоту HNO_2, которая легко проникает в кровь и разносится по всему организму. Попав в клетки, эта кислота реагирует с нуклеопротеидами и образует их оксипроизводные. При этом в триплетах ДНК образуются дефекты, что является причиной нежелательных мутаций. Для нейтрализации вредного воздействия

нитритов в мясопродукты стали добавлять аскорбиновую кислоту. При этом образовывалась дегидроаскорбиновая кислота и к сожалению, немало промежуточных продуктов, в основном – свободных радикалов. Они столь похожи на витамин С, что клетка не распознает и заглатывает их, что приводит к значительному повреждению ткани. Следствием этого могут быть инфаркты, онкозаболевания и т.д.

Исследования последних лет показывают, что избыточное потребление (более 1000мг) витамина С способствует образованию почечных камней.

Большие дозы витамина B_1, особенно введенные парентерально, угнетают ферменты холинэстеразу и гистаминазу, что приводит к аллергии вплоть до анафилактического шока. Кстати, на этом же принципе работают отравляющие вещества нервно-паралитического действия.

Витамин B_6 в больших дозах может вызвать кожные высыпания и головокружение с судорогами, а при длительном введении - угнетение противосвертывающей системы крови. Витамин B_{12}, особенно в комплексе с витамином B_1, зачастую приводит к аллергическим реакциям, воспалению полости рта, полицетемии.

Необходимо различать натуральные витамины и синтетические. Не отличаясь по своему воздействию при потреблении в нормальных дозах, синтетические витамины при передозировке дают реакцию гипервитаминоза.

Из всего вышесказанного следует, что если в процессе лечения ИК-излучателями, полностью восстанавливаются процессы обмена, то достаточно наладить поступление натуральных витаминов с пищей. Если уж человек не может отказаться от приема синтетических витаминов, нужно очень внимательно следить за тем, чтобы не возникла их передозировка, независимо от метода применяемого лечения.

19. Какую роль в лечении заболеваний Вы отводите восстановлению нормальной микрофлоры кишечника? Одним из необходимых условий нормальной жизнедеятельности организма, является микрофлора кишечника, которая вырабатывает необходимые для организма человека витамины и ферменты, ее состав определяет состояние барьерной функции кишечника и активность выработки антител в пристеночных лимфоузлах. Изменение количественного и качественного состава микрофлоры кишечника, ее локализации может явиться причиной развития различных заболеваний (не только кишечника) и снижения иммунитета.

Опыт работы, в течение нескольких лет показал, что практически у всех без исключения больных, при различных патологических состояниях, а также после

применения химио- или лучевой терапии отмечалось нарушение микрофлоры кишечника, а следовательно, и его работы. Применение излучателя GI в таких случаях, позволяло восстановить работу кишечника после химиотерапии в течение 5-15 дней при ежедневной трехразовой обработке в течение 10 минут, а после лучевой – в течение 30-90 дней при тех же режимах обработки. У больных, не принимавших другие виды терапии удается полностью восстановить нормальную работу кишечника за 1-2 дня.

20. Можно ли при помощи Вашего метода вылечить псориаз? В процессе исследовательской и лечебной работы, мы имеем неплохие результаты лечения самых тяжелых форм псориаза. Нами установлено, что классификацию этого заболевания нужно вести по причинам его возникновения. Это могут быть: инфекция (бактериальная, микотическая, вирусная, простейшие микроорганизмы), токсины химического происхождения (пестициды, гербициды, диоксин, красители и т. д.), ионы тяжелых металлов, которые нарушают работу наших ферментов, нарушения кровообращения, баланса гормонов, функции эндокринных органов (надпочечников, поджелудочной железы и др.), микрофлоры кишечника, наличие микроорганизмов в желудке (например, campilo bact.). Сроки и вид лечения ИК-излучателями определяются типом псориаза или комбинацией выше перечисленных факторов.

Мы уверены, что никакие мази, кремы, воды Мертвого моря не излечивают псориаз, а лишь только скрывают внешние симптомы, не затрагивая причину болезни.

В нашу клинику поступил больной Н., 1982 г. р. с диагнозом - псориаз распространенная форма, прогрессирующее течение, смешанный тип. При поступлении были жалобы на высыпания по всему телу с сильным зудом, раздражительность, нарушения сна, аппетита. Из анамнеза: наряду с установлением диагноза аденоидные вегетации II степени в 4-х летнем возрасте, мальчику был выставлен диагноз псевдопсориаз. После оперативного удаления аденоид, исчезли и явления псевдопсориаза. С 1992 года заложенность носа стала опять беспокоить, был установлен диагноз - искривление носовой перегородки. В 1993 году появились пятна с шелушением на коже волосистой части головы размером с 5-ти копеечную монету. Больной в течение 2-х лет проходил лечение в кожном диспансере МСЧ Ж/Д, после проведенной терапии

отмечалась полная ремиссия заболевания. В 1996 году на волосистой части головы, на теле появились высыпания в виде бляшек, размеры которых варьировались от булавочной головки до 5-ти копеечной монеты. С 6 октября 1996 года больному было назначено лечение на аппарате "Салют". (Разработка АО Др. Фишера в Вадуце в сотрудничестве с учеными разных стран: прибор, производящий пульсирующий ток, который создает магнитное поле в системах применения. В процессе лечения (5-6-й сеанс) количество и размеры бляшек увеличились (в инструкции по применению прибора оговорена возможность обострения заболевания), процесс нарастал. Состояние усугублялось до ноября 1996 года. На фоне обострения псориаза 3 ноября 1996 года произведена подслизистая резекция носовой перегородки. Больной неоднократно лечился в Москве в ЦКВИ, принимал гормоны и цитостатики, лечился у народных целителей нетрадиционными методами. Улучшения не отмечалось, процесс постоянно прогрессировал.

При осмотре на коже верхней части головы, лица, туловища, руках и ногах отчетливо видны бляшки красного цвета, покрытые плоскими серебристыми чешуйками и сливающиеся между собой. Высыпания занимают 80% поверхности кожи. Ногтевые пластинки в виде наперстка (с мелкоточечными вдавлениями).

В течение 3-х месяцев больной получал терапию резонансными ИК-излучателями GI и KL. В результате после 10-ого сеанса отмечалась стабилизация процесса, полностью прекратился зуд. Через 1,5 месяца лицо, шея и спина практически очистились от элементов. К моменту прекращения лечения отмечалось полное очищение кожных покровов от патологических элементов.

Пациент наблюдается в течение 3-х лет врачами нашей клиники, рецидива заболевания не отмечалось.

Приводим фотографии больного в течение терапии и после ее окончания.



21. Что вы думаете о проблеме окислительного стресса и о применении кислорода в медицине, рассматривая эти процессы на молекулярном уровне? Стресс – естественная составная часть жизни, особое состояние организма, появляющееся у человека в результате отрицательного эмоционального воздействия, переедания, мышечных перегрузок, инфекций, чрезмерно низкой или, наоборот, слишком высокой температуры среды. Также его активно вызывают такие окислители как, озон, перекиси, парамагнитные производные кислорода.

Парадоксально, но и столь необходимый для жизнедеятельности кислород токсичен для любого организма. Животные не погибают от воздуха только благодаря сложным биохимическим механизмам защиты, которыми их снабдила природа. Эта защита не абсолютно надежна, мощность ее ограничена. Поэтому на Земле нет организмов, устойчивых в атмосфере, более насыщенной кислородом, чем воздух. В среде чистого кислорода любое млекопитающее погибает сравнительно быстро. Известны также анаэробные существа, прекращающие свой жизненный путь в атмосфере даже с очень небольшой концентрацией кислорода, такой, при которой “нормальный” организм гибнет от кислородного голодания. Не потому ли значительная часть долгожителей – уроженцы горных мест, где парциальное давление кислорода меньше, чем в низинах?

Химические связи в молекулах, как правило, формируются парами электронов, спины которых ориентированы противоположно друг другу. Кислород – исключение, его молекула включает пару электронов с параллельными спинами. Эта особенность запрещает ему вступать в типичные химические реакции с участием сразу двух электронов. В большинстве случаев такие превращения оказываются для него энергетически невыгодными – иначе

ни свободный кислород, ни органическое вещество в нынешних его формах не могли бы существовать. Однако «табу» не распространяется на реакции с переносом одного электрона. Захват его молекулой O_2 приводит к образованию супероксидного анионрадикала, с которого начинается цепь реакций, способствующих появлению свободных радикалов HO_2 •, HO •, а за ними – пероксида водорода H_2O_2. И к упоминавшимся мало приятным последствиям их превращений.

Органические материалы при контакте с кислородом подвергаются окислительной деструкции, в ходе которой образуются и другие, углеродсодержащие радикалы. Особенно быстро окисляются растительные и животные жиры. Даже при простом хранении на воздухе в них накапливаются пероксиды, гидропероксиды, эпоксиды, карбонильные соединения и другие небезвредные продукты. Есть основания предполагать, что такие окислительные превращения клеточных липидов могут иметь довольно серьезные последствия для организма.

В результате перекисного окисления липопротеидов в организме человека с течением времени накапливаются старческие пигменты – липофусцины (проявление этого – старческая “гречка” на коже). Чем старше человек, тем больше их откладывается в тканях его тела. И это несмотря на активную защиту ферментов – каталазы, глютатионпероксидазы, супероксиддисмутазы, предохраняющих клетку от свободных радикалов, которые могут привести к ее повреждению и даже гибели.

Возьмем, к примеру, только один вид клеток – эритроциты. Они живут всего 120 дней. К концу этого периода они становятся старыми, более чувствительными к пероксиду водорода и легко погибают. Неодинаковая восприимчивость эритроцитов разного возраста к окислению – не есть ли это признак, помогающий организму вовремя опознать состарившуюся клетку и заменить ее новой? И не происходит ли нечто подобное со старым, выполнившим свою жизненную программу животным? Если рассматривать его как клетку, входящую в состав суперорганизма, именуемого биологическим видом, то сравнение кажется не таким уж условным.

Опыты, выполненные на культурах тканей организма человека, показывают, что в атмосфере кислорода наиболее интенсивное пероксидное окисление, приводящее к накоплению старческих пигментов, происходит в тканях легких, сердца и почек. В миокарде, например, их количество за каждые 10 лет возрастает на 0,6% полного внутриклеточного объема. Эти же органы чаще всего оказываются вовлеченными в патологический процесс.

Наиболее распространенный внешний признак старости – сморщенная кожа – появляется в результате свободнорадикальной полимеризации входящего в ее состав белка эластина. А инициирует ее кислород. Неприятное действие кислорода проявляется при повышении его парциального давления даже в пределах одной атмосферы, не говоря уже о так называемых гипербарических дозах, которые сегодня широко используются в медицинских учреждениях многих стран.

В последние годы в некоторых странах усиленно рекламируется кислородотерапия (оксигенация) на дому, и это вызывает тревогу. Потому что даже очень хорошее лекарство при бесконтрольном применении может принести непоправимый вред.

Учитывая возможность пагубного влияния на организм повышенных концентраций кислорода, нужно быть осмотрительным в использовании гипербарических методов терапии. При этом замечено, что при гипербарической кислородотерапии, как и при слабом облучении, у некоторых пациентов развивается адаптация. Почему так получается, пока неизвестно, можно лишь предполагать, что под действием кислорода активируется синтез простогландинов (по свободнорадикальному механизму) и усиливается антимикробная защита через интерферон.

Окончательные выводы о причинах пониженной, а в других случаях, наоборот, повышенной восприимчивости организма к окислительному стрессу, можно будет делать лишь после того, как удастся разобраться в механизмах его возникновения на молекулярном уровне.

Своеобразная природа кислорода сказывается и в том, что стандартное для других молекул состояние, в котором все электроны спарены, так называемое синглетное, для него не устойчивое, пассивное, а, наоборот, активированное, агрессивное. Превратить обычный молекулярный кислород $^3O_2$ в активный $^1O_2$ можно с помощью света в присутствии сенсибилизаторов.

Повышенная активность $^1O_2$ связана с тем, что ему запрещены двухэлектронные реакции. Поэтому он может очень легко присоединиться к кратным связям органических молекул, таких, как липиды или каротиноиды. Поэтому наилучшим средством защиты от его действия может служить β-каротин, красящее вещество, содержащееся в моркови и кожуре спелых помидоров. Показано, что фоточувствительность организма может быть снижена простым способом – приёмом внутрь каротина. Этот метод считается самым эффективным при лечении различных, даже очень тяжелых порфирий (фотодинамических заболеваний).

Синглетный кислород может реагировать и с насыщенными молекулами, если они содержат сульфидные группы или остатки аммиака, в частности, с аминокислотами и белками. Мало того, его отрицательное воздействие резко усиливается так называемыми ксенобиотиками – веществами, попадающими в организм из окружающей среды. К ксенобиотикам относятся продукты сухой перегонки табака, этиловый спирт, некоторые хлорсодержащие соединения. Это обстоятельство – еще один аргумент против благодушного отношения к курению и употреблению алкоголя, которое продолжает сохраняться у многих несведущих людей.

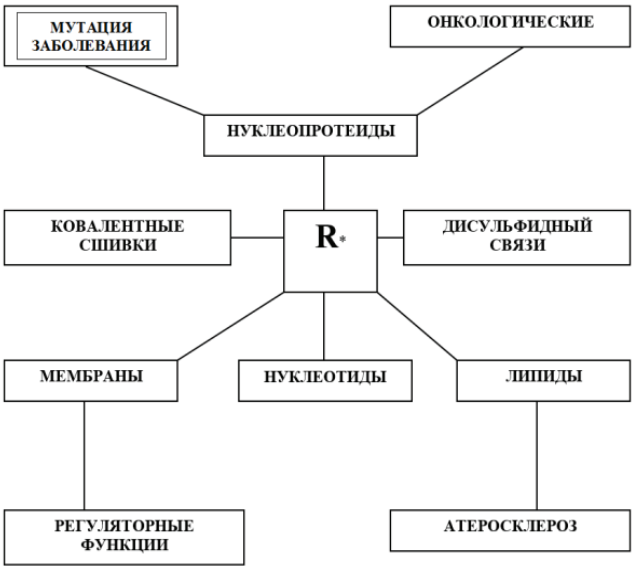
Обезвреживанием посторонних веществ, попавших в организм, занимаются клетки печени, почек и селезенки. Простейшей моделью происходящих при этом процессов, использующих, как правило, механизмы одноэлектронного окисления-восстановления, может служить реакция четыреххлористого углерода с первичными аминами. Первая ее стадия выглядит так:

$$CCl_4 + NH_2R \text{ ------- } [^{-}CCl_4...^{+}.NH_2R] \text{------ } .CCl_3 + Cl^{-} + {}^{+}.NH_2R$$

В результате появляется пара радикальных частиц: катионрадикал аминокислоты, одной из тех, что входят в состав белковых цепей, и трихлорметильный радикал. Судьба последнего развивается весьма многообразно. Частица может быть обезврежена силами ферментативной защиты, но в то же время может привести к образованию вредных продуктов, возникающих в результате заурядных химических реакций. Среди них – атомарный хлор, радикал $HO\bullet$ – тот же, который появляется в результате небезопасных трансформаций кислорода, и известные своей ядовитостью фосген, хлористый водород, окись углерода...

Так не в том ли состоит старение организма, что со временем слабеет, действует все медленнее ферментативная защитная механика и все большую роль начинают играть неуправляемые и разрушительные процессы?

Избыточное воздействие окислителей, в том числе воздуха, может способствовать возникновению легочных, сосудистых и других заболеваний. Если же учесть, что городской воздух содержит не только окислитель, но и продукты неполного сгорания топлива, соединения свинца и другие загрязнения, способные действовать как ксенобиотики, то напрашивается парадоксальный вывод: чем глубже мы дышим, тем быстрее стареем. Каждый из нас 25 тысяч раз в сутки подвергается непосредственному контакту с этим воздухом всею поверхностью своих легких, а она составляет около 80 м^2.



Процессы дыхания и энергообмена, несмотря на их зависимость от множества факторов, находятся под контролем гормональных систем организма и нервной системы. В первую очередь следует вспомнить о гормонах щитовидной железы – тироксине и трийодтиронине. Известно, что больные с гиперфункцией щитовидной железы (тиреотоксикозом) потребляют в полтора раза больше кислорода, чем здоровые. И напротив, при гипофункции железы (микседеме) потребление кислорода резко снижено.

Но гормоны щитовидной железы – далеко не единственные компоненты эндокринной системы, влияющие на газообмен и утилизацию кислорода. Весьма стимулирующе воздействуют на эти процессы гормон гомеостаза норадреналин, а также гистамин, глюкагон, соматотропный гормон гипофиза (СТГ) и мужской половой гормон – тестостерон. «Гормон тревоги» адреналин и другие стрессорные гормоны – адренокортикотропный гормон (АКТГ), кортизол, кортикостерон, альдостерон, наоборот, резко подавляют утилизацию кислорода и снижают МПК у человека и животных. По-видимому, здесь следует говорить не о локальном действии того или иного вещества, а о целой сложно организованной системе гормональных регуляторов, в свою очередь находящихся под контролем центральной нервной системы.

Эту точку зрения сформулировал и обосновал исследователь из Всесоюзного НИИ физической культуры В. С. Горожанин. Он классифицировал всех людей (независимо от физической тренированности и состояния здоровья) на два полярных типа. Первый – аэроб, реагирующий на продолжительные физические нагрузки резким увеличением «гормона гомеостаза» норадреналина, повышением секреции соматотропного (СТГ) и тиреотропного гормона (ТТГ), тестостерона, глюкагона и т.д. Такому человеку нужно много кислорода, и у него высокий уровень МПК. У второго типа – анаэроба – в ответ

на нагрузки значительно увеличивается концентрация в крови «гормона тревоги» адреналина и уровень всех стрессорных гормонов – АКТГ,  -эндорфина, кортизола, альдостерона. В крови таких людей быстро накапливается лактат, резко увеличивается ЧСС, и падает МПК.

Ни тот, ни другой тип нельзя назвать ни плохим, ни хорошим. Каждому из них соответствует свой характер активности нервной системы. Аэробы – обычно малочувствительные личности – «гипосенсоры»; анаэробы, напротив, как правило, тревожные, чувствительные – «гиперсенсоры». К аэробам относятся спортсмены, вид спорта которых требует выносливости, а также больные бронхиальной астмой, аллергией, тиреотоксикозом, к анаэробам – спринтеры, штангисты и больные, страдающие неврозами, гипертонией, ожирением, атеросклерозом.

22. Какой механизм лечения вирусных заболеваний вашим методом? Механизм лечения вирусных заболеваний по нашему методу заключается в следующем. Любой вирус размножается за счет своего основного фермента, который в момент размножения образует ферментсубстратный комплекс, представляющий из себя радикал. Излучатели RC или RV рекомбинируют этот радикал, как это было описано в лечение онкозаболеваний. Таким образом, мы получаем стабильную молекулу из ферментсубстратного комплекса, которая уже не способна к дальнейшему росту. Таким образом, вирус погибает необратимо. Можно сказать, что только наш метод позволяет надежно убить любой вирус. Вакцинация эффективна только на конкретный вирус и малейшие его изменения приводят к тому, что вакцина перестает работать.

23. Как Вы относитесь к применению в медицине ультрафиолетового облучения? УФ облучение вызывает образование радикалов с высокой энергией активации, эффекты будут такие же, как и при применении гипербарических концентраций кислорода. Кроме того, УФ способствует продуцированию сильнейшего окислителя - озона. Так что, окислительный стресс в присутствии УФ обеспечивается автоматически.

Следует сказать о том, что мы используем инфракрасное излучение, без которого невозможна жизнь. Длина волны нашего собственного излучения - 9,36 микрон. Как известно, квантовая энергия излучения обратно пропорциональна длине волны. Диапазон УФ находится в пределах 0,18 - 0,4 микрон. Следовательно, квантовая энергия этого излучения может превышать в 50 раз нашу собственную. Это равноценно воздействию бомбы на наши клетки. Наша ферментная система в определенных пределах может противостоять УФ. Опять же это зависит от того, в чистом ли виде используется УФ, или в сочетании

с другими областями спектра. Природный спектр излучения (Солнце) имеет и ИК-диапазон, который способствует активации, в какой-то мере, наших защитных сил, за счет нормализации скоростей фотохимических реакций. Поэтому природный солнечный свет, который содержит и УФ-излучение, не оказывает такого пагубного влияния на организм, как УФ-облучение получаемое искусственно в чистом виде, т.к. кварцевые, ртутные или ксеноновые лампы не имеют ИК-части спектра излучения.

24. Какова природа сахарного диабета? Поддается ли он лечению методом резонансной терапии? Причиной сахарного диабета второго типа часто является не само поражение поджелудочной железы или недостаток инсулина (в 99% случаев). Он возникает в связи с тем, что наша нервная система и мозг могут работать только на глюкозе. Следовательно, организму при заболеваниях требуется больше глюкозы, так как, в первую очередь увеличивается нагрузка на мозг и нервную систему, которые не только "следят" за всеми процессами организма, но именно они управляют синтезом необходимых для нормального существования и борьбы с патологическими факторами ферментов, гормонов и т.д. Таким образом, устранение причины заболевания автоматически приводит и к нормализации уровня глюкозы в крови. Если же мы будем давать сахароснижающие препараты, то организм в противодействие им будет еще больше увеличивать уровень глюкозы (за счет глюконеогенеза), что приведет к рефлекторному повышению и уровня инсулина. Именно такую картину мы и наблюдаем придиабете второго типа. Последствия диабета также излечиваются ИК-терапией. Например, ангиопатия и другие связанные с микроциркуляцией крови (ретинопатия, дибетическая рожа, трофические язвы и др.) могут быть излечены, практически только этим методом, так как излучатели серии Z переводят патологический коллаген в желатин. Лечение лекарственными препаратами в этом случае малоэффективно, так как лекарства доставляются, практически, кровью, а она не имеет возможности нормально циркулировать именно в пораженных зонах.

25. Позволяет ли ИК -терапия лечить аденомы предстательной железы? Существующие на сегодняшний день методы лечения аденомы предстательной железы обладают рядом недостатков и не всегда во всем удовлетворяют практических врачей. А потому разработка новых, менее травматических, экономически обоснованных, более результативных методов лечения не потеряла своей актуальности. Этим и обосновано использование метода резонансной терапии узкоспектральными ИК-излучателями в лечении аденомы предстательной железы. Дело в том, что при ряде заболеваний организму для

обеспечения нормального обмена веществ требуется больше гормонов, в том числе и гормонов предстательной железы. Чтобы обеспечить необходимое количество гормонов, предстательная железа повышает свои функции, а в дальнейщем и увеличивается в размерах. Эта дополнительная часть железы и является аденомой. Операция в таких случаях резко снижает сопротивляемость организма, так как дополнительные гормоны способствовали защите организма, а удаление аденомы лишает организм такой "подпитки". Устранение причины заболевания во всех случаях приводило к восстановлению нормальных размеров предстательной железы.

Можно сказать, что аденома предстательной железы полностью излечивается в сроки от 5 дней до 1 месяца. Симптом снимается излучателем KL/ZB, практически, после нескольких воздействий.

Проведено лечение большого числа больных различного возраста и все успешно. Вышеперечисленное, позволяет рекомендовать метод резонансной терапии узкоспектральными инфракрасными излучателями для лечения аденом предстательной железы.

Приводим ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по конкретным заболеваниям.

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО АДНЕКСИТА

Этиологическими факторами возникновения аднексита являются: анаэробы, дрожжевые грибки, клостридии, коринебактерии, энтерококки, эшерихии, клебсиелы, микоплазмы, гонококки, протей, риккетсии, сальмонеллы, стафилококки, стрептококки, микобактерии туберкулеза и т.д. Необходимо учитывать, что многие возбудители стали нечувствительными к применяемым антибиотикам. Лечение хронических аднекситов становится серьезной проблемой, тем актуальней, чем больше людей страдают аллергическими реакциями на прием медикаментов. Поэтому большой интерес представляет использование в лечении хронических аднекситов безмедикаментозного метода терапии узкоспектральными керамическими излучателями.

В НМЦ "Kamolot-Salomatlik" проводилось лечение больных хроническим аднекситом узкоспектральными керамическими излучателями без применения медикаментозной терапии. Под наблюдением находилось 19 женщин, возраст которых колебался от 18 до 35 лет, с давностью заболевания от 2 до 5 лет. Все больные ранее неоднократно получали антибактериальную и противовоспалительную терапию, но эффект от лечения был недостаточно

продолжительным. У всех больных рецидив заболевания наступал не реже 3 раз в год.

Ведущей жалобой всех больных была боль различной (чаще значительной) интенсивности в нижних отделах живота с иррадиацией в пояснично-крестцовую, гипогастральную области, нижние конечности и наружные половые органы. На обильные бели жаловались 80% женщин. Нарушение менструального цикла по типу альгодисменореи было у 93,3% женщин, гиперполименореи у 11% женщин, задержка менструаций от 3 недель до 3 месяцев у 26% женщин.

Воздействие ИК излучателями было направлено на уничтожение микроорганизмов (GI), грибов (AF), вирусов (RC и RV), улучшение микроциркуляции в маточных трубах и яичниках (ZB) и рассасывание патологической соединительной ткани. Всем больным проводилась иммуностимулирующая терапия (KL), санация очагов хронической инфекции (миндалины, кишечник, почки (RC, GI, AF)), стимуляция органов, отвечающих за адаптационные возможности организма (надпочечники, поджелудочная железа, печень (GI, KL, ZB)), регуляция симпатического и парасимпатического отделов ЦНС (KL/KH).

Комплексное лечение излучателями в среднем составило 5 недель. Исчезновение боли было отмечено через 7-9 процедур у 100% больных, значительное уменьшение количества белей через 10-15 процедур у 76,9% больных, очередные менструации у всех больных с альгодисменореей прошли со значительным уменьшением болей или вообще безболезненно. У больных, отмечавших задержку менструаций на 3 недели - 3 месяца, очередные менструации начались с задержкой на 5-7 дней. Больные, ранее жаловавшиеся на гиперполименорею, отмечали умеренную кровопотерю в течение 5-6 дней. На УЗИ яичников после проведенного нами лечения у 79% больных отсутствовали признаки эхопатологии; 16% имели улучшение, 5% без изменений (больная прекратила лечение через одну неделю, что явилось недостаточным сроком для ликвидации хронического процесса). При наблюдении за больными в течение двух месяцев рецидивов заболевания не отмечалось. Таким образом, полученные данные показали, что метод терапии узкоспектральными инфракрасными излучателями представляет собой высокоэффективное средство лечения и вторичной профилактики обострения хронического аднексита.

ОЦЕНКА ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ

Выбор иммунотропных препаратов до настоящего времени весьма ограничен. В последней наиболее полной монографии, посвященной этому вопросу, рассмотрено всего 20 препаратов. Причем многие из них получены из чужеродных биологических систем (препараты тимуса и др.), поэтому они могут вызывать сенсибилизацию организма при их длительном применении. В связи с этим ведется поиск новых методов лечения вторичных иммунодефицитных состояний, развивающихся при воспалительных заболеваниях, в том числе при остром бронхите. В последнее время стали уделять много внимания разработке и изучению эффективности физических методов стимуляции иммунитета. С этой целью используется ультразвук, СВЧ, лазер и др. (А.Ф. Накау 1988, Ш.Н. Ибрагимов 1995 и др.). Однако, применение лазеро- и ультразвуковой терапии при различных патологических процессах сопряжено с жестким воздействием на клетки очень высокой квантовой энергии, при котором разрушаются окружающие нормальные клетки и ткани. Предложенное нами узкоспектральное ИК-излучение, в отличие от других физических факторов, оказывает мягкое терапевтическое воздействие на различные патологические процессы, а также обладает иммуностимулирующим действием.

В связи с этим мы решили оценить эффективность применения ИК-излучения в целях иммуностимуляции при острых бронхитах у детей раннего возраста.

Под нашим наблюдением находились 68 больных с острым бронхитом. I - группу (контрольную) составили 30 больных, которым назначалась традиционная терапия; II- группу составили 38 больных, получавших в комплексе с традиционной терапией ИК-излучение. Воздействие узкоспектральным инфракрасным иммуностимулирующим излучателем проводилось в течение 5 - 10 минут, облучению подвергались иммуноактивная зона тимусгрудина. Процедуру начинали на второй - третий день лечения на высоте респираторных расстройств, курс лечения составлял в среднем 5 - 6 дней, ни в одном из случаев осложнений не наблюдалось.

Анализируя влияние узкоспектрального ИК-излучения на показатели иммунной системы у больных с острым бронхитом, хотелось бы отметить мягкую стимуляцию клеточного иммунитета, доказательством чего являются следующие моменты. Так, если в контрольной группе было выявлено незначительное нарастание общего пула Т-лимфоцитов 47,5 % (1,7 + 0,1 тыс/мкл

P< 0,05), то, у исследуемой группы пациентов абсолютное и относительное содержание Т-лимфоцитов увеличилось в большей степени 54,1+3,5% (2,2+0,27 тыс/мкл P1<0,01). Количество Т-хелперов в периоде выздоровления повышалось и имело тенденцию к нормализации, однако значительных различий между сравниваемыми группами не было, а количество Т-супрессоров имело тенденцию к достоверному повышению по сравнению с исходными данными и I группой (P1<0,05).

Полученные данные свидетельствуют о том, что применение узкоспектрального ИК-излучения в комплексном лечении бронхита способствует не только повышению общего числа Т-лимфоцитов, но и нормализации их субпопуляций.

При оценке В-системы иммунитета, было установлено, что после лечения в обеих группах нормализуется количество В-лимфоцитов. Однако увеличение абсолютного количества В-лимфоцитов было больше в группе больных, которым проводилось ИК-воздействие - 0,47+0,02 тыс/мкл, в то время как в контрольной группе количество В-лимфоцитов составляло - 0,42+0,03 тыс/мкл.

Сравнение показателей сывороточных иммуноглобулинов в зависимости от лечения показало, что в группе больных, которым проводилось ИК-воздействие в комплексе с общепринятой терапией, уменьшились явления дисиммуноглобулинемии, содержание IgA и IgC после лечения изменилось в сторону повышения (P<0,01), что еще раз свидетельствует об иммуностимулирующем действии узкоспектрального ИК-излучения. Содержание IgM уменьшилось, по сравнению с контрольной группой детей получавших общепринятую терапию и имело тенденцию к нормализации, что указывает на стихание воспалительного процесса в бронхолегочной системе под влиянием ИК-излучения.

Применение узкоспектрального ИК-излучения также оказывало благоприятное влияние на число фагоцитов, при этом их количество (50,3+2,6%) у исследуемой группы приближалось к показателям здоровых детей. Абсолютное количество фагоцитов при выписке даже превышало показатели здоровых детей 2,2+0,17 тыс/мкл и 2,03+0,5 тыс/мкл соответственно.

Наряду с этим, применение узкоспектрального ИК-излучения у больных с острым бронхитом способствовало снижению уровня сенсибилизации к ткани легкого, - то есть снижению количества антиген связывающих лимфоцитов (АСЛ). Так после ИК-терапии содержание АСЛ составило 3,5+0,1%, тогда как у контрольной группы этот показатель составил 4,4+0,3%.

Следовательно, сравнительная оценка иммунологической эффективности этих методов показала, что применение ИК-излучения в комплексной терапии имеет преимущество перед традиционными способами, так как при этом происходит более полное восстановление иммунитета. Воздействие ИК-излучением на иммуноактивную зону тимус - грудина при остром бронхите оказывает стимулирующее влияние на клеточный и гуморальный иммунитет.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРИНЦИПЫ ИХ ЛЕЧЕНИЯ ДАЛЬНИМ УЗКОСПЕКТРАЛЬНЫМ ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Со времен Гиппократа известно, что одно и тоже заболевание имеет свои особенности у разных групп больных. Разнообразие в клинических проявлениях заболевания обусловлено различием в вызывающих его причинах, а также состоянием системы управления организма и требует дифференцированного подхода к терапии.

Сегодня мы можем назвать следующие основные причины, приводящие к развитию патологических процессов - это инфекции (бактериальная, вирусная, микотическая), токсины органической и неорганической природы, соли тяжелых металлов, нарушение микроциркуляции, микрофлоры кишечника, липидного обмена, сбой в аппарате управления (гипоталамус, гипофиз), травмы, отягощенная наследственность. При этом перечисленные причины могут быть как первичными, так и возникать в результате воздействия одного из перечисленных факторов.

Состояние системы управления влияет на продолжительность прямой и обратной реакции в ответ на раздражитель и определяется наследственными факторами, но время реакции организма на раздражитель и период восстановления может удлиняться под воздействием вышеуказанных причин и приводить к сбою в работе. Исходом этих нарушений может быть дисбаланс отделов вегетативной нервной системы, нарушение в гипофизарно-надпочечниковой системе, снижение синтеза глюкокортикоидов, развитие аутоиммунного процесса.

В соответствии с указанными причинами возникновения заболеваний схема лечения должна включать следующие мероприятия:

1. Удаление инфекции. Однако применение антибиотиков способствует нарушению микрофлоры кишечника, что может способствовать отягощению заболевания. Поэтому считаем целесообразнее применение

ИК излучателей, оказывающих противовирусное, антимикробное и антигрибковое действие.

2. Активизация функциональной активности надпочечников, с целью повышения содержания свободных глюкокортикоидов.
3. Нормализация микрофлоры кишечника. Для этого проводится воздействие ИК-излучением на область кишечника.
4. Нормализация баланса между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы, состояния гипоталамуса, гипофиза.
5. Нормализация липидного обмена.
6. Активизация функциональной активности поджелудочной железы. Необходимость этой процедуры объясняется тем, что у больного человека основной энергетический путь обмена - гликолитический, требующий большего количества глюкозы и соответственно инсулина.
7. Нормализация микроциркуляции и кровотока.

Разные типы узкоспектрального излучения позволяют оказывать воздействие на все перечисленные процессы. Последовательность проведения процедур, продолжительность воздействия ИК-излучения индивидуальна и зависит от причины заболевания, а также от состояния больного. Для оценки состояния больного помимо общемедицинских методов можно использовать электроакупунктуру Р.Фолля.

Способ рекомбинации свободных радикалов

С повышением уровня свободных радикалов связан патогенез таких заболеваний как атеросклероз, инфаркт миокарда, язвенная болезнь желудка. В рекомбинации свободных радикалов принимают активное участие антиоксидантные факторы защиты организма. Под воздействием ряда причин антиоксидантные факторы защиты не срабатывают, что приводит к росту уровня свободных радикалов и отягощению течения патологического процесса. Особенно актуальна эта проблема для больных злокачественными новообразованиями, так как уровень энергии активации образовавшихся свободных радикалов очень высок. Для их рекомбинации возможно использование узкоспектрального инфракрасного излучателя. Излучатель испускает два последовательных импульса. Первый имеет необходимую энергию для образования активного радикала из ионизированной воды. Второй заставляет активный радикал образовавшийся из воды соединиться с

радикалом дегенеративно измененной клетки, а также приводит к рекомбинации радикалов, образовавшихся из воды.

В результате воздействия излучателя образуется стабильная система, позволяющая остановить развитие патологического процесса.

Принцип лечения больных с нарушениями микроциркуляции и кровотока

Развитие любого патологического процесса сопровождается изменением микроциркуляции. Нарушение микроциркуляции может быть первичным, т.е. в результате воздействия какого-либо патогенного фактора происходит поражение непосредственно сосудов, и уже затем в результате нарушения кровоснабжения органа происходит нарушение его функции.

При вторичном поражении сосудов воздействие патогенного фактора оказывается непосредственно на клетки какого-либо органа. Организм в ответ на раздражение, для ограничения воздействия отрицательных факторов, отвечает спазмом сосудов, изменением проницаемости сосудистой стенки, которые могут сохраняться продолжительное время и приводить к нарушению кровоснабжения органа и отягощать течение заболевания. Нарушение кровоснабжения органов и самих сосудов может быть обусловлено также отложением чужеродных веществ на самих стенках сосудов.

Восстановление микроциркуляции является ключом к успеху в лечении многих заболеваний. Для нормализации микроциркуляции и кровотока возможно использование узкоспектрального инфракрасного излучения.

Воздействие излучения на организм позволяет нормализовать микроциркуляцию и восстановить кровоток в сосудах за счет изменения реологических свойств крови, а также за счет рассасывания патологических отложений на стенках сосудов.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

Нарушение липидного обмена зависит не только и не столько от уровня холестерина в крови, сколько от соотношения липопротеидов высокой и низкой плотности, в состав которых входит холестерин.

Холестерин является одним из наиболее важных химических соединений организма. Он является составной частью клеточных мембран (40% состава

мембраны занимает холестерин). Из него синтезируются глюкокортикоиды, гормоны, выполняющие основную противовоспалительную функцию.

Именно в составе липопротеидного комплекса происходит переход холестерина в ток крови и обратно. Смещение баланса липопротеидов является причиной изменения концентрации холестерина в крови, что может привести к возникновению различных заболеваний. Повышение уровня липопротеидов низкой плотности приводит к нарушению вывода холестерина из крови, что способствует развитию таких заболеваний как атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, желчекаменная болезнь. Снижение уровня липопротеидов низкой плотности и увеличение высокой плотности приводит к повышенному выводу холестерина из тока крови, а это является предпосылкой для развития надпочечниковой недостаточности, гипотиреоза, истощения нервной системы, кахексии.

Использование узкоспектрального ИК-излучения на область желчного пузыря, способствует кратковременной диссоциации липопротеидных комплексов, и в соответствии с законом действия масс - к нормализации их баланса.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Клинические проявления воспалительных заболеваний весьма разнообразны, но общим для них является процесс воспаления. Воспаление является защитной реакцией организма, возникающей в ответ на внедрение патогенного агента. Для него характерны свои закономерности, как в развитии и течении, так и в прогрессировании и исходе.

В норме, при внедрении инфекции организм включает механизмы, способствующие удалению патогенного фактора, а для подавления процессов воспаления происходит увеличение выработки и диссоциации глюкокортикоидов. Как правило, заболевают лица, у которых эти механизмы не работают или являются недостаточными.

Нормализация этих процессов возможна при воздействии на организм узкоспектрального инфракрасного излучения. Применение для лечения разных типов узкоспектрального ИК-излучения позволяет не только прервать процессы размножения микробов, вирусов, грибков, исключая возможность адаптации микроорганизма к данному виду воздействия, но и проводить процедуры, направленные на повышение адаптационных возможностей организма. Выбор

типа излучения определяется при помощи электроакупунктурной диагностики по методу Р.Фолля.

При воздействии на очаг воспаления учитывается его стадия. В стадии альтерации рекомендуется применение излучателя оказывающего противовоспалительный эффект, в стадии экссудации - излучателя, уменьшающего эксудацию; в стадии пролиферации - одновременное использование излучателей с противовоспалительным эффектом и оказывающим рассасывающий эффект.

С целью повышения уровня свободных глюкокортикоидов, также способствующих уменьшению процессов экссудации и нормализации микроциркуляции проводится активизация функциональной активности надпочечников.

Как было указано, заболевания возникают у лиц со сниженной резистентностью организма, которая может быть обусловлена имеющимися хроническими очагами инфекции в других органах, нарушениями микроциркуляции, микрофлоры кишечника. Поэтому при лечении необходимо применение излучателей, способствующих устранению имеющихся нарушений.

Принципы лечения воспалительных заболеваний носоглотки

Воспалительные заболевания носоглотки являются одной из наиболее часто встречающихся патологий в практике врача. Они могут вызывать тяжелые осложнения, вести к возникновению и ухудшению течения многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы, системных заболеваний соединительной ткани.

Причинами воспалительных заболеваний носоглотки могут быть различные бактерии и вирусы. Как и многие другие заболевания воспалительные процессы в области носоглотки, особенно при их хроническом течении, развиваются на фоне иммунологических нарушений. Причиной снижения иммунитета могут быть хронические очаги инфекции в других органах, нарушение микрофлоры кишечника, связанное с неправильным питанием или частым приемом антибиотиков, первичные нарушения микроциркуляции, вызванные различными факторами, нарушение баланса отделов вегетативной нервной системы, снижение функциональной активности надпочечников, поджелудочной железы.

Учитывая вышеизложенное при лечении узкоспектральными ИК-излучателями необходимо в первую очередь проводить лечебные процедуры,

направленные на повышение иммунитета и удаление инфекции. При проведении лечебных процедур в области носоглотки учитывается стадия заболевания. В начальных стадиях, когда в области носоглотки имеются только явления воспаления назначаются излучатели обладающие противомикробным и противовирусным действием (для удаления инфекции), при развитии атрофических процессов, сопровождающихся поражением сосудов и нарушением микроциркуляции, одновременно используются антимикробные или противовирусные излучатели и нормализующие микроциркуляцию.

Принципы лечения бронхитов

Причиной развития бронхита являются различные бактерии, вирусы. Такие факторы, как отягощенность организма различными токсинами органической и неорганической природы, нарушение микрофлоры кишечника и поражения сосудов способствуют снижению резистентности организма, имеющей решающее значение в восприимчивости к инфекциям.

Течение бронхита, особенно хроническое, характеризуется снижением уровня свободных глюкокортикоидов за счет снижения функциональной активности надпочечников. Морфологические изменения бронхов характеризуются гиперемией и отеком слизистой оболочки. При тяжелых и хронических течениях заболевания процесс захватывает более глубокие слои бронхов с поражением сосудов.

При лечении узкоспектральным ИК-излучением в комплекс мероприятий включаются процедуры направленные на удаление инфекции и восстановление иммунитета. Для улучшения состояния иммунитета проводится нормализация баланса отделов вегетативной нервной системы (через воздействие на гипоталамус, гипофиз), микроциркуляции и кровотока в сосудах в целом, микрофлоры кишечника, активизация функциональной активности надпочечников и поджелудочной железы.

При бронхитах, характеризующихся наличием воспалительного процесса, применяются излучатели оказывающие противовоспалительный эффект, при наличии атрофии и поражения сосудов - рекомендуется одновременное применение эмиттеров, оказывающих противовоспалительный и рассасывающий эффект, а также нормализующих состояние микроциркуляции.

Более быстрому восстановлению организма также способствует выполнение комплекса специальных упражнений.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИЙ

Пневмония является полиэтиологическим заболеванием, возникающим вследствие воздействия на легочную ткань различных бактерий, вирусов, грибков. В возникновении острых пневмоний важную роль играют вирусно-бактериальные ассоциации. Химические токсины и неблагоприятные физические агенты, как этиологические факторы, обычно сочетаются с инфекционными. Пневмония могут развиться как проявление системного заболевания.

Важную роль в патогенезе пневмонии играют нарушения разнообразных защитных механизмов бронхолегочной системы, а также состояние тканевого и гуморального иммунитета организма, на которое оказывают влияние интоксикация, нарушение микрофлоры кишечника и микроциркуляции.

При лечении острых пневмоний узкоспектральными инфракрасными излучателями применяются эмиттеры, оказывающие антибактериальный, противовирусный и антимикотический эффект. Одновременно проводятся мероприятия направленные на повышение иммунитета, нормализацию баланса отделов вегетативной нервной системы, активизацию функциональной активности надпочечников, поджелудочной железы. На область легких назначаются излучатели, оказывающие противовоспалительный эффект.

Развитие хронической пневмонии происходит на фоне иммунологических нарушений, вследствие неразрешившейся острой пневмонии - в результате замедления или прекращения резорбции экссудата в альвеолах и формирования пневмосклероза и поражения сосудов.

При лечении хронической пневмонии в первую очередь проводят мероприятия, направленные на восстановление иммунитета, нормализацию баланса вегетативной нервной системы, восстановление микрофлоры кишечника и микроциркуляции, стимуляцию функциональной активности надпочечников и поджелудочной железы. На область легких наряду с излучателями, оказывающими противомикробное, противовирусное действие назначаются излучатели, обладающие рассасывающим действием и нормализующие микроциркуляцию.

Выбор излучателей и последовательность их применения строго индивидуальны, определяются с помощью электроакупунктурной диагностики по методу Р.Фолля.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ НЕВРАЛГИЙ

Воспаление нервов различной локализации часто возникает в результате переохлаждения, внедрения различной инфекции, чаще всего вирусной природы. Развивается заболевание, как правило, на фоне сниженной резистентности организма, причинами которой является сбой в работе системы управления, из-за отягощенности организма различной инфекцией, токсинами, солями тяжелых металлов. Интоксикация организма может быть и при нарушении микрофлоры кишечника, микроциркуляции.

В связи с вышесказанным лечение должно включать мероприятия направленные не только на удаление инфекции из очага поражения, но и санацию очагов хронической инфекции в других органах. Одновременно необходимо проводить процедуры направленные на повышение иммунитета, нормализацию баланса отделов вегетативной нервной системы, стимуляцию функциональной активности надпочечников. Для поддержания гликолитического пути энергообмена рекомендуется стимуляция функциональной активности поджелудочной железы.

Все указанные мероприятия возможно провести при применении различных типов узкоспектральных инфракрасных излучателей.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

Нами разработан новый метод лечения вирусных заболеваний. Метод прошел апробацию в Германии, Малайзии, Южной Корее, Эстонии, Грузии, Узбекистане, России. Он основан на следующих принципах.

Как известно, вирус представляет собой ДНК или РНК с соответствующим ферментом, который обеспечивает его репродукцию. Процесс репродукции происходит путем образования фермент-субстратного комплекса, который, в действительности, является радикалом. Наш метод основан на том, что специальный излучатель испускает два последовательных импульса за очень короткое время - в миллионные доли секунды. Первый дает необходимую энергию активации для создания активного радикала, необходимого для связывания растущего радикала в устойчивую молекулу, неспособную к дальнейшему росту. Второй импульс заставляет активный радикал вируса

(фермент-субстратный комплекс) соединиться с образовавшимся радикалом и, таким образом, прекратить рост ДНК или РНК вируса.

Первый импульс длится 10 888мкс, при плотности энергии 320 Вт на $см^2$.

Первый импульс:

HOOH->2HO·

LOOH->LO·+OH·

Второй импульс:

R·+HO·->ROH

R·+LO·->LOR

2HO·->HOOH

LO·+OH·->LOOH

Где R· - фермент-субстратный комплекс вируса.

В результате воздействия этих излучений образуется химически стабильная система, позволяющая остановить развитие процесса. Имеются и другие излучатели, которые позволяют нормализовать микроциркуляцию, укрепить иммунную систему, уничтожить патогенную инфекцию, нормализовать микрофлору кишечника и т. д.

Таким образом, этот метод позволяет излечивать все виды вирусных инфекций, независимо от их разновидностей. Метод апробирован на всех видах гриппа, гепатитов, СПИДа, цитамегаловирусе, герпесах и во всех случаях показал высочайшую эффективность.

Увеличение числа случаев тяжелых осложнений после перенесенных острых вирусных инфекций, свидетельствует о недостаточной эффективности существующих методов терапии этих заболеваний. Возможно это связано, с тем что имеющиеся схемы лечения не учитывают состояние всех органов и систем, вовлеченных в патологический процесс.

Известно, что тяжесть заболевания зависит от резистентности организма, которая определяется состоянием иммунной системы, микрофлоры кишечника, наличием очагов хронической инфекции, функциональной активностью надпочечников. Поэтому при лечении любого заболевания, в том числе и вирусной инфекции, необходимо проводить коррекцию имеющихся нарушений.

Нами для лечения больных с острыми вирусными заболеваниями предлагаются разные типы узкоспектральных инфракрасных излучателей, позволяющих оказывать воздействие на патологические процессы, с которыми излучение находится в резонансе. Они обладают противовирусным, антибактериальным эффектом, оказывают нормализующее действие на

состояние микрофлоры кишечника, микроциркуляции, на баланс отделов вегетативной нервной системы, стимулируют функциональную активность надпочечников и поджелудочной железы. Излучатели не оказывают отрицательного воздействия на организм, так как длина волны их излучения ниже излучения человеческого организма.

Выбор типа излучателя и органов, вовлеченных в патологический процесс, проводится с помощью метода электроакупунктурной диагностики по Р.Фоллю.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Причиной развития язв желудка и двенадцатиперстной кишки являются некоторые виды бактерий, но основной причиной их возникновения является развитие нарушений нервных и гуморальных факторов, регулирующих секреторно-трофические процессы в гастродуоденальной области.

"Сбой " в системе управления может быть обусловлен стрессами или интоксикацией организма инфекцией в других органах или ее токсинами, ксенобиотиками, нарушением микрофлоры кишечника или задержкой в поступлении импульсов в результате поражения сосудов и циркуляции в них.

В связи с вышеуказанным при лечении узкоспектральными излучателями наряду с терапией, направленной на восстановление функций органов и систем, вовлеченных в патологический процесс, основное внимание необходимо уделять нормализации баланса отделов вегетативной нервной системы.

Для определения органов, вовлеченных в патологический процесс, можно проводить электроакупунктурную диагностику по методу Р.Фолля, позволяющую определить функциональное состояние органов и систем в их взаимосвязи.

В соответствии с данными обследования проводятся мероприятия по санации очагов инфекции, нормализации микрофлоры кишечника, жирового обмена, микроциркуляции.

Для улучшения процессов рубцевания в области язвы проводятся процедуры, направленные на активизацию функциональной активности надпочечников, что позволяет повысить синтез глюкокортикоидов и диссоциацию их с белками.

На область язвы рекомендуется проводить воздействие излучателями, оказывающими противовоспалительный эффект.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ

В литературе этиологический фактор возникновения острого гломерулонефрита традиционно связывают с гемолитическим стрептококком группы А. Однако не исключаются и другие инфекционные агенты, являющиеся пусковыми факторами развития заболевания - возбудители инфекционного эндокардита, сепсиса, пневмококки, менингококки; вирусы гепатита В, инфекционного мононуклеоза, паротита, ветряной оспы, Коксаки, ЕСНО. Возможно поражение клубочкового аппарата почек и при полисистемных заболеваниях, поствакцинальных поражениях, болезни Бергера, синдроме Гийена-Барре.

Развитие заболевания, как правило, происходит на фоне сниженной резистентности организма и характеризуется слабостью адаптационных возможностей организма и нарушениями иммунитета.

Исходя из вышесказанного, основное лечение должно быть направлено на удаление патогенного фактора с одновременным проведением мероприятий по повышению резистентности организма.

При лечении узкоспектральным ИК-излучателями комплекс лечебных мероприятий должен включать следующие процедуры:

1. Применение антибактериальных и противовирусных излучателей - для удаления имеющейся инфекции.
2. Нормализация баланса отделов вегетативной нервной системы достигается путем воздействием излучения на гипоталамус.
3. Нормализация микрофлоры кишечника и микроциркуляции (нарушение микроциркуляции и состояния микрофлоры может усиливать интоксикацию организма, что может вызвать сбой в системе управления и явиться причиной отложения циркулирующих комплексов на стенках сосудов).
4. Активизация функциональной активности надпочечников для повышения уровня свободных глюкокортикоидов
5. Активизация функциональной активности поджелудочной железы для поддержания гликолитического пути энергообмена в организме.

На область почек в стадии воспаления и фибриноидного некроза назначаются излучатели с антимикробным или противовирусным действием (в зависимости от возбудителя). В стадии нарушения микроциркуляции добавляется излучатель оказывающий рассасывающий эффект и

восстанавливающий микроциркуляцию. При лечении острых процессов в первую очередь проводятся мероприятия направленные на удаление инфекции из организма, при хронических - на повышение его резистентности.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ СКЛЕРОДЕРМИИ

Склеродермия относится к системным заболеваниям соединительной ткани с преимущественным поражением кожи. Причиной заболевания является различного вида инфекция (вирусная, микробная), отягощенность организма токсинами органической или неорганической природы, или солями тяжелых металлов. Интоксикация организма возможна также при нарушениях микрофлоры кишечника, микроциркуляции и кровотока в целом, травмах. Воздействия указанных патогенных факторов на организм приводит к нарушению регулирующей функции системы управления (гипоталамус, гипофиз), изменениям в гипофизарно-надпочечниковой системе, смещению баланса вегетативных регуляций. У лиц с отягощенной наследственностью или предрасположенностью к развитию коллагенозов, результатом этих изменений является аутосенсебилизация организма, проявляющаяся деструкцией собственного коллагена, а также нарушениями микроциркуляции и проницаемости сосудов.

Для успешной терапии необходимо воздействие на все органы и системы, вовлеченные в патологический процесс. Необходимо проводить мероприятия направленные на удаление инфекции и других ксенобиотиков, нормализацию системы управления, стимуляцию выработки собственных глюкокортикоидов, восстановление микроциркуляции.

Комплексную терапию возможно провести с использованием разных типов узкоспектральных инфракрасных излучателей. Испускаемое ими излучение имеет длину волны ниже излучения организма человека, поэтому он является прозрачным для него и излучение оказывает воздействие только на те патологические процессы с которыми находится в резонансе.

Последовательность применения излучателей индивидуальна и зависит от состояния больного, которое определяется при помощи общемедицинских методов, а также при помощи метода электроакупунктурной диагностики Р.Фолля. Метод Р.Фолля позволяет определить функциональное состояние органов и систем в их взаимосвязи, а также подобрать оптимальный тип излучения и продолжительность экспозиции.

При лечении очаговой склеродермии необходимо учитывать стадию заболевания. В стадии отека сначала используются излучатели, оказывающие противовоспалительный эффект; в стадии - инфильтрации - рекомендуется одновременное применение излучателей с противовоспалительным действием и восстанавливающим микроциркуляцию; в стадии атрофии - лечение начинается с применения излучателя восстанавливающего микроциркуляцию.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕРМАТОМИОЗИТА

Дерматомиозит - системное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением, в результате аутоиммунных нарушений, мышечной ткани, проявляющемся ее уплотнением.

Аутоиммунные нарушения развиваются при изменениях вегетативной регуляции, обусловленных сбоем в системе управления (гипоталамус, гипофиз), возникающим в результате стресса или продолжительной интоксикации организма (инфекция, нарушение состояния микрофлоры кишечника, нарушение микроциркуляции и др.).

Руководствуясь вышеизложенным, лечение дерматомиозита ИК-излучателями должно включать мероприятия, направленные на санацию очагов инфекции, нормализацию баланса отделов вегетативной нервной системы, восстановление микрофлоры кишечника, микроциркуляции, стимуляцию функциональной активности надпочечников.

На область уплотнения мышц применяются излучатели оказывающие нормализующее действие на состояние кровотока, а также противовоспалительный эффект.

Выбор типа излучения определяется индивидуально и зависит от состояния больного и характера патологического процесса.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ

Основным признаком красной волчанки является деструкция собственного коллагена с образованием ненормальных, коротких, сложных нитей, а также нарушение микроциркуляции.

Деструкция коллагена является результатом аутосенсебилизации, развивающейся из-за нарушений регуляторной функции вегетативной нервной системы, нарушений в гипофизарно-надпочечниковой системе. Причинами

последних могут быть отягощенность организма инфекцией, токсинами органической и неорганической природы, солями тяжелых металлов. К интоксикации организма также приводят нарушения микрофлоры кишечника и микроциркуляции.

В связи с вышеизложенным лечение красной волчанки должно включать процедуры направленные на санацию очагов инфекции, активизацию функциональной активности надпочечников, нормализацию баланса отделов вегетативной нервной системы, путем воздействия на гипоталамус, гипофиз, восстановление микроциркуляции и микрофлоры кишечника.

Проведение вышеуказанных мероприятий возможно при помощи разных типов узкоспектральных инфракрасных излучателей.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТИЗМА

Основным этиологическим фактором ревматизма является интоксикация организма бактериальной инфекцией, преимущественно беттагемолитическим стрептококком. Возможна аллергическая природа заболевания - в результате сенсебилизации организма различными токсинами органической и неорганической природы, солями тяжелых металлов.

Продолжительное воздействие на организм токсинов, вызывает сбой в системе управления (гипофиз, гипоталамус), нарушение вегетативных регуляций, что приводит к развитию аутоиммунных процессов, характеризующихся развитием воспаления соединительной ткани с преимущественным поражением суставов и сердца и нарушением микроциркуляции в них.

В соответствии с вышеизложенным при лечении ревматизма основное внимание должно уделяться очищению организма от имеющейся инфекции с одновременной нормализацией баланса отделов вегетативной нервной системы, микроциркуляции, стимуляцией функциональной активности надпочечников.

Учитывая, что у больных основным путем энергообмена является гликолитический путь, рекомендуется проводить мероприятия, направленные на активизацию функциональной активности поджелудочной железы.

Весь комплекс указанных лечебных мероприятий возможно провести с использованием разных типов узкоспектральных инфракрасных излучателей.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ РЕВМОКАРДИТА

Ревмокардит - аллергическое состояние, развивающееся под влиянием неблагоприятных моментов, таких как переохлаждение, стресс, в результате сенсибилизации мембранных рецепторов, мышечных и соединительно-тканных клеток сердца бактериальной инфекцией. Ревмокардит - аллергическое состояние, развивающееся под влиянием неблагоприятных моментов, таких как переохлаждение, стресс, в результате сенсибилизации мембранных рецепторов, мышечных и соединительно-тканных клеток сердца бактериальной инВ результате длительного воздействия патогенных факторов происходит "сбой" в работе нервной системы с характерным для него снижением активности симпатического отдела вегетативной нервной системы, нарушением гипофизарно-надпочечниковой системы и снижением уровня глюкокортикоидов.

Для успешной терапии необходимо проводить мероприятия, направленные на удаление инфекции, нормализацию баланса отделов вегетативной нервной системы, микроциркуляции, микрофлоры кишечника, стимуляцию функциональной активности надпочечников и поджелудочной железы.

Применение для лечения разных типов узкоспектральных инфракрасных излучателей, оказывающих влияние только на патологические процессы с которыми изучение находится в резонансе, позволяет провести весь комплекс лечебных мероприятий, в соответствии с описанным выше этиопатогенезом ревмокардита.

Лечение гипертонической болезни путем нормализации жирового обмена и восстановления функциональной активности позвоночника

Патогенез возникновения гипертонии очень сложен, в патологический процесс вовлечены многие органы и системы.

Немаловажная роль в патогенезе развития гипертонии принадлежит нарушению жирового обмена. Нарушение жирового обмена выражается в смещении баланса липопротеидов (ЛП) в сторону липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), а значит в повышении уровня холестерина в крови, который, осаждаясь на стенках сосудов, приводит к нарушению микроциркуляции и кровотока в целом. Восстановление баланса ЛП способствует улучшению транспорта холестерина из тока крови, нормализации его концентрации, что способствует улучшению кровотока.

Использование в лечении гипертонической болезни узкоспектральных излучателей на область печени и желчного пузыря позволяет нормализовать баланс ЛП. А применение излучателя, оказывающего рассасывающий эффект позволяет "очистить" сосуды от патологических отложений на них.

На состояние кровотока в области головного мозга оказывает влияние состояние шейного и крецового отделов позвоночника и мышц шеи, нарушение которого отмечаются при продолжительном спазме мышц шеи в результате воспалительных процессов в позвоночнике или остеохондроза. Эти нарушения могут явиться причиной развития гипертонии. Поэтому при лечении больных гипертонической болезнью рекомендуется проводить диагностику состояния мышц и позвоночника в области шеи и крестца, а при наличии отклонений необходимо проводить мероприятия, направленные на их устранение.

При лечении больных узкоспектральными ИК-излучателями, для снятия воспалительных явлений в области шейного отдела позвоночника и мышц шеи, применяются излучатели оказывающие противовоспалительный эффект G), а также нормализующие микроциркуляцию и восстанавливающие эластичность межпозвоночного диска (Z).

ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Процессы, протекающие в организме (как физиологические, так и патологические) затрагивают множество органов и систем взаимосвязанных между собой. Взаимосвязь осуществляется на уровне нервной (через гипоталамус, гипофиз), эндокринной и других систем. В норме, в ответ на какой-либо раздражитель, нервная система отвечает выбросом гормонов, ферментов, спазмом сосудов и производством антител. Своевременность и последовательность этих процессов, по сути, определяют состояние иммунитета и обеспечивают адекватность реакции на раздражитель.

Иммунный ответ считается нормальным, если после ответа на раздражитель организм возвращается к физиологическому состоянию. При постоянном раздражителе синтез и разрушение необходимых веществ повторяется неоднократно, что может привести к их сбою, и в конечном итоге снижению работы симпатического отдела вегетативной нервной системы, а соответственно к снижению уровня стероидных гормонов. Этому так же способствуют такие дестабилизирующие факторы, как разнообразные инфекции, токсины органической и неорганической природы, соли тяжелых

металлов, отрицательные психоэмоциональные нагрузки, нарушение микрофлоры кишечника или другие заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушение микроциркуляции и кровотока в целом.

В связи с вышесказанным, план лечения аллергических заболеваний зависит от причины вызвавшей сбой в работе нервной системы. В комплекс лечебных мероприятий необходимо включать процедуры, направленные на очищение организма от инфекции и др. ксенобиотиков, нормализацию работы гипоталамуса, восстановление баланса отделов вегетативной нервной системы, стимуляцию функциональной активности надпочечников, нормализацию микрофлоры кишечника, микроциркуляции.

Из-за повышенной сенсибилизации организма больных с различными проявлениями аллергии, в последнее время все больший интерес приобретают не медикаментозные методы терапии. Использование для терапии больных аллергическими заболеваниями разных типов узкоспектральных ИК-излучателей, позволяет оказать воздействие на все звенья патологического процесса.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ, ЭКЗЕМОЙ, ВИТИЛИГО

Псориаз, экзема, витилиго - заболевания, характеризующиеся различными клиническими проявления на коже. Однако, если рассмотреть причины их возникновения, то можно назвать общие для всех - это различные инфекции (вирусная, бактериальная, микотическая), отягощенность токсинами органической и неорганической природы, солями тяжелых металлов, нарушение микрофлоры кишечника и микроциркуляции, дисбаланс в системе управления (гипоталамус, гипофиз). Указанные причины заболеваний могут быть первичными или возникать в результате воздействия одного из перечисленных факторов. Клинические проявления, отличаются морфологическим признакам, определяющимися генетическими факторами и являются проявлением выраженной интоксикации организма.

В случаях витилиго, причиной заболевания, по нашему мнению, является повышенный синтез мелатонина - гормоноподобного вещества, который регулирует многие процессы в организме. Его повышенный синтез является компенсаторной реакцией в ответ на пречисленные факторы, приведшие к заболеванию. Мелатонин обладает еще одним свойством - он обесцвечивает пигмент. Таким образом, пигмент синтезируется в организме, но из-за коформационных изменений, вызванных воздействием повышенных

концентраций мелатонина, не имеет необходимой окраски. Устранение истинной причины заболеваний приводит к нормализации уровня мелатонина и, как следствие, восстановлению окраски кожи. Во многих случаях, пациенты, имеющие стаж заболевания витилиго десятки лет, излечиваются за 1-3 месяца.

В соответствии с вышеизложенным лечение должно включать следующие пункты:

1. Удаление инфекции (микробной, вирусной, микотической);
2. Нормализация баланса отделов вегетативной нервной системы;
3. Нормализация микрофлоры кишечника;
4. Нормализация микроциркуляции.
5. Активизация функциональной активности надпочечников.

В последние годы в связи с ростом медикаментозной аллергии все большее внимание уделяется немедикаментозным методам терапии, одним из которых является дальнее узкоспектральное инфракрасное излучение. Разные типы излучателей позволяют оказать противовоспалительный, антибактериальный, противо-микотический, противовирусный эффект, нормализовать состояние микрофлоры, баланс отделов вегетативной нервной системы, микроциркуляцию и кровоток, оказать активизирующее влияние на поджелудочную железу и надпочечники.

ПРИМЕНЕНИЕ УЗКОСПЕКТРАЛЬНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ В ЛЕЧЕНИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА

В клинике инфекционных болезней было произведено лечение 33 больных эпидемическим паротитом в возрасте от 2 до 28 лет методом резонансной терапии керамическими узкоспектральными ИК-излучателями.

В процессе лечения применяли противовирусный, противовоспалительный, нормализующий кровообращение и иммуностимулирующий излучатели.

У больных с легкой степенью тяжести заболевания (16,7% от общего количества больных) выздоровление отмечалось на 2-3 день лечения, сроки лечения сократились в 2 раза, по сравнению с контрольной группой больных. У больных со средней степенью тяжести заболевания (53,3%) выздоровление наступило на 5-6 день, что также в 2 раза быстрее по сравнению с контрольной группой. Тяжелые больные, которые составили 30% выздоравливали на 10-12 день.

У 7 больных мужского пола (23% от общего количества больных) течение заболевания было осложнено орхитом. После терапии узкоспектральными излучателями выздоровление отмечалось на 8-9 день. У 12 больных (40%), с повышенным уровнем лимфоцитов на 4 день терапии наблюдалась нормализация показателей. У 4 больных (13,3%) до начала терапии отмечалось повышение сахара крови, на 4-5 день терапии сахар крови нормализовался.

Анализ результатов лечения показал, что сроки лечения больных сократились в два раза по сравнению с контрольной группой больных, лечение которых проводилось без применения керамических излучателей.

Таким образом, полученные наблюдения показали возможность использования и эффективность метода резонансной терапии узкоспектральными ИК-излучателями при лечения эпидемического паротита.

ЛЕЧЕНИЕ ГАНГРЕНОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ИК-ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

Сосудистые заболевания нижних конечностей, связанные с затруднением притока артериальной крови приводят к очень грозным осложнениям, одним из которых является гангрена пальцев и стопы.

Как правило, лечение в таких случаях направлено на улучшение кровоснабжения, нормализацию микроциркуляции, а в случаях безуспешности этих методов прибегают к оперативному вмешательству - ампутации конечностей. Поэтому поиски более доступных и менее травматичных методов лечения очень актуальны.

Метод резонансной ИК-терапии, применялся нами при лечении четырех больных с гангренозными поражениями стоп, из них у 2-х больных гангрена была осложнением эндартериита нижних конечностей, у 1 больного - осложнением сахарного диабета, у 1 больного - последствием тромбоза a. tibialis.

Всем больным было предложено в условиях стационара произвести оперативное вмешательство, направленное на ампутацию пораженного участка конечности. Больные отказались от данного метода лечения и обратились в НМЦ "Kamolot-Salomatlik".

В ходе терапии с целью восстановления кровообращения применялся излучатель ZB, а с целью снятия перифокального воспаления излучатель GI. К концу первого дня лечения уменьшились боли и перифокальный отек в пораженной конечности. После 3-5 дней лечения кровоток в пораженной

конечности стал восстанавливаться, боль и отек исчезли, цвет ткани стал восстанавливаться. Курс лечения до полного выздоровления составил 30±5 дней.

Таким образом, предложенный нами метод терапии может более широко применяться в практике сосудистой хирургии.

УЗКОСПЕКТРАЛЬНЫЙ ПРОТИВОВИРУСНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ В ТЕРАПИИ HERPES SIMPLEX У ДЕТЕЙ

Одним из наиболее встречающихся дерматозов вирусной этиологии в детском возрасте, является Herpes simplex. Данный дерматоз характеризуется высокой контагиозностью, частотой встречаемости среди остальных дерматозов у детей в возрасте 5-7 лет - 9,5%.

В детском дерматологическом отделении клиники ТашПМИ проведено клиническое испытание нового метода лечения Herpes simplex (ГС) у детей с использование узкоспектральных инфракрасных (ИК) излучателей.

В комплексной терапии применялись излучатели локального противовирусного действия, а в качестве немедикаментозной иммунокорекции - иммуностимулирующие эмиттеры.

Под нашим наблюдением находилось 7 больных с проявлениями ГС на губах, 2 - с часто рецидивирующей абортивной формой, 5 - с отечной формой дерматоза. До обращения в клинику все дети получали противовирусную терапию препаратами местного действия - ацикловиром, бонафтоновой и оксолиновой мазями, но рецидивы герпетической инфекции наблюдались с частотой не реже 1-2 раз в месяц, осенне-зимнего периода.

Нами проводилось амбулаторное лечение ГС противовирусным излучателем в течение 7-10 дней, воздействие проводилось непосредственно на область высыпаний в течение 5-7 мин, 1 раз в день. Всем детям проводилась иммуностимулирующая терапия узкоспектральным ИК-излучателем общего действия в течение 10-15 мин, 1 раз в день.

До начала, в процессе и после проводимой терапии всем больным проводилось иммунологическое обследование периферической крови с помощью стандартного набора моноклональных антител к дифференцированным антигенам CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD22+.

Начиная с 2-3 процедуры, отмечался регресс герпетических элементов, пузырьки ссыхались в корочки, улучшалось общее самочувствие детей. Клинические проявления ГС исчезали полностью на 5-6 день проводимой

терапии. К 10 дню у детей в картине периферической крови отмечалась нормализация показателей клеточного и гуморального иммунитета.

После проведенного курса терапии дети наблюдались в течение 1 года. Рецидив ГС наблюдался только у 1 ребенка после перенесенной ОРВИ.

Таким образом, предлагаемый нами метод лечения ГС узкоспектральными ИК-излучателями является методом выбора немедикаментозной терапии Herpes simplex у детей, особенно страдающих вторичным иммунодефицитным состоянием, и может быть рекомендован в терапии других вирусных дерматозов.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА УЗКОСПЕКТРАЛЬНЫМИ ИНФРАКРАСНЫМИ (ИК) ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

Имеющиеся в настоящее время меры борьбы с гриппом недостаточно эффективны и не всегда общедоступны, а вызываемые этим вирусом осложнения слишком грозны и нередко приводят к летальному исходу.

Нами в осенне-зимнем периоде проведено лечение 30 больных гриппом, из них: 12 женщин, 10 мужчин и 8 детей. К нам в клинику, все больные обратились в остром периоде заболевания с жалобами на высокую температуру 38-39^{0}С, слабость, недомогание, головные боли, чувство ломоты в конечностях, озноб, чувство разбитости, отсутствие аппетита.

Больным назначались процедуры с воздействием излучения на всю поверхность тела: RV, RC и GI(AF) по 20-30 мин, после которых проводили локальное воздействие на область носоглотки и органы дыхания излучателями RV и ZB по 10-15 мин. Процедуры проводились по 3 раза в день с перерывом 3-4 часа. К концу второго дня терапии у всех больных отмечалась нормализация температуры и значительное улучшение общего состояния.

Полученные результаты доказывают возможность использования метода резонансной терапии узкоспектральными ИК-излучателями в лечении и профилактике гриппа.

ДАЛЬНЕЕ УЗКОСПЕКТРАЛЬНОЕ ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА

В патогенезе развития холецистита важное место имеет различного рода инфекция (бактериальная, вирусная или микотическая, простейшие), удаление которой очень часто позволяет добиться успеха в лечении. Применяемая в

настоящее время антибиотикотерапия не всегда достаточно эффективна, кроме того, приводит к появлению дисбактериоза, что еще больше отягощает течение холецистита.

В последнее время все большее значение приобретают немедикаментозные виды терапии холецистита. Много лет для лечения заболеваний используется инфракрасный спектр излучения. Однако он не находил широкого применения в медицине из-за отрицательного воздействия на организм его коротких волн. Воздействие на организм излучения с длиной волны выше, чем излучение человеческого организма, не оказывает отрицательного действия на физиологические процессы и может быть использовано для лечения заболеваний.

На основе керамических материалов созданы системы преобразования энергии, способные поглощать излучение широкого спектра, а испускать его в узком заданном диапазоне. Использование различных типов преобразователей позволяет получить излучение, оказывающее противовоспалительный, противомикробный эффекты, нормализавать состояние микросомальных ферментов, уменьшить уровень свободных радикалов.

На базе научно-медицинского центра "Kamolot-Salomatlik" проводилось наблюдение за больными хроническим холециститом, получавшими лечение узкоспектральным инфракрасным излучением. Под наблюдением находилось 52 больных хроническим холециститом (44 больных с некалькулезным и 8 с калькулезным). Возраст больных колебался от 10 до 72 лет (мужчин -21, женщин - 31). Продолжительность заболевания была от 1 года до 20 лет. Оценка эффективности терапии проводилась на основании жалоб больного, объективного обследования (Таблица 1).

Таблица 1. Процент встречаемости признака до и после лечения ИК-излучением.

Симптом	**% встречаемости признака до лечения**	**% встречаемости признака после лечения**
Тошнота	100	23
Чувство горечи	26,9	0
Нерегулярный стул	19,2	0

Ультразвуковое обследование проводилось 20 больным. У всех обследованных больных отмечалось уплотнение и утолщение стенок желчного пузыря; у 12 из них - загиб желчного пузыря.

Для лечения больных применялось инфракрасное узкоспектральное излучение, оказывающее противовоспалительный, противомикробный эффект, нормализующее состояние микроциркуляции и иммунный статус.

Продолжительность терапии составила 13,6±3,52 дня. К 10 дню терапии у больных исчезли тошнота, горечь во рту, нерегулярный стул (Таблица 1).

К окончанию курса лечения 73% больных отмечали исчезновение болей в правом подреберье, 5,7% - их уменьшение; 5,7% изменения в интенсивности болей не отмечали.

Ультразвуковое обследование, проведенное после лечения, показало, что у 50% состояние стенок пузыря было в пределах нормы; уменьшение уплотнения стенок пузыря - у 25%. У 25% больных динамики изменений на УЗИ после терапии не выявлено.

У больных калькулезным холециститом продолжительность терапии ИК-излучением составила (16,6 + 4.78) дней. Повторное ультразвуковое обследование показало отсутствие камней у 50% больных, уменьшение их размеров - у 30%. У 20% больных изменений на УЗИ не выявлено.

Таким образом, полученные результаты терапии показали возможность использования узкоспектрального инфракрасного излучения для лечения хронических бескалькулезных и калькулезных холециститов.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УЗКОСПЕКТРАЛЬНЫХ ИК-ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ ИБС

0В исследования вошли 20 больных ИБС, мужчин в возрасте 40-55 лет. Диагноз ИБС выставлялся на основании опроса по анкете Rose и данных велоэргометрии (ВЭМ) (воспроизведение приступа стенокардии и/или "ишемической" депрессии сегмента ST больше 1 мм и продолжительностью не менее 0,08 сек на ЭКГ у больных во время ВЭМ нагрузки), а также при указаниях в анамнезе на перенесенный инфаркт миокарда, документированный ЭКГ исследованием. У всех больных хронической ИБС определена стабильная стенокардия напряжения, у 12 больных II ФК стенокардии, у 8 больных III ФК, 4 больных в прошлом перенесли инфаркт миокарда. У 12 больных выявлена сопутствующая патология, из них у 5 - остеохондроз с корешковым синдромом, у 4-х астенизация нервной системы, у 3-х больных - ОРВИ.

В исследования не включались больные с признаками НК IIБ и III стадии, частой желудочковой и наджелудочковой экстрасистолией, ЭКГ-признаками AV-блокады II-III степени, признаками обострения течения ИБС (нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда), а также больные менее чем 6 месяцев назад перенесшие инфаркт миокарда. Верификацию стенокардии напряжения и оценку исходной толерантности (по величине общего объема выполненной работы) к физической нагрузке, с определением ФК класса стенокардии проводили по общепринятым рекомендациям с помощью ВЭМ теста. Перевод больных с III во II ФК проводили по общепринятым рекомендациям.

Оценку влияния ИК-излучателей на коагулирующие свойства крови проводили по показателям коагулограммы до, во время сеансов и на 1 - 3 - 6 месяце терапии. Оценку влияния ИК-излучателей на уровень липопротеидов низкой и высокой плотности проводили при исследовании липидного состава крови также до, во время сеансов и на 1 - 3 - 6 месяце терапии. Оценку влияния ИК излучателей на глобальную и локальную сократимость левого желудочка, объемы левого желудочка, массу миокарда левого желудочка проводили с помощью метода эхо-кардиографии. Эхокардиография проводилась до, во время сеансов и на 1 - 3 - 6 месяце терапии.

Наблюдения за больными хронической ИБС со II и III ФК стенокардии напряжения в течение 6 месяцев показали, что включение соответствующих режимов воздействия узкоспектральных ИК-излучателей к поддерживающей медикаментозной антиангинальной (нитраты, b-блокаторы и антагонисты Са) терапии не привело к возникновению обострения и прогрессированию заболевания, повышению коагулирующих свойств крови у больных с нормальными исходными показателями коагулограммы, не вызвало нарушений в липидном составе крови у больных, если изначальный уровень липопротеидов низкой и высокой плотности у последних лежал в пределах нормы.

4 больных ИБС с III ФК стенокардии были переведены во II ФК.

Применение ИК-излучателей у больных ИБС, с сопутствующей ОРВИ, показало их эффективность в устранении симптомов вирусной инфекции, а также повышение сопротивляемости организма к ней во время эпидемии. Применение ИК-излучателей у больных ИБС с сопутствующим остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника с корешковым синдромом показало их высокую эффективность в устранении болевого синдрома. У больных ИБС с астенизацией нервной системы при применении ИК - излучателей отмечен успокаивающий эффект, нормализация сна и устранение вегетативных расстройств.

Приведенные данные указывают на возможность включения узкоспектральных ИК-излучателей в комплекс лечебно оздоровительных мероприятий, применяемых в активном динамическом наблюдении за больными ИБС.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЭНТЕРОКОЛИТОВ И КОЛИТОВ МЕТОДОМ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ

Нарушение функции кишечника является одной из причин интоксикации организма, которая приводит к снижению его адаптационных возможностей, способствуя повышению восприимчивости к различным заболеваниям. Поэтому лечению заболеваний кишечника, необходимо уделять очень большое внимание, особенно учитывая тот факт, что последнее время отмечается их значительный рост. Постоянно ведется поиск новых, более эффективных, не оказывающих побочных эффектов средств лечения.

В НМЦ "Kamolot-Salomatlik" за период 1998-2000 года было проведено лечение методом резонансной терапии узкоспектральными ИК-излучателями 86 больных с хроническим энтероколитом и колитом. Из них 68,6% женщин и 31,4% мужчин. Ведущими жалобами всех обратившихся больных были спастические боли по ходу тонкого и толстого кишечника, чувство постоянного дискомфорта, метеоризм, запоры, недомогание и общая слабость, головная боль.

Воздействие узкоспектральным инфракрасным излучением проводилось в виде общих и локальных процедур. Локально на область кишечника, для уничтожения патогенных микроорганизмов назначали противовирусный, противовоспалительный и антибактериальный, а также антимикотический излучатели. Тип излучателя и время экспозиции подбиралось под контролем ЭАФ, и в среднем составляло 15 мин. Необходимой процедурой была нормализация кровообращения в сосудах кишечника. С этой целью на область кишечника ежедневно в течение 10 мин назначался излучатель, нормализующий микроциркуляцию. Всем больным до и после лечения проводилась коррекция состояния иммунитета и вегетативной нервной системы.

В результате проводимой терапии значительное улучшение состояния у 96,6% наблюдаемых больных отмечалось на 5-7 день лечения и проявлялось в: прекращении спастических болей и чувства дискомфорта в области живота, исчезновении головной боли, повышении работоспособности. Нормализация

стула у женщин наблюдалась на 13±2 день лечения, у мужчин на 11±2. У троих больных, что составило 3,4% от общего количества больных, положительного эффекта не наблюдалось. Медикаментозные препараты во время лечения больных не применялись.

Таким образом, данные наблюдения показали возможность применения метода резонансной терапии для эффективного лечения хронического колита и энтероколита.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЗКОСПЕКТРАЛЬНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ МАТКИ.

Инфекционные и воспалительные процессы, отягощенность организма токсинами и ионами тяжелых металлов, гиповитаминозы, стрессы приводят к нарушению обменных процессов и сбою в системе регуляции организма. На фоне этих нарушений в гипоталамо-гипофизарной системе организма очень часто развивается миома матки.

Миома матки - это одна из наиболее распространенных доброкачественных опухолей, развивающихся в мышечной оболочке матки. Очень часто на ранней стадии развития она не дает о себе знать, и при ее выявлении, констатируют диагноз "бессимптомная миома", ограничиваясь пассивным наблюдением с осмотрами 3-4 раза в год, тем самым, оттягивая проведение терапии, которая бывает наиболее эффективной на начальной стадии развития болезни.

С наступлением менопаузы миома иногда рассасывается сама, но молодым женщинам страдающим этим заболеванием невозможно ждать наступления, а затем прекращения климакса. За это время миома, увеличиваясь в размерах, сдавливает окружающие ткани и органы, в крупных миоматозных узлах возникают кровоизлияния, некроз, размягчение, образуются псевдокисты, нарушается менструальный цикл и возникают длительные маточные кровотечения.

В НМЦ "Kamolot-Salomatlik" наблюдалось 12 женщин в возрасте от 39 до 49 лет с диагнозом миома матки, различной локализации узлов: интерстициальные - 7, субмукозные - 3, множественные - 2. Величина матки (в неделях беременности): 6 недель - 4 больных, 7-8-9 недель - 4, 11-12 недель - 3, 17 недель - 1.

Давность заболевания составляла в среднем 2,18 года. На боли жаловались 83,3% женщин. Меноррагия встречалась в 75% случаев. Метроррагия в 50% случаев, из них 40% женщин отмечали длительное

кровомазанье, а 60% - кровотечение длительностью до 2-х месяцев, 25% больных отмечали задержку менструаций на 2-3 месяца, из них в последующем у 33,3% больных отмечалась меноррагия.

Лечение узкоспектральными ИК-излучателями было направлено на восстановление нарушенных соотношений в гипоталамо-гипофизарной системе (KL, ZB); устранение проявлений сопутствующего воспалительного процесса (GI), улучшение состояния миометрия (RV/RC, ZB), нормализацию функции яичников (RC/GI, ZB/GI).

Одновременно проводились мероприятия по коррекции иммунной системы, повышению адаптационных возможностей организма. Медикаментозная терапия больным не проводилась.

В среднем продолжительность лечения составила 1,5 месяца. В результате лечения в 33% случаев произошло полное рассасывание узлов (в основном у женщин с 6 недельной миомой). Регресс заболевания (уменьшение размеров матки на 2-3 неделе) в 50% случаев при имевшейся миоме 7-11 недель. Эффекта не наблюдалось в 17% случаев при 12 и 17 недельной миоме с множественными узлами.

Все женщины, имеющие обратную динамику в развитии миомы, отмечали исчезновение болевого синдрома, нормализацию менструальной функции и отсутствие кровомазанья и кровотечений в межменструальный период.

Наблюдение за больными проводилось в течение 6 месяцев. Рецидивов заболевания не было.

Таким образом, применение узкоспектральных ИК-излучателей при миоме матки в сроке до 11 недель, позволяет добиться обратного развития процесса, восстановить систему регуляции половой функции, избежать оперативного вмешательства.

МОРФОГЕНЕЗ СПАЙКООБРАЗОВАНИЯ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Несмотря на адекватное проведение операции и соблюдение всех правил асептики и антисептики частота спаечного процесса в брюшной полости после операций на органах брюшной полости не имеет тенденции к снижению (48%-93%), а послеоперационная летальность достигает 24%. В связи с этим проблема профилактики спаечного процесса к настоящему времени остается актуальной.

С целью снижения частоты спаечного процесса (СП) в брюшной полости, нами в эксперименте на крысах были использованы керамические

узкоспектральные инфракрасные (ИК) излучатели. СП в брюшной полости вызывали путем механического травмирования серозной оболочки слепой кишки и париетальной брюшины. В послеоперационном периоде до 7 суток проводили ИК-облучение на область живота с помощью излучателя ЗК (длина волны 20-22,5 мкм, мощность 10 мВт). Животных забивали методом мгновенной декапитации на 1, 3, 7, 14, 21 сутки с момента операции и результаты анализировали по наличию и степени тяжести СП в брюшной полости. Биопсийные образцы брали из областей спайкообразования на морфологические исследования (световая и сканирующая электронная микроскопия S-405 A Hitachi, Япония)

Результаты исследований показали, что в контрольной группе без ИК-облучения СП развился у всех животных (100%). При этом выраженное спайкообразование наблюдали в 58,3% случаях, умеренное спайкообразование - в 25% и слабое в 8,3%. В группе с ИК-облучением СП обнаружили в 58,3% случаях, а также установили тенденцию к снижению степени тяжести спайкообразования.

Морфологическими исследованиями было установлено, что на первые сутки с момента повреждения брюшины отмечалось выпадение фибрина и клеток перитонеальной жидкости на денудированную поверхность брюшины. На 3 сутки формировались рыхлые спайки основу которых составлял фибрин и малодифференцированные клетки. В данный срок наблюдения отмечалось начало дифференцировки низкодифференцированных клеток в фибробласты.

На 7 сутки основу спаек составляла молодая соединительная ткань, которая была представлена тонкостенными кровеносными капиллярами, фибробластами и тонкими пучками коллагеновых фибрилл. Источником кровеносных капилляров являлись близлежащие участки соединительно-тканной основы брюшины.

На 14-21 сутки основу спаек составляла зрелая соединительная ткань, состоящая из толстых пучков коллагеновых волокон, кровеносных капилляров и фибробластов. Из средней оболочки тонкой кишки в толщу спаек прорастали гладкомышечные клетки и нервы. Поверхность спаек была выстлана мезотелиальными клетками.

Во второй группе животных с воздействием ИК излучения при гистологическом исследовании было установлено, что через 3 суток после повреждения брюшины денудированная поверхность частично покрывается мезотелиальными клетками продолговатой формы. На демезотелизированных

участках откладывается фибрин и клетки перитонеальной жидкости, однако, количество их существенно меньше, чем в контрольной группе.

На 7 сутки поврежденная поверхность брюшины полностью покрывается мезотелиальными клетками продолговатой или овальной формы. Площадь апикальной поверхности мезотелиоцитов меньше, чем в норме. Снижено также и количество микроворсинок на их апикальной поверхности. В соединительно-тканной основе брюшины усилена макрофагальная и лимфоцитарная инфильтрация, умеренно выражен оттек.

На 14-21 сутки отмечается полное восстановление клеточного состава брюшины. Мезотелиоциты сплошным слоем выстилают её поверхность, лежат на хорошо выраженной базальной мембране. На их брюшинной поверхности имеется большое количество микроворсинок.

Таким образом, при повреждении мезотелиального слоя происходит резкое снижение пролиферативной способности мезотелиоцитов, что, возможно, служит причиной для развития спаек и спаечной болезни. ИК облучение способствует быстрому восстановлению кровообращения на уровне сосудов гемомикроциркулярного русла, что позволяет активизировать защитные механизмы. Эти условия способствуют снижению экссудативных воспалительных изменений в брюшине, восстановлению пролиферативной способности мезотелиоцитов и ускорению заживления поврежденных зон брюшины. Включение узкоспектрального ИК излучения в комплекс профилактики позволило снизить частоту возникновения спаечного процесса в брюшной полости почти в 2 раза.

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БОЛЬНЫМИ РАКОМ ПОЛУЧАВШИМИ ЛЕЧЕНИЕ УЗКОСПЕКТРАЛЬНЫМ ИК-ИЗЛУЧЕНИЕМ

Несмотря на достижения современной науки в области лечения онкологических заболеваний, продолжается поиск новых более эффективных методов терапии.

Одним из новых методов в лечении онкологических больных является применение узкоспектральных излучателей серии R.

В госпитале Penawar под наблюдением находилось 29 больных раком различной локализации (12 из них больные раком молочной железы, 3 - раком легких, 3 - раком цервикального канала шейки матки и 11 больных с локализацией опухоли в других органах).

По стадии заболевания больные разделились следующим образом: больных с 4-ой стадией заболевания было 21; с 3-ей - 4; со 2-ой - 4.

Лечение проводилось узкоспектральным излучателем серии R. Под воздействием данного излучения проводится рекомбинация свободных радикалов с высокой степенью активации. Одновременно использовались излучатели оказывающие нормализующее действие на микроциркуляции и микрофлору кишечника.

Анализ результатов лечения показал, что у 34% больных было отмечено улучшение общего состояния. У 58% больных отмечалось улучшение состояния в симптомах связанных с наличием опухоли. Значительное изменение в клинических проявлениях опухолевого процесса (такие как уменьшение болей связанных с появлением метастазов) отмечено у 10.3% и у 24% отмечалось уменьшение метастатических болей в области костей

Повторный рост опухоли отмечен у 1 больного (рецидив заболевания отмечен через 9 месяцев, против ожидаемых 3).

Отсутствие изменений состояния в процессе лечения отмечено у 34% больных.

Ухудшение в процессе терапии отмечали у 2 больных (6.7%)

Побочные эффекты в виде чувства усталости и сонливости отмечались у 2 больных. После перерыва в лечении подобные жалобы не повторялись.

Проведенные наблюдения показывают необходимость глубоких научных исследований в применении инфракрасных излучателей при лечении опухолевых процессов.

ПРИМЕНЕНИЕ УЗКОСПЕКТРАЛЬНЫХ ИК-ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ В ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В клинике госпиталя S. T. MARY при лечении онкологических больных применялся метод резонансной терапии узкоспектральными ИК-излучателями.

Наблюдение проводилось за 21 больным с поражением различных органов и систем на разных стадиях заболевания, которым проводилось терапевтическое воздействие узкоспектральным излучателем серии R. С целью объективной оценки результатов лечения применялся метод хемолюминесценции - подсчет количества свободных радикалов в крови на аппарате BJL, до и после лечения.

Данный метод обследования показал увеличение уровня свободных радикалов у больных онкологическими заболеваниями в 2-3 раза по сравнению

с контрольной группой. На 5-7 день терапии ИК-излучателями серии R отмечалась нормализация уровня свободных радикалов в крови. В процессе лечения у больных отмечалось улучшение самочувствия, повышение общего тонуса, аппетита, уменьшение болей. В динамике наблюдения за этой группой больных отмечалось замедление роста опухолей.

Перечисленное выше, позволяет сделать вывод, что применение узкоспектральных ИК-излучателей группы R в лечении онкологических заболеваний имеет все основания для внедрения в широкую практику.

ОПИСАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕТОДОМ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ УЗКОСПЕКТРАЛЬНЫМИ ИНФРАКРАСНЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

Сегодня, наряду с традиционными методами терапии, все более широкое применение в лечении различных заболеваний находит метод резонансной терапии узкоспектральным инфракрасным излучением. В работе представлены результаты эффективного лечения невропатии, абсцедирующего эхинококкоза, ревматоидного полиартрита, бесплодия, ювенильного маточного кровотечения, аменореи, токсоплазмоза, цитомегалии.

ЛЕЧЕНИЕ НЕВРОПАТИИ

Поражение периферических нервов может возникать в результате травмы, интоксикации, внедрения бактериальной или вирусной инфекции, нарушения обмена веществ и недостаточности кровоснабжения нервов и развивается, как правило, на фоне сниженной резистентности организма. Поэтому для эффективного лечения заболеваний периферических нервов необходимо учитывать все вышеперечисленные факторы. Лечение должно включать не только мероприятия направленные на удаление инфекции из очага поражения, но и восстановление кровообращения и обменных процессов на пораженном участке нерва, санацию очагов хронической инфекции во всех остальных органах и повышение иммунитета.

Больная С. 1976 г.р. обратилась в клинику с жалобами на боль в левой заушной области и наружном слуховом проходе, расширение глазной щели слева, слезотечение из левого глаза.

Из анамнеза: больна в течение недели, заболевание началось после перенесенного гриппа, до обращения в нашу клинику лечения не получала.

При осмотре; левая глазная щель расширена, отсутствует рефлекс мигания, выраженное слезотечение, симптом "парусита" положительный слева, отсутствие мимических движений в левой половине лица, перекос лица вправо. Больной выставлен диагноз острая невропатия n. faciales вирусной этиологии.

Лечение узкоспектральными ИК-излучателями было направлено на уничтожение вирусной инфекции, восстановление обмена веществ и микроциркуляции на пораженном участке нерва, улучшение кровообращения в пораженных мышцах и повышение их тонуса. Терапия проводилась только локальными излучателями.

На 3 день проводимой терапии прекратилось слезотечение, исчезла боль. На 7 день появилось мигание, глазная щель приобрела нормальные размеры. К концу лечения на 12 день у больной полностью восстановилась мимика.

Больной Б. 1985 г.р. обратился в клинику с жалобами на отсутствие тыльного сгибания и чувствительности в правой стопе.

Из анамнеза: болен в течение 8 месяцев, начало заболевания связано с перенесенной вирусной инфекцией. До обращения в нашу клинику лечения не получал. Был обследован невропатологом, выставлен диагноз невропатия n. peroneus.

При осмотре: тыльное сгибание в правой стопе отсутствует, стопа висит, болевая и температурная чувствительность снижена.

Лечение узкоспектральными ИК-излучателями было направлено на уничтожение вирусной инфекции, восстановление обмена веществ и микроциркуляции на пораженном участке нерва, улучшение кровообращения в пораженных мышцах и повышение их тонуса, стимуляцию иммунитета. Терапия проводилась общими и локальными излучателями.

На 3 день лечения появилось неполное тыльное сгибание правой стопы, на 10 день движения в стопе восстановились на 90%, чувствительность восстановились.

ЛЕЧЕНИЕ АБСЦЕДИРУЮЩЕГО ЭХИНОКОККОЗА ЛЕВОГО ЛЕГКОГО

Больная Л. 28 лет обратилась в клинику с жалобами на одышку, слабость, недомогание, боли в грудной клетке слева, кашель без выделения мокроты и постоянное повышение температуры тела до 38^0С.

Больна на протяжении 7-8 месяцев. При обследовании на рентгенографии обнаружили образование в диаметре до 3-х см. Установлен диагноз абсцедирующий эхинококкоз левого легкого. В стационарных условиях больной было предложено оперативное вмешательство, направленное на удаление абсцедирующего участка легкого. От оперативного вмешательства больная категорически отказалась, и в этой связи обратилась в нашу клинику.

При поступлении больной была проведена электроакупунктурная диагностика по методу Фолля, были подобраны необходимые для лечения излучатели. Воздействие было направлено на снятие воспаления в очаге поражения, подавление роста инфекции и восстановление кровообращения в пораженном легком.

На 2 день проводимой терапии отмечалось улучшение общего состояния, а на 7 день наблюдалось отхождение гноя с примесью крови при кашле, что было связано по нашему мнению с вскрытием абсцесса. При бактериологическом обследовании мокроты обнаружен стафилококк.

Лечение продолжалось 47 дней. В динамике лечения и наблюдения, после отхождения гноя, отмечалось стабильное улучшение состояния. Вышеперечисленные жалобы постепенно исчезли. Контрольная рентгенография показала отсутствие каких-либо полостных образований в легких.

ЛЕЧЕНИЕ РЕВМАТОИДНОГО ПОЛИАРТРИТА

Больная А. 1966 г.р поступила в клинику в тяжелом состоянии с жалобами на резкую слабость, одышку, недомогание, приступы тахикардии, снимающиеся только сердечными гликозидами, выраженное ограничение подвижности во всех суставах

(тазобедренном, коленном, голеностопном, а также плечевом, локтевом и лучезапястном суставах), А/Д 180/120 160/100.

В анамнезе: больна 5 лет, неоднократно лечилась стационарно, на протяжении 3-х лет получала гормональную терапию (по 25 мг преднизолона 3 раза в день). Д/з Ревматизм, активность I-II, возвратный ревмокардит, митрально-аортальный порок, ревматоидный полиартрит.

Проводилось лечение узкоспектральными ИК-излучателями, оказвающими противовоспалительный эффект и нормализующими состояние микроциркуляции. Одновременно больной проводилась терапия ИК-излучателями, направленная на нормализацию липидного обмена и микрофлоры кишечника.

Первый курс лечения длился на протяжении 1 месяца, затем был перерыв на 2 недели. Результатом месячного лечения явилось:

1. Ликвидация отеков в области всех суставов
2. Нормализация функции желудочно-кишечного тракта
3. Больная стала одеваться и двигаться самостоятельно
4. Отмечалась стабилизация АД в пределах 130/80
5. Резко уменьшились, практически прошли приступы тахикардии.

После двухнедельного перерыва больная явилась для продолжения лечения, которое проводилось по той же схеме, что и ранее, но основной упор делали на нормализацию липидного обмена и стимуляцию синтеза глюкокортикоидов.

Благодаря проводимому лечению больная была снята с гормонотерапии, стала активная, передвигается свободно, состояние удовлетворительное.

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ

Учитывая, что среди причин бесплодия основное место занимают воспалительные процессы в половых органах и различные эндокринные нарушения, а узкоспектральные ИК-излучатели обладают противовоспалительным и нормализующим действием на регулирующие системы организма (гипоталамус -гипофиз), мы использовали их для лечения данного заболевания.

Больная Л. 1977 г.р. обратилась в клинику с жалобами на боли в паховой области, нарушение менструального цикла, болезненные

менструации, отсутствие беременности, обильные выделения из половых путей

Из анамнеза: замужем 2 года, половая жизнь регулярная, детей нет. До настоящего времени нигде не лечилась и не обследовалась. С июля 1997 г. менструации стали нерегулярными, с задержкой.

При обследовании в зеркалах: шейка матки чистая, нерожавшей, p/v- тело матки нормальных размеров, матка безболезненная, плотная, подвижная. Придатки с 2-х сторон слегка увеличены, плотные, болезненные при пальпации. Выделения умеренные слизисто-гнойного характера. На УЗИ - матка нормальных размеров, правый яичник 34х31 мм, левый 43х33 мм, повышенной эхогенности. Заключение - эхокартина двухстороннего аднексита. Анализ выделений - эпителий ++, L-40-45/1, грам+ и _ флора (кокки)

В течение 4-х недель проводилось лечение узкоспектральными инфракрасными излучателями. При этом использовался антибактериальный и противовоспалительный излучатель. Общие процедуры этим излучателем составляли в среднем 40 мин в день, локально излучатель назначался по 5 мин на каждый яичник. Затем использовался излучатель, нормализующий кровообращение, также в виде общих и локальных процедур. Ежедневно проводились процедуры направленные на стимуляцию иммунитета и регуляцию состояния вегетативной нервной системы.

В результате проводимой терапии на 14 день исчезли боли в паховой области, на 20 день резко уменьшилось количество выделений. При повторном обследовании после окончания лечения на УЗИ матка и придатки без признаков эхопатологии, анализ выделений - эпит. +, L-5-7/1, грам+ флора.

Через 1 месяц после окончания лечения у больной наступила беременность, родился нормальный здоровый ребенок.

Больная М. 1971 г.р. обратилась в клинику по поводу отсутствия беременности, а также с жалобами на боли в правой паховой области, усиление болей во время полового акта, длительный менструальный цикл.

Из анамнеза: регулярной половой жизнью живет 3 года, не предохраняется, беременность не наступала, menses с задержкой на 2-3 недели.

При осмотре в зеркалах шейка матки чистая, р/v- тело матки нормальных размеров, б/б, плотное, подвижное. Придатки слева без особенностей, справа тяжистые, болезненные. Выделения умеренные, слизистого характера. Лабораторно-инструментальное обследование - общий анализ крови Hb-90 г/л; L-6,0; СОЭ-3 мм/ч. На УЗИ тело матки размером 60х45х57, смещено вправо, структура матки однородная. Правый яичник 36х25 мм с мелкокистозными изменениями, левый яичник не визуализируется.

Больной проводили лечение противовоспалительным и антибактериальным излучателем, а также излучателем, нормализующим кровообращение и рассасывающим патологическую соединительную ткань - общие и локальные (на область яичников) процедуры. Ежедневно проводились процедуры направленные на стимуляцию иммунитета и регуляцию состояния вегетативной нервной системы.

На 7 день проводимого лечения исчезли боли, после 15 сеанса придатки справа б/б, тяжи не прощупываются, выделения серозные, скудные. Лабораторно-инструментальное обследование после месячного курса терапии показало Hb-110г/л; L-5,0 г/л; СОЭ-5 мм/ч. УЗИ матки - беременность сроком 4 недели. Правый яичник 26х28 мм, левый 30х26 мм.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ МАТОЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ

Маточные кровотечения, особенно в период полового созревания, нередко приводят к опасным для жизни состояниям, поэтому в гинекологической практике их лечению уделяется большое внимание.

Больная Б. 1985 г.р поступила в клинику с жалобами на постоянное кровотечение из половых путей в течение 2-х месяцев, головокружение, слабость, снижение работоспособности.

Из анамнеза: в течение 9 месяцев отмечаются нарушения менструального цикла в виде длительных кровотечений. Начало заболевания ни с чем не связывает. Неоднократно получала гемостатическое и утеротоническое лечение, в течение 3-х месяцев синтетические прогестины, без эффекта.

При поступлении: кожные покровы бледные, Hb-80 г/л, анизо-пойкилоцитоз, на УЗИ органов малого таза без признаков

эхопатологии. При обследовании методом электроакупунктурной диагностики по Фоллю отмечалось резкое снижение показателей на всех меридианах.

Лечение узкоспектральными ИК-излучателями было направлено на нормализацию состояния гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, стимуляцию органов отвечающих за адаптационные механизмы. Также проводили иммуно-стимулирующую и противовоспалительную терапию.

В результате проводимой терапии на 5 день отмечалась остановка кровотечения, на 12 день Hb-112г/л. Последующее наблюдение в течение 2-х месяцев рецидивов кровотечений не выявило.

ЛЕЧЕНИЕ АМЕНОРЕИ

Менструальный цикл - биологический процесс, характеризующийся постоянными циклическими изменениями в организме женщины, осуществляется под контролем центральной нервной системы. В период полового созревания организм девочки наиболее чувствителен к различным неблагоприятным воздействиям, нервно-психические расстройства, чрезмерные физические нагрузки, неполноценное питание могут вызвать нарушение менструального цикла. Лечебные мероприятия, направленные на восстановление менструальной функции, обычно проводятся с применением гормональных препаратов, оказывающих непосредственное влияние на гипоталамо-гипофизарную систему. Зачастую врачи сталкиваются с нежеланием пациенток принимать гормональные препараты, поэтому ведется поиск новых альтернативных средств лечения нарушений менструального цикла.

Больная А. 1984 г.р. обратилась в клинику с жалобами на отсутствие менструаций в течение 7 месяцев, слабость, головокружение, снижение работоспособности.

В анамнезе: в течение 5 месяцев, с целью похудания, соблюдала жесткую диету, с исключением белковой пищи (ела только помидоры и яблоки), за это время похудела на 12 кг. Через месяц после начала диеты очередные menses не наступили. Больная обратилась к гинекологу, при обследовании патологии в половых органах не выявлено, при измерении базальной температуры в

течение 3 месяцев выявлен монофазный цикл. Получила стимулирующее лечение прогестероном, без эффекта.

При поступлении отмечалась бледность кожных покровов, неудовлетворительное развитие подкожно-жирового слоя (при росте 170 см больная весила 50 кг).

Проводимая терапия была направлена на нормализацию состояния гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, стимуляцию органов, отвечающих за адаптационные механизмы. Во время терапии узкоспектральными излучателями больная измеряла базальную температуру. На 6 день лечения отмечалось повышение базальной температуры до 37^0, что свидетельствовало о нормализации яичникового цикла. На 12 день терапии началась менструация.

Наблюдение за данной больной проводилось в течение 3-х месяцев. За этот период менструации регулярные, умеренные, безболезненные, цикл 28-30 дней.

ЛЕЧЕНИЕ ТОКСОПЛАЗМОЗА

Токсоплазмоз - паразитарное заболевание, характеризующееся поражением многих органов и систем, протекающее (при хронической форме) годами и приводящее к возникновению тяжелых осложнений. Существующие на сегодняшний день методы лечения токсоплазмоза недостаточно эффективны, поэтому поиск новых средств терапии не теряет своей актуальности

Больная И. 1951 г.р. поступила в клинику с жалобами на слезотечение, ломоту в суставах, боли в ногах, ухудшение зрения, общую слабость.

Из анамнеза: считает себя больной в течение 1,5 лет; обследовалась в НИИ Микробиологии и Инфекционных заболеваний, где был установлен диагноз токсоплазмоз (преимущественно глазная форма) - хорионэпителиит.

При осмотре: слезотечение, периферические лимфатические узлы увеличены, в основном подчелюстные и подмышечные, тоны сердца приглушены. При иммунологическом обследовании крови на токсоплазмоз - РГАЭр результат 1:20.

В течение 8 недель ежедневно проводилось лечение общими и локальными излучателями. При этом использовались: противовирусный (10 мин в день), антибактериальный и

противовоспалительный (от 20 до 90 мин в день по схеме), иммунокорригирующий (10 мин в день), улучшающий кровообращение (от 10 до 15 мин в день) излучатели. Локально излучатели назначались на оболочки мозга, лимфатические узлы, печень, селезенку, почки, глаза, желчный пузырь, кишечник. Время воздействия локальных излучателей подбиралось под контролем ЭАФ. Ежедневно проводилась регуляция состояния вегетативной нервной системы.

В результате проводимой терапии через 3 недели после начала лечения исчезли боли в ногах и суставах, через 8 недель прошло слезотечение, отмечалось улучшение зрения. При повторном иммунологическом исследовании крови на токсоплазмоз результат отрицательный.

ЛЕЧЕНИЕ ЦИТОМЕГАЛИИ

Широкая и повсеместная распространенность цитомегаловируса (ЦМВ) в природе, разнообразие путей и способов его передачи, способность вируса к длительной персистенции в организме хозяина и политропность приводят к практически тотальной инфицированности взрослого населения этим вирусом. Этиотропных средств борьбы с цитомегалией не найдено, поэтому проблема лечения данной инфекции остается актуальной.

Больная С. 1977 г.р. обратилась в нашу клинику с диагнозом цитомегаловирусная инфекция, осложненная привычным поздним выкидышем. В течение 2-х лет отмечалось два самопроизвольных выкидыша на 6-7 месяце беременности, плод с признаками гепатоспленомегалии, асцитом, анасаркой. Жалобы при поступлении на боли внизу живота ноющего характера, боли в пояснице, обильные гнойно-кровянистые выделения из половых путей. Тест на цитомегаловирусную инфекцию положительный (1:20). Анализ выделений: дрожжи, кокки в большом количестве. На УЗИ - хронический эндометрит, хронический аднексит, киста яичников.

Через десять дней терапии противовирусным, противовоспалительным и иммуностимулирующим излучателями, в сочетании с применением установки "СТ", клинические проявления заболевания исчезли. Повторный тест на цитомегаловирусную

инфекцию, проведенный через 2 недели после начала терапии, был отрицательным, на УЗИ матки и яичников признаков эхопатологии не выявлено.

Больная Б. 1976 г.р. обратилась с жалобами на постоянные ноющие боли внизу живота, болезненные менструации, субфебрильную температуру тела, обильные гнойные выделения из половых путей, учащенные мочеиспускания с неприятными ощущениями.

Из анамнеза: больна в течение 2-х лет, неоднократно получала медикаментозную терапию, без эффекта.

При обследовании установлен диагноз - хронический кольпит, уретрит, двухсторонний аднексит. Лабораторные данные: кровь на цитомегаловирус положительная; анализ выделений: выраженный лейкоцитоз, обнаружены хламидии, стафилококки, дрожжевые грибки.

Курс лечения составил 24 сеанса. Применялись противовирусный, антибактериальный и противовоспалительный излучатели. Также проводилась коррекция иммунитета, нормализация состояния симпатической и парасимпатической нервной системы.

В результате проводимого лечения на 7 день отмечалась нормализация температуры тела, исчезновение боли на 10 день, значительное уменьшение выделений из половых путей на 15 день. При повторном обследовании цитомегаловирус в крови не обнаружен. В анализе выделений лейкоциты в пределах нормы, хламидии не обнаружены, стафилококки и дрожжевые грибки в незначительном количестве.

ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОХОНДРОЗА МЕТОДОМ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ

Любая интоксикация, будь она связана с инфекцией, токсинами, ионами металлов, газами, стрессом и т.д., приводит к нарушению кровотока и гормональному дисбалансу. В первую очередь этот процесс затрагивает позвоночник. Невозможность транспортировки пластических и энергетических материалов, а также кислорода в клетки, органы и ткани, приводит к гипоксии мозга и особенно его коры, что в свою очередь вызывает нарушение системы управления, питания, эвакуации продуктов распада из органов. Патологический

процесс в позвоночнике приводит к сдавлению нервных волокон и расстройству иннервируемых ими органов.

Заболевания позвоночника, приводят к поражению многих органов и систем, отсюда и становится ясной роль восстановления его нормальных функций для лечения и профилактики многих болезней.

Среди заболеваний позвоночника на первом месте стоит остеохондроз, наиболее часто поражающий пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Причиной такой избирательности, вероятно, служит эволюция анатомии человека (прямоходящий), приведшая к повышенной нагрузке именно на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Нагрузки усугубляются еще и подъемом тяжестей, адинамией, нерациональным питанием.

В научно медицинском центре "Kamolot-Salomatlik" зарегистрировано 80 клинических случаев остеохондроза, как основного заболевания, так и в качестве сопутствующей патологии. 62% всех исследованных больных составляли больные с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника.

При исследовании по методу электроакупунктурной диагностики Фолля, у больных наиболее часто наблюдались отклонения на меридианах нервной системы, кровеносных сосудов, толстого и тонкого кишечника, печени.

При лечении остеохондроза методом резонансной терапии узкоспектральными керамическими излучателями нами преследовались следующие цели: снятие воспалительного процесса, нормализация обменных процессов и кровообращения на пораженном участке позвоночника. Одновременно с ИК-терапией проводится массаж позвоночника по паравертебральным линиям. Эта процедура ускоряет нормализацию кровотока на пораженном участке позвоночника, приводит к размягчению межпозвоночных дисков и эвакуации продуктов распада. Также нами проводилась коррекция работы кишечника, желчного пузыря, поджелудочной железы для нормализации обменных процессов в организме.

В результате проводимой терапии у больных с пояснично-крестцовой формой заболевания боль и ограничение подвижности исчезали, как правило, на 3-5 день терапии, у больных с поражением шейно-грудного отдела позвоночника данные симптомы исчезали в среднем на 7-10 день лечения. Курс лечения остеохондроза в среднем составил у всех больных 14 дней.

Наблюдения в течение 8 месяцев показало, что повторных обращений в исследуемой группе больных, с обострением данной патологии, до настоящего времени не было.

Таким образом, можно сделать вывод, что метод резонансной терапии керамическими узкоспектральными излучателями может быть успешно применен для лечения остеохондроза.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЗКОСПЕКТРАЛЬНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ В ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИЙ

Наиболее частыми возбудителями пневмонии являются бактерии, вирусы, микоплазмы, хламидии, грибы и пр. Учитывая, рост числа микроорганизмов, приобретающих устойчивость к антибактериальным препаратам, отсутствие этиотропных противовирусных средств, частые аллергические реакции на медикаменты, очень актуальны поиски новых методов лечения пневмонии.

В НМЦ "Kamolot-Salomatlik" для лечения пневмоний успешно применяется метод резонансной терапии керамическими узкоспектральными излучателями.

Под наблюдение находилось 16 больных с диагнозом острая очаговая пневмония и 1 больной с диагнозом острая крупозная пневмония; из них у 90% больных отмечалось повышение температуры тела, у 60% ДН I степени, у 10% - ДН II степени, 90% больных отмечали головную боль, в 100 % случаев отмечалась слабость. Аускультативно у 100% больных в легких отмечались крепитирующие и звучные (консолидирующие) постоянные мелкопузырчатые хрипы; у 90% больных наблюдалось укорочение перкуторного звука. При рентгенологическом обследовании у всех больных выявлялись очаговые и инфильтративные тени, усиление прикорневого и легочного рисунка.

При лечении пневмонии бактериальной этиологии, нами использовались излучатели GI и AF, обладающие антибактериальным и противовоспалительным действием. Время воздействия излучателей составляло от 45 мин до 1,5 часов в зависимости от состояния больного. Средняя продолжительность лечения составила - 10-12 дней.

При лечении пневмонии вирусной этиологии использовался излучатель RV, обладающий антивирусным действием. Средняя продолжительность лечения составила - 8-10 дней.

Для нормализации кровообращения в легких локально использовались излучатели серии Z, также применялись излучатели серии К для стимуляции иммунитета и регуляции состояния вегетативной нервной системы.

В результате терапии, у всех больных, симптомы интоксикации исчезли на 3-й день лечения, аускультативная и перкуторная нормализация отмечалась на 8-10 день лечения.

Таким образом, вышеприведенные наблюдения позволяют рекомендовать метод лечения узкоспектральными инфракрасными излучателями как безмедикаментозный метод терапии пневмоний.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЕТОДОМ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ УЗКОСПЕКТРАЛЬНЫМ ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

В отделении физиотерапии Навоийской областной больницы проводилось лечение больных бронхиальной астмой и хроническим бронхитом с применением узкоспектрального инфракрасного излучения.

Под наблюдением находилось 5 больных хроническим бронхитом с астмоидным компонентом, в том числе мужчин-1, женщин-4. Возраст больных от 25 до 50 лет.

Исследования до лечения: флюорография грудной клетки - корни уплотнены, общий анализ крови: гемоглобин 90,2 ± 2,5; лейкоциты 4,8 ± 0,90; СОЭ15,2 ± 2,3 мм/ч.

Проводимое лечение включало воздействие на грудную клетку излучателями ZB по 5 - 15 минут и GI по 5-15 мин; в виде общего воздействия применялись излучатели GI по 20-30 мин и KL по 5-10 мин

Начиная со 2-3 процедуры лечения узкоспектральными ИК-излучателями, наблюдалась положительная динамика: уменьшение кашля с выделением мокроты и удушья, нормализация сна, уменьшение общей слабости, улучшение общего самочувствие; аускультативно отмечалось уменьшение числа сухих свистящих хрипов в легких.

После окончания лечения больные отмечали исчезновение кашля, удушья, хрипы в легких не выслушивались. Повторный анализ крови показал повышение гемоглобина 110,2 ± 3,2 г/л и снижение СОЭ 8,5 ± 0,5мм/ч.

При наблюдении в течение последующих 6 месяцев рецидивов заболевания у данных больных не отмечалось.

Больной 45 лет с диагнозом правосторонняя нижнедолевая пневмония поступил к нам в клинику с жалобами: на кашель с выделением мокроты, боли в грудной клетке, общую слабость, потерю аппетита. Аускультативно в легких на фоне ослабленного везикулярного дыхания выслушивались сухие и влажные хрипы. На рентгенограмме грудной клетки обнаружено затемнение слева. Общий анализ крови: лейкоциты - 8,0: СОЭ 15 мм/ч.

Больному локально воздействовали излучателем GI на подлопаточную область справа; для процедур общего воздействия применялись излучатели: GI по 30-40 мин, ZB по 20 мин и KL по 10 мин

На 10 день проводимой терапии отмечалось исчезновение клинических симптомов заболевания и нормализация лабораторных показателей.

Под наблюдением в нашей клинике находилось 2 больных с гипертонической болезнью в возрасте от 40 до 60 лет. До лечения артериальное давление 190-200/110-120 мм рт ст. Потромбиновый индекс 96,5. На ЭКГ у обоих больных отмечалась гипертрофия левого желудочка.

Больным проводилась терапия излучателем ZB, в виде общего воздействия в течение 10 мин, и локального - на область шейного отдела позвоночника в сочетании с легким массажем в течение 5 мин. Излучатель GI в виде общего воздействия применяли в течение 15 мин, локального - на область почек по 5 мин; KL общее назначали по 10 мин в день

После лечения у обоих больных отмечалось улучшение общего состояния, уменьшились головные боли. Артериальное давление снизилось до 150-140/80-75 мм рт.ст.

Мы проводили лечение 5 больных хроническим простатитом в возрасте от 25 до 40 лет. У всех больных отмечались боли в пояснице, частое мочеиспускание, снижение эрекции, преждевременная эякуляция, раздражительность, бессонница, головные боли. Общий анализ мочи - лейкоциты 15-16 ± 2 в поле зрения, секрет простаты - лейкоциты 14 ± 1. УЗИ - эхокартина хронического простатита.

Лечение проводилось общими и локальными излучателями. Общие процедуры: GI 20 мин, ZB - 15 мин, KL - 10 мин. Локально на область промежности воздействовали излучателями GI и KL по 5-10 мин.

После 10 дневного курса лечения у всех больных нормализовалось мочеиспускание, исчезли боли в пояснице, нормализовался сон, отмечалось усиление эрекции, в анализах мочи и секрета простаты уменьшилось количество лейкоцитов.

На основании приведенных выше данных можно судить о возможности использования метода резонансной терапии узкоспектральными ИК-

излучателями при лечении заболеваний органов дыхания, гипертонической болезни, хронического простатита.

ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ, ПРИМЕНЕНИЕ ЕГО ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

Известно, что инфракрасное излучение стимулирует окислительно-восстановительные процессы, усиливает периферическое кровообращение и ферментативные процессы, активизирует систему гипофиз - кора надпочечников, оказывает десенсибилизирующее и противовоспалительное действия, повышает иммунитет. Однако применение в традиционной медицине ИК-излучения с широким спектром действия приводит к перегреву организма в результате преобладания процессов поглощения над процессами излучения и наоборот. В связи с этим его использование противопоказано в острый период воспалительных заболеваний. Керамические узкоспектральные инфракрасные (ИК) излучатели не оказывает подобного отрицательного действия в связи с тем, что их излучение имеет селективную длину волны, не приводящую к перегреву организма. Учитывая вышеизложенное, целью настоящей работы явилось изучение эффективности узкоспектрального ИК-излучения при лечении различных патологических состояний, как у детей, так и у взрослых.

Нами проанализировано лечение при помощи узкоспектрального ИК-излучения 353 больных с различными заболеваниями, из них 266 детей и 87 взрослых. Всем пациентам наряду с традиционной терапией проводилось воздействие узкоспектральным ИК-излучением, 1 раз в сутки в течение 3-8 дней, с расстояния 35-40 см, при помощи эмиттера GI - по 20-30 мин и KL по 5-10 мин.

Применение узкоспектрального ИК-излучения в комплексном лечении острых бронхолегочных заболеваний (62% наблюдаемых больных) способствовало их более легкому течению. Наблюдения показали, что клиническое улучшение наступало на 2-3 день лечения бронхита и на 3-4 день лечения пневмонии: быстрее исчезали явления интоксикации, одышка, кашель, тахикардия, восстанавливался сон и аппетит, отмечалась нормализация температуры. В отношении лабораторных показателей мы отметили параллелизм положительной динамики клинического течения и результатов анализов. Анализ рентгенологических исследований у 50 больных острой пневмонией к 10 дню терапии показал улучшение рентгенологической картины.

Следует отметить, что применение узкоспектрального ИК-излучения в комплексном лечении острых бронхолегочных заболеваний снижает частоту

перехода острого бронхита и пневмонии в затяжное и хроническое течение, а также количество вторичных осложнений: абсцессы, плевриты и др. Эти данные указывают на целесообразность включения узкоспектрального ИК-излучения в комплекс лечения острых бронхолегочных заболеваний.

Положительный терапевтический эффект ИК-терапии наблюдался при лечении больных с хронической пневмонией и бронхиальной астмой. Наблюдения показали быстрое уменьшение, а в некоторых случаях исчезновение клинических проявлений заболеваний.

Большую группу больных в нашей практике составляли пациенты с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей: флегмона, абсцесс, панариций, инфильтраты после внутримышечных инъекций ягодичной области. В большинстве случаев хирурги прибегают в таких случаях к оперативному вмешательству, которое лишь удлиняет сроки лечения, что требует дополнительных материальных расходов. Применение узкоспектрального ИК-излучения в фазе инфильтрации этих процессов позволяет купировать очаг воспаления после 2-3 сеанса, а при флегмоне и панариции после 4 - 5 сеансов очаг гнойного воспаления разрешается, при этом удается полностью избежать хирургического вмешательства. Также нужно отметить, что нам удалось ускорить заживление раневого процесса после вскрытия больших флегмон и после аппендэктомии у больных сахарным диабетом (незаживающие раны более 1- 1,5 мес.).

Узкоспектральное ИК-излучение применялось нами при лечении трофических язв. После 10-12 процедур у 2-х детей с трофическими язвами в области подошвы, отмечалось полное разрешение патологического процесса.

Высокоэффективным было использование ИК-излучения после ошибочного подкожного введения 10% хлористого кальция. Болевой синдром, отек мягких тканей и другие проявления уменьшились после 1-2 сеанса, а на 3-4 сутки процесс полностью купировался. Несмотря на выраженную положительную динамику в лечении, мы продолжали терапевтическое воздействие ИК-излучения до 5-6 процедур.

В последние годы увеличивается число больных экссудативно-катаральным диатезом с различными степенями опрелостей, особенно у грудных детей. При данной патологии узкоспектральное ИК-излучение по эффективности намного превосходит все остальные методы лечения. На 2-3 день ускоряется процесс эпителизации у больных с 1-2 степенью опрелости, а в течение 4-6 дней у больных с опрелостями 3 степени.

Мы использовали узкоспектральное ИК-излучение при лечении 15 больных с грибковым поражением кожи. Уже в первый день терапии выявлен положительный эффект антимикотического действия излучения. Курс лечения грибковых поражений кожи составлял в среднем от 3 до 6 процедур.

В целом наш опыт показывает, что ИК-терапия в комплексе с традиционным лечением не только не ухудшает состояние больных в остром периоде гнойно-воспалительных процессов, а напротив способствует их более благоприятному течению.

Таким образом, предложенный метод терапии острых и хронических заболеваний бронхолегочной системы, острых гнойновоспалительных заболеваний кожи и подкожно жировой клетчатки, незаживающих ран и трофических язв, а также микотических поражений кожи, можно считать высокоэффективным.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ СПАЕК В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Профилактика образования спаек между органами брюшной полости является одним из сложных вопросов абдоминальной хирургии. Ограниченный спаечный процесс в большинстве случаев не приводит к неблагоприятным последствиям. Однако в ряде случаев отмечается избыточное образование спаек, которые приводят к острой кишечной непроходимости, что требует проведения повторных оперативных вмешательств.

Одним из современных и наиболее перспективных методов физического воздействия на репаративные процессы является узкоспектральное инфракрасное излучение (ИК) керамических излучателей. Керамические излучатели обладают антибактериальным и противовоспалительным действиями. Однако литературных данных по исследованию их влияния на процесс образования спаек нет. В связи с вышеизложенным, с целью изучения влияния ИК излучения на развитие спаечного процесса (СП) в брюшной полости мы провели экспериментальные исследования на белых беспородных крысах-самцах. Животных разделили на 3 группы: I группа - здоровые (интактная), II-животные с воспроизведением СП, III - с воспроизведением СП + ИК излучение. Каждая группа состояла из 8-16 особей. СП воспроизводили по общепризнанному методу: механическим травмированием париетальной и висцеральной брюшины (Swolin K., 1966) На 3, 7, 14 и 21 сутки после воспроизведения СП животных под легким наркозом забивали методом мгновенной эвтаназии. При вскрытии животных развитие СП в брюшной полости

оценивали в трехбалльной системе по методу David A. Colasante et al [1981]. С помощью излучателя ЗК (мощность 10 мВт) ИК-излучение направляли на область живота в течение 7 суток послеоперационного периода. Содержание белково-связанного оксипролина (БОП) в плазме крови, как критерия интенсивности новообразования соединительной ткани в организме, определяли в динамике на 3, 7, 14 и 21 сутки по общепринятой методике Осадчук М.А., Капустин В.М.

Результаты исследований показали, что при облучении области живота ИК-излучением на 21 сутки опыта в этой группе наблюдается значительное снижение частоты случаев спайкообразования, оцениваемых в 3-2 балла и возрастание величины этого показателя в 1 балл по сравнению с животными II группы, не получавших эту процедуру ($P<0.02$). Общая частота развития СП в II группе составила 100%, а в III группе после проведения метода профилактики снизилась на 37,5%. При оценке показателя эффективности лечебного действия следует отметить, что среднее значение всех измеряемых показателей во II группе составило 2,81±0,02 баллов, в то же время в III группе, где проведено облучение с помощью ИК излучения снизилось на 62,3% ($P<0,02$), по сравнению с таковым показателем во II. Следовательно, наиболее эффективным методом, направленным на снижение СП в брюшной полости в наших исследованиях является включение в профилактический комплекс узкоспектрального ИК излучения.

Максимальное значение уровня БОП в плазме крови во II группе отмечается на 3 сутки, а затем этот показатель постепенно снижается. В III группе наблюдается аналогичная картина нарастания уровня БОП в динамике крови животных со спайкообразованием. Однако по сравнению со II группой уровень БОП в плазме в III группе находился статистически достоверно ниже.

При оценке показателя зависимости уровня БОП от степени тяжести развития в брюшной полости процесса спайкообразования отмечено, что чем сильнее СП в баллах, тем выше уровень определяемой в плазме крови исследуемой аминокислоты. Так у животных, с сильным СП оцененным в 3 балла, уровень БОП в плазме крови составил 9,21±0,72 мкг/мл, у животных с умеренным СП в 2 балла - 7,89±0,54 мкг/мл, со слабым в 1 балл - 6,75±0,52, которые статистически достоверно превышали уровень контроля. Следовательно, у животных с выраженным развитием спайкообразования наблюдается значительное нарастание уровня БОП в плазме крови, что может служить важным вспомогательным критерием для оценки СП у больных, перенесших хирургические операции на органах брюшной полости.

Таким образом, узкоспектральное ИК излучение значительно снижает частоту и тяжесть развития СП в брюшной полости, и уровень БОП в плазме крови. Показатель уровня БОП в плазме крови может быть важным дополнительным критерием для оценки выраженности спаечной болезни у больных, перенесших операции на органах брюшной полости.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИК-ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ В ПРАКТИКЕ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Разработка эффективных средств восстановления, способствующих поддержанию высокой физической работоспособности спортсменов, препятствующих возникновению различных отрицательных последствий больших физических нагрузок, является актуальной проблемой спортивной медицины.

Под наблюдением находилось 18 спортсменов высокой квалификации: 10 футболистов играющих в клубах высшей лиги и члены сборных юношеской (2), молодежной (4) и взрослой (2) команд Узбекистана по теннису.

При применении ИК-излучателей в соответствующих режимах отмечены:

1. Противовоспалительный и рассасывающий эффекты у спортсменов: с типичными инфекциями кожных покровов (6) (инфицированные мозоли, фурункулы); с типичными повреждениями кожных покровов (7) (ссадины лица, тела, конечностей; подкожные гематомы); с растяжением сумочно-связочного аппарата локтевого (2), коленного (2) суставов; бурситом в области пяточной кости (2), локтевого отростка (1); с плечелопаточным периартритом травматического генеза (1).
2. Повышение сопротивляемости организма вирусным инфекциям у спортсменов с клиническими симптомами снижения иммунитета (частые обострения хронического тонзиллита (4), частые ОРВИ (3)) в соревновательном периоде.
3. Нормализация сна и устранение вегетативных расстройств у спортсменов с функциональными расстройствами нервной системы (4), возникшими в результате хронического физического перенапряжения.
4. Устранение симптомов болевого печеночного синдрома у спортсменов (4), возникшего в результате больших физических нагрузок в тренировочном и соревновательном периодах
5. Рассасывающий эффект у 1 спортсмена с посттравматической кистой нижней губы.

6. Отсутствие отрицательного влияния ИК-излучения на уровень физической работоспособности, показатели функционального состояния и тренированности спортсменов, и их спортивные результаты.

Приведенные данные указывают на возможность включения ИК-излучателей в комплекс медико-биологических средств восстановления и лечения спортсменов в соревновательном и тренировочном периодах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕТОДОМ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ УЗКОСПЕКТРАЛЬНЫМИ ИНФРАКРАСНЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

Проводилось лечение методом резонансной терапии узкоспектральными инфракрасными излучателями 153 больных (из них 55 больных с ОРВИ, 40 - с острым бронхитом, 40 - с хроническим тонзилитом, 12 - с хроническим бронхитом, 1 - с сахарным диабетом, 1 - с лейшманиозом, 2 с витилиго и 2 с острым пиелонефритом).

В зависимости от заболевания, воздействие проводилось как общими, так и локальными ИК-излучателями с противовоспалительным и антибактериальным, противовирусным, нормализующим микроциркуляцию и обменные процессы эффектом. Также использовались излучатели, действие которых направленно на повышение иммунитета. Время воздействия подбиралось индивидуально в зависимости от состояния больного.

Наблюдения показали, что при лечении узкоспектральными инфракрасными излучателями ОРВИ улучшение состояния наблюдалось у всех больных на 3±2 день терапии, на 7±2 день отмечалось полное выздоровление.

У больных с острым бронхитом выздоровление наступало в среднем на 7-10 день, у больных с хроническим бронхитом после 2 курсов терапии отмечалось значительное улучшение состояния.

У больного с сахарным диабетом II, осложненным трофической язвой верхней трети правой голени, через неделю после начала терапии отмечалось улучшение кровообращения в конечности, прекратились гнойные выделения из язвы, исчезли отек и гиперемия, улучшилось общее состояние больного, полное рубцевание язвы наступило на 22 день терапии.

При лечении лейшманиоза с локализацией очага поражения на спинке носа, через неделю после начала терапии спал отек, исчезла гиперемия, уменьшилось гнойное отделяемое.

У больных с острым пиелонефритом клиническое улучшение и нормализация лабораторных показателей стали наблюдаться с 10 дня терапии, полное выздоровление отмечалось на 22 день.

В результате месячного курса лечения больных с витилиго отмечалось уменьшение размеров депигментированных очагов в среднем на 2 мм.

У всех 40 больных хроническим тонзилитом полная ремиссия заболевания отмечалась в среднем на 7 день

Таким образом, полученные результаты показывают возможность применения узкоспектральных ИК-излучателей, для лечения различных заболеваний, как в комплексе с традиционными методами терапии, так и как альтернативный метод лечения.

НЕКОТОРЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

(Клинические случаи 1998-1999 г.г.).

Результаты предоставлены доктором Завави Абдулла, Медицинский Университет, Малайзия.

1. Рак мочевого пузыря
2. Рак легких с метастазами
3. Гипертония
4. Двусторонние варикозные язвы на ногах
5. Болезнь Бургера
6. Псориаз
7. Опухоль яичника и псориаз
8. Киста яичника
9. Нарушение эрекции при диабете II типа
10. Диабетическая язва на ноге
11. Диабетическая гангрена большого пальца ноги
12. Гипоксия головного мозга
13. Гипоксия головного мозга
14. Дискомфорт в икроножной мышце и хроническая сонливость
15. Заболевание двигательного нейрона
16. Спондилолистез
17. Синдром канала запястья
18. Боль в месте прикрепления Ахиллова сухожилия
19. Отравление медикаментами

20. Эффект ИК-излучения на пациента, принимавшего рифампицин (rifampicin)
21. Отравление несколькими химикатами
22. Детский аутизм
23. Бронхиальная астма
24. Хроническая почечная недостаточность
25. Хроническая почечная недостаточность
26. Хроническая почечная недостаточность
27. Нефротический синдром с нарастающими отеками
28. Атония мочевого пузыря
29. Тики (моргание)
30. Болезненный шрам от ожога соляной кислотой
31. Гипергидроз
32. Боль в икроножной мышце
33. Седина
34. Ишемическая болезнь сердца
35. Воспаление подкожно-жировой клетчатки при СПИДе
36. Воспаление подкожно-жировой клетчатки (или рыхлой соединительной ткани) под ногтем
37. Воспаление подкожно-жировой клетчатки большого пальца
38. Воспаление Ахиллова сухожилия
39. Колики в животе и диарея
40. Кашель, сопровождающийся рвотой при врожденном пороке сердца
41. Выпадение волос вследствие химиотерапии
42. Мигрень
43. Мигрень
44. Мигрень с гипертонией
45. Длительное срастание перелома бедренной кости
46. Диабетическая ретинопатия
47. Обострение хронического подагрического артрита
48. Инсулинозависимый сахарный диабет
49. Диплопия миастения гравис
50. Серонегативный артрит
51. Серонегативный артрит
52. Повышенное содержание холестерина и липидный дисбаланс
53. Тиреотоксическая кардиомиопатия
54. Системная красная волчанка

55.Реваскуляризация роговицы из-за контактных линз

1. Рак мочевого пузыря. ***Больной R S.,*** 53 года, мужчина. Диагноз: Рак мочевого пузыря и TURP поставлен за год до начала лечения резонансной терапией (РТ) с использованием ИК. За 9 месяцев до РТ при проведении внутривенной урографии (IVU) выявлен двухсторонний гидронефроз, но пациент от операции отказался. Симптомы - недержание мочи (моча постоянно капает), блокируется уретра при мочеиспускании из-за фиброзного осложнения TURP (скопическая операция), что причиняет боль в основании уретры при попытке мочеиспускания, постоянно нужно массажировать уретру. Иногда тупая боль в надлобковой области, продолжающаяся от нескольких часов до целого дня в течение нескольких месяцев.

Ультразвуковое исследование до начала РТ показало двухсторонний гидронефроз и утолщение задней стенки мочевого пузыря. РТ проводилась ежедневно в течение 3 недель. В основном использовались излучатели RC, ZB на мочевой пузырь. УЗИ было повторено через 14 дней - гидронефрита нет, утолщение стенки все еще без изменений.

Недержание мочи в виде капания постепенно прекращалось, начиная с 10-го дня и почти полностью исчезло после 20 сеансов терапии за 2 месяца.

Боль при мочеиспускании из-за блокирования уретры также уменьшилась и по его оценке облегчение примерно на 60% (более чем 50%) после 20-го сеанса лечения.

Абсолютно никаких побочных симптомов и признаков.

Он чувствует себя хорошо и не продолжил лечение после 20 сеансов. Причиной этому послужило дальнее расстояние (60 км), а больной пользуется общественным транспортом и у него финансовые трудности чтобы добраться до клиники.

Заключение: РТ дала симптоматическое облегчение вышеописанному пациенту с раком мочевого пузыря.

2. Рак легких с метастазами. ***Больной О.Н.А.***, 65 лет, мужчина, бывший курильщик в течение 40 лет.

Обратился с жалобами на боль в позвоночнике на уровне лопатки и боль в левом бедре. Боль тупая, усиливающаяся за последние два месяца. В течение того же времени у него возникли прогрессирующие трудности при мочеиспускании и самостоятельной дефекации, из-за отсутствия позывов и способности тужиться). Раз в 4-5 дней вынужден принимать слабительное или

делать клизму. Больной также не может чувствовать и контролировать мочеиспускание, поэтому потребовался катетер с 4-часовым испусканием.

Все симптомы медленно ухудшались в течение двух месяцев. Он не может ходить, но в состоянии стоять с опорой. Большинство болеутоляющих препаратов не снимают боль полностью.

Биохимический анализ крови и гематологический профиль - в норме.

Рентген грудной клетки: одно обширное поражение, выступающее за левую сердечную тень, другое расположено на левой боковой средней доле легкого, предположительно с метастазами.

Ультразвук: Фокусных поражений в печени нет, почки нормальные, простата увеличена. Компьютерная томограмма головы показала множественные обширные поражения в мозговой оболочке.

Ядерно-магнитный резонанс спинного мозга: измененный сигнал костного мозга в цервикальном, грудном и поясничном отделах, а также в области крестца на многих уровнях. На позвонке T III имеется патологический компрессионный перелом, который связан с паравертебральной массой, которая простирается от T I до T V и эпидуральной массой от T II до T IV, что создает компрессию позвоночника.

На уровне S II имеется другая большая опухоль посередине и с левой стороны, которая сужает крестцовый спинной канал и, по-видимому, задевает нервные окончания крестцового сплетения с левой стороны.

Все это появилось, в основном, из-за метастатических поражений.

На основании всех симптомов поставлен диагноз рак легких с метастазами в легкие, грудной отдел, крестец и мозговую оболочку.

Больному рекомендовали пройти радиотерапию, но он искал альтернативу и когда услышал о лечении с использованием особого ИК-излучения по методу Рахимова, решил попробовать это лечение. В его случае радиотерапия не была еще проведена. После разъяснения, что так называемый излучатель RC имеет эффект рекомбинации радикалов с высокой энергией активацией и, по теории, может снизить или остановить рост, с или без симптоматического облегчения, он пожелал попробовать лечение. Его лечили в течение 14 дней, в основном с использованием RC, GI и ZB с непродолжительной экспозицией.

Результат: Результат был ошеломляющий, заметное симптоматическое облегчение. Через 3 дня наступило полное избавление от боли в крестцовом отделе позвоночника. Основной проблемой была боль в левом бедре, которая через 10 дней уменьшилась и больше не появлялась. Через 7 дней процесс

дефекации восстановился (1 раз в два дня), а через несколько дней стул-ежедневно. Мочеиспускания также стали самостоятельными и катетер был удален. Может ходить на короткие расстояния. Выписан из больницы, и рекомендовано продолжать лечение 4 видами излучателей (RC, GI, ZB, KL) в домашних условиях. Далее, через 10 дней, больной смог ходить с тростью, и выглядел очень счастливым. Еще через 2 недели (т.е. через 3,5 недели после выписки) он пришел без трости. До лечения ему была предписана инвалидная коляска. Все симптоматические улучшения поддерживались в течение одного месяца. Он прекратил лечение, когда излучатель, по его мнению, больше не оказывал никакого эффекта. Неделей позже ногу опять парализовало, и появилась боль в крестцовом отделе позвоночника. Больной пришел на лечение и получил обработку излучателем RV. После одного сеанса боль заметно уменьшилась и осталась на том же уровне.

Комментарии: Теоретически лечение может остановить рост рака. У некоторых пациентов ожидается симптоматическое облегчение, когда иммунная система организма сама восстановила нормальные обменные процессы в очаге поражения, особенно после излучателя ZB, который играет способствует рассасыванию опухоли до определенного предела, и улучшает кровообращение. Чем лучше клиническое состояние и функции органов, тем эффективнее результат мы можем ожидать, потому что лечение, в этих случаях может проводиться без помех., У больных, не проходивших радио- и химиотерапию, мы ожидаем лучший клинический результат. Этот метод терапии может быть использован в качестве симптоматической терапии онкологических больных.

3. Гипертония. ***Больной Z.***, 40 лет, мужчина

Гипертония в течение пяти лет принимает nifedipine 10 mg в таблетках. Масса тела повышена, вес 109 кг. Ежедневно делает упражнения и соблюдает диету. Однако избыточный вес и АД не поддаются контролю.

АД было между 140-150/90-100.

Прошел лечение РТ, в основном с использованием излучателей RV, GI, ZB. Пройден месячный курс, затем раз в неделю в течение еще одного месяца и далее раз в две недели, еще несколько сеансов.

После месячного лечения вес снизился до 95 кг, хотя до этого ему очень трудно снизить вес, несмотря на соблюдение диеты.

АД контролировалось лучше, больной снизил дозу Nifedipine до 5 mg через неделю и затем полностью прекратил принимать медикаменты после 3 недель

терапии. АД стабилизировалось на уровне 120-130/70-80 без приема медикаментов. Вес также сохранялся, с продолжением регулярных упражнений и диетой.

Вес больного продолжал снижаться и через два месяца после начала РТ составил 90 кг. Он больше не продолжает лечение, однако, вес тела, АД и липидный обмен остаются нормальными и поддерживаются на нормальном уровне в течение года (на момент описания данного клинического случая).

Ни одного побочного симптома не наблюдается.

Комментарии:

Резонансная терапия эффективна для снижения веса тела. Такой же феномен наблюдался у 20 % пациентов.

Из-за снижения веса лучше контролируется гипертония.

Возможность излечения гипертонии, с хорошим побочным эффектом снижения избыточного веса.

4. Двухторонняя варикозные язвы на ногах**.** ***Больная R.***, 34 года, женщина. Жалобы: на безболезненные хронические рецидивирующие язвы на ногах и венозный застой с двусторонним отеком в течение 4-х лет, продолжающимися в течение 2-х лет до начала РТ. Больная вынуждена находиться дома, длительное стояние и ходьба причиняет дискомфорт и усиливает отек в области голеней. Она обрабатывала раны обычным физиологическим раствором, при этом размер язв не менялся. До начала лечения на переднемедиальной поверхности голеностопного сустава справа язва размером 4,5 х 2,3 см, на левом голеностопном суставе на переднемедиальной поверхности язва 3 х 4 см.

Лечение: 25 раз. В основном применялся излучатель на область язвы.

Язва заживала очень хорошо и отеки заметно уменьшались, так что больная могла долго стоять и ходить. Чувство дискомфорта в ногах почти незаметно, и нет ограничений по продолжительности нахождения на ногах.

После 25 сеансов лечения размер язвы справа уменьшился до 1,4 х 1,0 см, слева язва полностью эпитализировалась. Лечение продолжалось раз в неделю в течение месяца до полного излечения.

Побочных эффектов нет.

Комментарии: Излучатель ZB влияет в основном на нормализацию состояния кровеносных сосудов за счет удаления патологического коллагена с их стенок.

5.Болезнь Бургера**. *Больной 72 года, мужчина***. Хронический курильщик в течение 40 лет. Болезнь Бургера (облитерирующий тромбангиит). Отмечалась перемежающаяся хромота, обострение в течение нескольких месяцев, за 4 дня до начала лечения появилась острая боли в области голеней, вплоть до невозможности ходить, находился на постельном режиме, и даже при этом кричал при малейшем движении, в связи с чем, предписали инвалидную коляску. Но и после этого не мог перемещаться с инвалидной коляски на кровать и нуждался в посторонней помощи.

Больной осмотрен хирургом-ортопедом. При осмотре: пульсация в области arteria poplitea/ tibialis posterior, pedis dorsalis резко снижена, поставлен диагноз болезнь Бургера.

Больному проводилось лечение в основном излучателем ZB на область голеней. После 3-го сеанса отмечалось незначительное улучшение, но после 4-го сеанса терапии у больного почти полностью прошли боли, может ходить без боли на длительные расстояния. Так как он почувствовал себя хорошо, больной не захотел продолжать лечение и обещал вернуться, если будет рецидив.

Побочных эффектов или осложнений не наблюдается.

Комментарии: в данном случае отмечалось полное излечение болезни Бургера методом резонансной терапии.

6. Псориаз**. *Больная М.,*** 36 лет, женщина. Больна псориазом в течение 2-х лет.

Жалобы:

Псориатические высыпания на коже по всему телу

Рецидивирующая псориатическая артропатия, боль при движении, ограничение объема движения до 30%. Иногда не может ходить, осложнение и рецидив примерно в течение 1 недели 1 раз в месяц. Из-за резкого ограничения подвижности в коленных суставах, больная вынуждена мочиться стоя.

Сильные тупые боли в области лопатки справа в течение года. Хирург-ортопед считает, что эти боли псориатического характера.

Лечение: 34 сеанса

Результат: Кожные высыпания уменьшались с каждым днем. После 25 сеансов кожа полностью очистилась за исключением нескольких очагов на спине и голове. Боли в суставах уменьшились, объем движения увеличился до 60%, но движения все еще ограничены, не может полностью сесть на корточки.

После 30 сеансов терапии больная приходит два раза в неделю для дальнейшего лечения.

Две недели позже - дальнейшее улучшение. Кожа намного чище, особенно на руках и ногах, за исключением нескольких шрамов. Несколько очагов рецидива на голове. Боль в лопатке уменьшилась только на половину.

После дня отдыха от лечения замечено дальнейшее уменьшение болей в коленных суставах. Рекомендовано продолжать лечение дома несколькими излучателями для поддержания эффекта терапии, однако больная отказалась, при этом ремиссия продолжалась 8 месяцев, после чего отмечался рецидив.

Побочный эффект: сильные боли в суставах и явления простуды в течение 5 дней, из-за невозможности ходить была прикована к инвалидной коляске на 4 дня, но после этого смогла нормально ходить, более того, лучше, чем до начала лечения.

Комментарии: В данном случае достигнута почти полная ремиссия. Если бы больная продолжила лечение несколькими излучателями, возможно, можно было избежать рецидива, как это наблюдалось у нескольких других пациентов. В течение курса терапии, наблюдался побочный эффект в виде артралгии. Поэтому предлагается определить оптимальную продолжительность экспозиции или начать лечение с малой экспозиции и увеличивать по мере переносимости.

7. Киста яичника и псориаз. ***Больная Z.N.***, 42 года, женщина.

Жалобы:

Киста яичника и опухоль

Псориаз

Бесплодие

Основной причиной обращения является киста яичника и псориаз.

Анамнез: замужем 12 лет, но никогда не беременела. Проведено обширное обследование, с применением 7 общих анестезий для такого обследования, как лапароскопия и GIFT. Отказалась от дальнейшего обследования и искала альтернативный метод лечения кисты яичника. Кроме того, у больной имеются псориатические поражения на коже головы, туловища и конечностей, особенно, на сгибательных поверхностях, возникшие в течение 10 дней.

Гинекологом проведено УЗИ яичника до начала терапии. Диаметр яичника 3,5 см, однако, кроме кисты гинеколог обнаружил внутри яичника часть цельной структуры, поэтому был поставлен диагноз опухоль яичника. Та как неизвестна природа опухоли (доброкачественная или злокачественная), больной

предложено срочно пройти цитологическое исследование ткани. Она отказалась и захотела пройти курс ИК терапии.

Результат лечения: После 10 дней терапии тот же гинеколог повторил УЗИ, самый широкий диаметр опухоли был 3,1 см. Были предприняты попытки, измерить самый возможно большой диаметр, но вышел только этот замер. Таким образом, размер кисты уменьшился за 10 дней на 3 мм. К сожалению, больная не смогла продолжить лечение из-за работы. Псориатические поражения стали менее выраженными и более плоскими. Улучшение замечено сразу после второго дня терапии. Однако полное очищение кожи наступило через 10 дней, как и ожидалось.

Никаких побочных эффектов.

Комментарии: Так как больная не смогла продолжать лечение, рекомендовано дальнейшее наблюдение у гинеколога и придерживаться плана терапии наблюдающим врачом. Полный курс терапии не проведен, но есть уменьшение размера опухоли яичника.

8. Киста яичника**. *Больная S.N.,*** 43 года, женщина

История болезни: За четыре месяца до начала терапии поставлен диагноз киста левого яичника, размером 5 х 5 см. Планировалась операция, но больная решила отложить. Обратилась в клинику Infra Life. В основном применялись излучатели RC и ZB на яичник.

Продолжительность лечения составила 14 сеансов, почти ежедневно. Сразу после окончания 14 сеансов терапии, больная обратилась к тому же гинекологу и проведено повторное УЗИ.

Результат: Киста не обнаружена.

Ни единого побочного симптома или эффекта не наблюдалось.

Комментарии: Киста яичника является одним из доброкачественных образований, которые легко поддаются лечению, согласно опыта работы в Ташкенте. Пациентам с кистой яичника следует проходить лечение данным методом до хирургического вмешательства.

Недостатком метода является то, что не знаем наверняка, содержит ли киста также злокачественный рост. Если есть подозрение на злокачественность, данный метод в качестве единственной терапии не рекомендуется. Если опухоль злокачественная применяется больше излучатель RC и меньше ZB. В этом случае уменьшение размера опухоли займет больше времени.

9. Нарушение эрекции при диабете II типа**.** ***Больной S.***, 41 год, мужчина. Жалобы: В течение 2 лет страдает недостаточной эрекцией и отсутствием эякуляции.

История болезни: Диабет II типа, принимает Glibenclimide 5 мг. Женат 7 лет, но детей нет. Эрекция только раз в 2 недели, достаточная для начала полового акта, но не достаточная для его продолжения, и в большинстве случаев эякуляция не происходит и нет оргазма.

Лечение: Больной лечился 7 дней. После 4 сеанса проводимой терапии половой контакт стал возможен через день, с нормальной эрекцией и эякуляцией. Больной продолжал лечение 2 раза, а затем 1 раз в месяц в течение 3-х месяцев.

Уровень сахара в крови снизился с 8-11 ммоль /л до уровня нормы.

Повторное снижение эрекции отмечал после прекращения лечения через 8 месяцев, чувство онемения в области стоп не возобновилось, уровень сахара в крови сохраняется в пределах нормы.

После повторного курса терапии вновь отмечал улучшение потенции.

Ни единого побочного симптома или эффекта не наблюдалось.

10. Диабетическая язва на ноге. ***Больной А.Н,*** 41 год, мужчина, болен диабетом много лет, принимает glucophage, glibenclimide в таблетках.

Жалобы: на правой подошве незаживающая в течение 2-х лет безболезненная язва размером с монету, явления диабетической нейропатии.

Язва сохраняется в размере в течение 2-х лет. Больному было проведено иссечение и хирургическое очищение язвы от некротических масс, заметно заживление, но не полностью, рана оставалась открытой. Было предпринято наложение швов, но из раны продолжала сочиться жидкость. Каждый день обрабатывали обычным физраствором. Рана всегда чистая, но края уплотненные, размер не изменяется. Хирург-ортопед сделал z-образный разрез и ушил язву. Одновременно подключили резонансную терапию. Язва полностью зажила через две недели. После 2-х недель онемение и снижение чувствительности уменьшилось и немного осталось на пальцах ног. Лечение прекратили из-за того, что больной живет очень далеко и не может ездить на лечение. Общее состояние также заметно улучшилось.

Никаких побочных симптомов.

Комментарии: Действие ИК на диабетические поражения нижних конечностей заметно у многих пациентов, проходивших лечение данным

методом. Эффект заключается в улучшении кровоснабжения нижних конечностей.

11. Диабетическая гангрена большого пальца ноги**.** ***Больная М.***, 54 года, женщина, больна диабетом более 10 лет, принимает сахаропонижающие препараты в таблетках.

Месяц назад в области первого пальца стопы появилась трофическая язва, перешедшая в гангрену с воспалением подкожно-жировой клетчатки по периферии. Хирургом была предложена операция с удаление всей стопы, и возможно, если будет плохая циркуляция в области голеней до подколенной ямки. Больная от операции категорически отказалась. Начато лечение ИК-излучателями. На область пораженной конечности воздействовали излучателями GI и RV по 10-20 минут 2 раза в день, ZB назначили по 3-5 минут на третий день лечения 2 раза в день на очаг поражения и на область голени по 10 минут 2 раза в день.

На область поджелудочной железы KL-s по 5 минут в двух проекциях.

В результате проведенной терапии у больной появились чувство боли (до начала терапии больная боль в области пораженной конечности не чувствовала), явления воспаления вокруг очага гангрены значительно уменьшились. Ампутация была ограничена очагом гангрены, т.к. циркуляция в сосудах голени и стопы была нормальной. Побочных эффектов не замечено.

Комментарии: Для всех пациентов с диабетическим поражением нижних конечностей применяются излучатели GI и ZB (GI убивает патогенные бактерии, а ZB улучшает микроциркуляцию). Лечение следует начинать как можно раньше, с увеличением экспозиции до 40-60 минут три-четыре раза в день. Если клиническая картина хорошая, оперативное вмешательство можно отложить. Делаются обычные обработки и хирургическое удаление некротической ткани.

12. Гипоксия головного мозга. ***Больная 33 года***, женщина

После родов у больной была остановка сердца на 10 мин. При помощи реанимационных мероприятий работа сердца была восстановлена, но острое нарушение мозгового кровообращения осталось. Это произошло 13 месяцев до начала РТ.

Больная была в вегетативном состоянии. Наблюдается спастическая контрактура конечностей, ноги абсолютно неподвижны. Нет реакции на обращение. Кормление через трубку, т.к. жевание и глотание очень замедленно.

Проводилось лечение ИК-излучателями два раза в день в течение месяца. Основной используемый излучатель - ZB на голову, суставы и позвоночник.

Замечены следующие улучшения:

Может жевать и глотать в 4 раза быстрее.

Больше протягивает руки

Все суставы расслаблены, легче проводить физиотерапию

Пальцы ног двигаются, при легком поглаживании бедра, больная двигает ногой, чего не происходило в течение прошедших 13 месяцев.

Она моргнула после того, как ее муж попросил моргнуть, чтобы показать, что она понимает инструкции. Улыбается, когда слышит обращенные к ней слова.

После месяца лечения не смогла продолжать.

Комментарии: Лечение дало частичное улучшение, даже после года с момента возникновения заболевания. Для получения лучшего результата рекомендовано начинать терапию как можно скорее.

13. Гипоксия головного мозга. ***Больной M.S.***, 20 лет, мужчина

Гипоксия головного мозга в результате травмы с последующим MVA, болен в течение года до начала лечения. Парень попал в аварию на мотоцикле и как следствие был гемопневмоторакс и недостаток подачи кислорода в мозг, достаточно долго, что привело к гипоксии мозга.

Больной находился в вегетативном состоянии, при котором наблюдалась спастическая контрактура конечностей и скованность суставов, однако шея подвижна, но больной не может ее выпрямить. Лежа на животе не может поднять голову. Прием пищи возможен, но очень замедлен. Не реагирует, на звуковые раздражители

Получил курс резонансной терапии в течение месяца, в основном, с использованием излучателя ZB на позвоночник и голову. После месячного периода семье рекомендовано применять излучатель для продолжения лечения дома.

Результат: Замечено несколько нижеследующих улучшений:

Может жевать и глотать то же количество пищи в три раза быстрее.

Сидя может выпрямить шею и держать ее прямо достаточно долго, а раньше этого делать не мог.

Реагирует на обращенную к нему речь поворотом головы .

Больше улыбается окружающим.

Может поднимать ногу, если положить ее на край кровати.

Может поднимать голову в любом положении лежа, чего не мог делать раньше

Производит больше звуков, как будто хочет что-то сказать.

Комментарии: Те же, что и в предыдущем случае.

14. Дискомфорт в икроножной мышце и сонливость**.** ***Больной A.R.***, 40 лет, мужчина

Обратился с жалобами на постоянную сонливость и дискомфорт в икроножной мышце в течение 2-х лет. Работает учителем и, возможно, длительное пребывание на ногах послужило причиной дискомфорта в икроножной мышце. Обычно боль начинается утром и вечером.

Лечение: Лечение проводилось в основном на икроножную мышцу.

Результат: Ежедневное заметное улучшение, дискомфорт полностью прошел после 3-х сеансов терапии. Сонливость отмечалась только после первого сеанса. Чувствует в себе больше энергии, сонливость исчезла. Так как улучшение наступило через 3 дня, лечение было прекращено.

Комментарии: Лечение подобных проблем дало хороший результат у нескольких других пациентов со схожими состояниями.

15. Заболевание двигательного нейрона**.** ***Больной S.Z.***, 49 лет, мужчина.

Жалобы: Медленно прогрессирующее заболевание двигательного нейрона в течение 6 лет.

Двигательная активность верхних конечностей равна 3. В основном поражены руки. Не может выпрямить пальцы на руках, не может сжимать ладони, искривление локтевых костей обеих рук. Отмечается постоянное ухудшение состояния.

Лечение: В течение 30 дней 2 раза в день.

Результат: В конце месяца смог выпрямить большие пальцы на руках и слабо сжимать ладони. Может выпрямить запястье, чего не мог делать в течение прошедших двух лет. Чувствует в себе больше энергии.

Больной не смог продолжить лечение из-за того, что терапия требует много времени, а он должен работать.

Побочных эффектов не наблюдается.

Комментарии: Удивительно, но данный метод может повернуть вспять заболевание двигательного нейрона. Однако продолжительность лечения не облегчает ситуацию для пациентов, которые не могут длительно ходить на лечение, особенно если они ожидают быстрый эффект от проводимой терапии.

Лечение достаточно хорошо для остановки прогрессирования заболевания и, из практических соображений, лучше применять излучатели дома.

16. Спондилолистез**. *Больная S,*** 62 лет, женщина.

В течение двух лет после падения с лестницы беспокоят сильные боли в области спины. Из-за сильных болей не может ходить, стоять и вынуждена находится в горизонтальном положении. На рентгенограмме спондилолистез L IV-V.

Получала лечение в течение 14 дней.

Результат: Заметное улучшение, больная может ходить, сидит столько сколько хочет без боли. Может ходить без посторонней помощи, может безболезненно сгибать колени. Продолжительность наблюдения за больной - 6 месяцев. Боли не возобновились.

Побочных эффектов не наблюдается.

Комментарии: Наблюдался хороший эффект лечения еще у двух больных со спондилолистезом.

17. Синдром канала запястья**. *Больная К.***, 33 года, женщина.

Обратилась с жалобами на начавшуюся два месяца назад боль в правой руке, особенно в пальцах с симптомом онемения в указательном, среднем и безымянном пальцах. Наблюдается ухудшение к ночи после домашней работы. Чувство онемения и боли иногда беспокоят во время сна.

Больная принимала несколько видов медикаментозных препаратов, предписанных хирургом-ортопедом, но без улучшения. Была назначена операция по снятию давления на запястье.

Обратилась в клинику Infra-Life, и хотя мы не знали, каков будет эффект терапии, больная пожелала попробовать нетрадиционный подход.

Показатели по ЭАФ были высокими на большинстве точек, реагирует на излучатель RC.

Проведен курс терапии в течение 14 дней. В первые 3 дня улучшения не было, чувство онемения начало проходить через 4 дня. На 10-й день симптом полностью прошел и больная очень счастлива.

Побочный эффект: После первого дня лечения у больной началась сильная головная боль, продолжавшаяся 24 часа, так что второй сеанс отложили на один день. Она приняла парацетомол для обезболивания, что дало некоторое облегчение.

Комментарии: Следует пробовать лечить синдром канала запястья до начала серьезного хирургического вмешательства. Кажется, синдром является проявлением изменений химических процессов в организме.

18. Боль в месте прикрепления Ахиллова сухожилия**.** ***Больной S.***, 45 лет, мужчина

Жалобы: Боли в левой ноге в месте прикрепления Ахиллова сухожилия, в течение двух лет, обезболивающие медикаменты не приносят облегчения. Больной при ходьбе прихрамывает, а его работа в качестве бригадира на фабрике требует длительной ходьбы. Состояние ухудшается. Рентген никаких изменений не показал.

Проходил терапию в основном с применением излучателей RC, GI и ZB в течение 8 дней.

Побочных эффектов не наблюдалось.

Результат: Заметное улучшение. Согласно вопросника из 10 пунктов, больной испытывает облегчение на 90%, даже при продолжительной работе, связанной с длительной ходьбой. Ремиссия сохранялась в течение 9 месяцев, после чего больной вновь обратился в клинику из-за рецидива.

19. Отравление парацетомолом. ***Больная S.***, 31 год, женщина

У пациентки возникли семейные проблемы, приведшие к разводу.

Больная приняла одновременно 50 таблеток парацетомола. Через три дня обратилась в больницу с жалобами на чрезмерную сонливость, потерю аппетита. После принятия таблеток рвоты не было. Ее заявление поставлено под сомнение несколькими врачами, но больная утверждает, что считала таблетки до приема. Ее бывшему мужу, который все еще заботится о ней, объяснили, что вероятнее всего ей понадобится гемодиализ, но не в домашних условиях.

Медицинское обследование: Сонливость, заторможенность, желтуха. Из-за дегидратации больной сделано внутривенное вливание.

Пациентке было предложено попробовать ИК терапию, и в безуспешном случае ей нужно проходить ежедневный гемодиализ, в зависимости от обследования. На что она согласилась.

Проведен 5-дневный курс терапии, в основном излучателем RC на печень (отмечалась реакция на этот излучатель по ЭАФ). Результат оказался очень интересным, желтуха не прогрессировала, и все энзимы печени пришли к норме.

Биохимические показатели крови, следующие:

День	До лечения	1-й день	2-й день	3-й день	7-й день
Дата		13/9/98	14/9/98	15/9/98	23/9/98
Общий билирубин	1.8	1.4	1.1	1.0	1.0
Прямой билирубин	1.5	0.9	0.4	0.6	0.5
Непрямой билирубин	0.3	0.5	0.7	0.4	0.5
Общий белок	71	56	66	63	72
Альбумин	34	27	31	30	37
Глобулин	37	29	35	33	35
A/g ratio	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1
Alp	55	51	51	64	52
АСТ	1884	1412	1000	782	15
АЛТ	2252	1028	561	252	27

Больная была выписана из больницы через 4 дня и анализ через неделю показал, что энзимы печени в норме. Она выжила без гемодиализа и желтуха не прогрессировала. Следует сказать, что при таких тяжелых формах отравлений и гемодиализ помогает очень редко. Побочных эффектов не наблюдалось.

Комментарии: Лечение дало замечательный результат. В дальнейшем рекомендуется изучать большее количество отравлений, сопровождающихся поражением печени.

20. Эффект ИК-излучения на пациента, принимавшего рифампицин (rifampicin)**. *Больная 30 лет***, женщина. Жалобы: В течение 2-х месяцев у больной наблюдался хронический сухой кашель, потеря веса, отсутствие аппетита.

Рентген грудной клетки показал ватообразное затемнение в правой верхней доле. Однако мокрота на AFB была отрицательной. Поставлен клинический диагноз туберкулез легких и назначен стандартный режим медикаментозного лечения, включающий прием рифампицина.

Больная обратилась к нам сразу на второй день, в надежде, что поможет резонансной терапия - антибактериальный излучатель, помимо медикаментов.

Лечение начато с применения излучателей GI и RC. Из-за высоких показателей по ЭАФ на печени, применялся также излучатель RC на печень. Лечение проводилось через день, т.к. больная чувствовала себя очень уставшей после сеанса терапии.

Наблюдался интересный феномен: в день лечения моча была прозрачной и чистого цвета, в день, когда лечение не проводилось, моча имела красноватый

цвет. Данный феномен наблюдался в течение 7 дней, из которых 3 дня больная приходила на сеансы терапии и моча была чистой, а 4 дня без лечения моча была красноватой, хотя больная принимала одинаковую дозу рифампицина. Она беспокоилась, что воздействие ИК-излучателя на печень снизит эффективность медикамента, т.к. данный метод не доказан. Мы предоставили ей выбор, продолжать лечение, но без излучателя на печень, или прекратить курс. Больная выбрала только медикаментозное лечение.

Побочный симптом: В дни ИК-терапии основным симптомом является сонливость.

Комментарии: Наблюдаемый феномен возможно, связан с сильным влияниянием на переработку печенью медикаментов в целом или только рифампицина в данном случае или парацетамола в вышеописанном случае.

21. Отравление несколькими химикатами**.** ***Больная N.***, женщина 38 лет

Отравление возникло вследствие приема нескольких химикатов. Поведение больной продиктовано желанием привлечь к себе внимание после ссоры. Она смешала Polyethelene glychol, хлоргексидин, Dettol, Ethanol, эритромициновую мазь и спирт, и выпила эту смесь. Спустя три часа ее поместили в палату, к тому времени она оставалась в сознании. Наблюдалась легкая дрожь в руках, гиперкинез, жалобы на боль в эпигастральной области эпигастральную, больная постоянно повторяла "Доктор, помогите". Было сделано промывание желудка, но боль не уменьшилась.

На всех точках показатели по ЭАФ были около 100, и на большинство излучателей не реагировали, за исключением КН на гипофиз и RC на печень и общую RC. Через 5 минут воздействия излучателя КН на голову показатели упали только до 70, однако больная почувствовала себя лучше, и дрожь почти прекратилась. Прибор ЭАФ также показал снижение показателей на печени и всем меридианам под излучателем RC. Было проведено три сеанса в один день. Эпигастральная боль немедленно не прошла ни с одним излучателем, но через 2 дня больная полностью поправилась и была выписана.

Комментарии: В данном случае наблюдалась симптоматическая реакция организма. Точное воздействие на выделение химикатов не установлено из-за отсутствия средств отслеживания. Требуется дальнейшее изучение.

22.Детский аутизм**.** ***Больная N.A.J.***, 12 лет, девочка с Ланкави.

Диагноз: аутизм поставлен в возрасте 2-х лет

Основные симптомы: Не контролирует злость, рассеянное внимание, заторможенность, слабые навыки общения.

Рождена нормальным ребенком, затруднений при родах не было. До 2-х лет развитие протекало нормально. Затем замечено странное поведение, когда девочка перестала реагировать на внешние раздражители

Больная прошла курс физио- и акупунктурой терапии. Ее мать работает учителем, и она посвятила много времени ее развитию. В возрасте 9 лет у девочки наблюдалось некоторое улучшение, она смогла писать, читать, пользоваться компьютером. Понимает телевизионные программы и понимает устную речь, хорошо говорит по-английски и по-малайски, способна отвечать на вопросы. Однако интервалы ее внимания очень коротки, легко раздражается, когда дважды повторяют вопрос, если она еще не ответила. В большинстве случаев кричит в ответ. Обычно может читать только 3-4 предложения и не концентрируется на продолжении.

Проведен курс резонансной терапии ежедневно, только 10 сеансов. Причиной прекращения послужило то, что больная приезжала издалека и только на школьные каникулы.

Отмеченный прогресс: Обычно пациентка может концентрироваться на всего нескольких предложениях. После 5 дней терапии замечено, что она способна концентрироваться дольше, и через 10 дней смогла читать 3-4 страницы за 1 раз. Удивительно, что она лежала на кровати в течение 2-х часового сеанса, т.к. обычно она не может сидеть на одном месте, особенно, лежать при первоначальном лечении. Также больная стала менее агрессивна, и по словам родителей, не так легко злится, как до лечения. Данные изменения основаны на наблюдении родителей.

Побочный эффект: В течение курса терапии у больной появились зудящие пятнышки. Сыпь появилась внезапно и исчезла сама, без применения медикаментозного лечения

Комментарии: Улучшение концентрации после курса резонансной терапии. К сожалению, более длительный курс терапии не был возможен по демографическим причинам.

23. Бронхиальная астма. Больная 55 лет, женщина из Муара

Страдает астмой в течение 2 лет. Приступы почти ежедневно по утрам, сопровождаются сторозным дыханием и одышкой. Постоянно нуждается в медикаментах. Ингалятор не облегчает приступ.

Лечение: Больная прошла курс резонансной терапии с использованием, в основном, излучателей GI и ZB на желчный пузырь и надпочечники. Курс терапии составил 7 дней, после чего должна была вернуться к работе.

Результат: После 3-х дней лечения прием мед. препаратов полностью прекращен, приступов нет. Вернулась обратно в родной город. Приступов не было с начала лечения и прием лекарств прекращен. Через 6 недель приехала на контрольный осмотр, не было ни единого приступа астмы. Пятью месяцами позже она поехала в Мекку, и по возращении в течение двух дней были слабые приступы астмы, после чего пациентка вновь обратилась в клинику Infra Life. Через 2 дня она почувствовала себя хорошо, и будет использовать лампы дома, в случае приступа. С того времени приступов астмы не было.

Побочных эффектов не наблюдалось.

Комментарии: Данный случай довольно отдельный, требуется больше примеров для анализа реакции на лечение. Ответная реакция на этот метод терапии при лечении больных астмой довольно поздняя, и применять данный метод для лечения острых приступов не рекомендуется. Лечение должно быть направлено на предотвращение рецидива.

24. Хроническая почечная недостаточность**.** ***Больной 45 лет***, женатый мужчина

Хроническая почечная недостаточность вследствие обструктивной уропатии из-за камней в почках. Шесть лет назад были камни в почках, в связи с чем была проведена цистолитотрипсия (камнедробление) и затем хирургическая литотомия (камнесечение). С тех пор количество мочи уменьшилось и развилась гипертония. Больной принимает атенолол и нифедипин по 10 мг.

При дальнейшем наблюдении установлена прогрессирующая почечная недостаточность и почки резко уменьшились в размере. 6 месяцев назад начат гемодиализ по 3 раза в неделю.

Больной обратился за лечением в нашу клинику. Однако приходил очень нерегулярно, т.к. много времени занимал гемодиализ. В течение первых 2-х недель лечение проводилось 3 раза в неделю, затем 2 раза в течение 3-х недель. Ему рекомендовано собирать мочу в контейнер, замерять объем с помощью шприца и вести записи. Выход мочи оставался неизменным в течение прошедших 6 месяцев.

Результат: С начала лечения выход мочи увеличился следующим образом:

До лечения - 80 мл/день

5-й день - 115 мл/день

7-й день - 125 мл/день

14-й день - 145 мл/день

После 14 сеансов количество мочи не изменялось и оставалось на уровне 130-145 мл/день.

Побочный эффект: В день лечения иногда больной чувствовал легкую головную боль, не мешающую работе.

Комментарии: Количество мочи увеличилось на 60-70%, однако базисная линия еще очень низка, чтобы отказаться от гемодиализа. Лечение довольно ограничено для пациентов на гемодиализе, если низкая базисная линия. В случае продолжения лечения возможно дальнейшее увеличение мочи, но неизвестно насколько. Однако можно ожидать увеличение количества мочи в два раза, затем достижение плоского уровня.

В данном случае количество мочи увеличивалось, но больной не смог приходить по расписанию, а только раз в неделю, т.к. он тратит 3-4 часа на диализ 3 раза в неделю в диализном центре.

25. Хроническая почечная недостаточность**. *Больная S.,*** 41 год, женщина

Хроническая почечная недостаточность из-за камней в почках. Была оперирована, но хроническая почечная недостаточность уже возникла. Больная находится на постоянном амбулаторном перитонеальном диализе по 4 пакета в день в течение 2-х лет. Отеки появляются и проходят, бледность. Гипертония, принимает нифедипин в таблетках по 10 мг и празозин в таблетках по 1 мг. Обе почки очень маленькие (сморщенные). До начала лечения объем мочи за 24 часа составлял около 20-25 мл в день.

Больная прошла 30-дневный курс терапии.

Результат: Объем мочи увеличивался ежедневно или за несколько дней следующим образом: 40 мл -50 мл -60 мл -70-80 мл -110 мл-120 мл -125 мл за месячный период. Увеличение плоского уровня мочи через 20 дней лечения все еще недостаточно для отказа больной от диализа, но общее состояние заметно улучшилось. Обычно он не могла делать домашнюю работу, из-за усталости и отсутствия энергии. С начала лечения она может заниматься хозяйственными делами целый день и чувствует повышение работоспособности.

Лечение привело к значительному увеличению мочи на 600 % по сравнению с первоначальным уровнем, но не ожидается, что дальнейшее лечение еще увеличит объем мочи.

При прохождении курса терапии у больной была безболезненная гематурия в течение 3-х дней. Ее направили к хирургу, провели УЗИ, в результате чего обнаружен маленький камень в правом мочеточнике, который исчез при продолжении лечения.

Никаких осложнений не замечено.

Комментарии: Даже при значительном увеличении выхода мочи, больная продолжает оставаться на диализе в том же количестве (3-4 пакета в день). Поэтому не предлагается применять данный метод для пациентов с хронической почечной недостаточностью, если их объем мочи до лечения был очень маленьким. Данный метод не может помочь пациентам отказаться от диализа, а может помочь больным с объемом мочи более 500 см3 в день.

26. Хроническая почечная недостаточность. ***Больной 55 лет***, мужчина

Хроническая почечная недостаточность вследствие химиотерапии по поводу рака желудка. Проведена операция по раку желудка, достигнуто состояние ремиссии. Больной находится на гемодиализе два раза в неделю.

Применена резонансная терапия, направленная на улучшение функции почек. До начала курса объем мочи составлял около 500 мл/день. После двухнедельного курса выход мочи значительно увеличился и достиг уровня 700 мл/24 часа. Гемодиализ все еще необходим два раза в неделю.

Побочных эффектов не наблюдалось.

Комментарии: Терапия может увеличить объем мочи при хронической почечной недостаточности.

Комментарий Рахимова Р.Х. Наиболее частой причиной хронической почечной недостаточности, является нарушение функций печение и желчно-печеночного протока. Дело в том, что печень выполняет более 500 функций в организме. Употребление в больших количествах сладкого, приводит к повышенному синтезу холестерина печенью. В результате, желчно-печеночный проток, через который выводятся продукты распада и, таким образом, печень очищает кровь, В результате этого, в крови наблюдается недостаток кислорода и глюкозы. Нарушается вторая функция печени обеспечивать мозг глюкозой. Почки компенсируют недостаток глюкозы, повышением ее синтеза. Как итог, собственная функция почек – вывод минералов и продуктов распада белков, отходит на второй план. Это способствует размножению патогенов в образовавшейся питательной среде. В связи с изложенным, лечение нужно начинать с восстановления желчно-печеночного протока и исключения сладостей в питании.

27. Нефротический синдром с нарастающими отеками**.** ***Больная Н.***, женщина 30 лет, замужем, один ребенок 1,5 лет, обратилась с жалобами на вздутие живота и отеками обеих ног, от щиколотки и ниже в течение 6 месяцев. Поставлен диагноз идеопатический нефротический синдром HSA, JB. Кожа на ногах лоснящаяся, отек значительный, больная с трудом носит обувь. Кроме того, имеется асцит.

К началу курса терапии больная ежедневно принимала преднизолон в таблетках по 15 мг, T. lasix 20 мг, T. Slow k. За четыре месяца до описываемых событий у больной был герпес Зостер с осложнением на правую грудь, после заживления которого остался шрам. Однако доза преднизолона не может быть уменьшена, т.к. будет ухудшение с явлениями протеинурии.

Протеин в моче был три + (+++), сывороточный альбумин 16 мг/dl. Данные являются обычным уровнем при большинстве анализов.

Прошла курс резонансной терапии в течение месяца, ежедневно.

Результат: Отек ног заметно уменьшился, и ноги приобрели нормальный размер. Протеин в моче сократился до ++, но сывороточный альбумин оставался между 13-16 мг/dl. Наблюдающий терапевт сократил ежедневную дозу преднизолона до 10 мг. Сывороточный протеин увеличился до +++, но сывороточный альбумин остался на прежнем уровне. Обхват живота уменьшился на 3 см. Вес тела уменьшился с 45 до 40 кг, возможно, за счет потери тканевой жидкости (уменьшения отеков).

Интересным наблюдением было то, что ноги стали обычного размера через 20 дней лечения, и стало возможным уменьшить дозу преднизолона на две трети (до 5 мг в день), применение lasix и slow k прекращен. Через 30 дней терапии больной рекомендовано приходить раз в неделю. Клиническая картина оставалась прежней, дальнейшего улучшения биохимических анализов не наблюдалось. По этой причине лечение прекращено. Невозможно было провести более длительный курс, т.к. больная приезжала издалека и на месяц должна была оставить работу.

Побочный эффект: После пятого сеанса на одной ноге отмечались точечные кровоизлияния и боль в коленном суставе. При продолжении лечения симптомы через неделю прошли.

Комментарии: Интересно, что излучатель ZB явно воздействовал на уменьшение избыточной жидкости в сосудах ног, а сывороточный протеин остался на прежнем уровне. Однако доза преднизолона была уменьшена на две трети по сравнению с первоначальной. В данном случае наблюдалось хорошее симптоматическое улучшение.

28. Атония мочевого пузыря**.** ***Больная S.,*** женщина 51 год

Обратилась с диагнозом атония мочевого пузыря в течение 3-х месяцев. Нет позывов на мочеиспускание, хотя она знает, что мочевой пузырь полон. После усиленной попытки помочиться выделяется очень малое количество мочи. Пузырь всегда заметно раздут. Больная обратилась в больницу, где поставлен катетер с 4-часовым выпуском. До введения катетера после мочеиспускания, остаточный объем мочи составлял >1000 мл. Больная чувствует опорожнение мочевого пузыря, когда объем выведенной мочи составляет около 2000 мл.

Проведен курс резонансной терапии, основные используемые излучатели - RC и ZB на мочевой пузырь. (За две недели до курса больной проведено хирургическое удаление матки из-за дисфункционального маточного кровотечения).

Результат воздействия при атонии мочевого пузыря был исключительно хороший. После трех сеансов больная не нуждалась в катетере, и появились позывы на мочеиспускание. Терапия проводилась ежедневно в течение первых 3-х недель, два раза в неделю в течение следующих 2-х недель, и затем раз в неделю в течение 4-х недель. Рекомендовано приходить на лечение чаще, чтобы полностью вылечить заболевание, но больная отказалась из-за того, что чувствует себя абсолютно нормально.

Ее попросили вывести катетер за день до посещения клиники для проверки, затем попросили помочиться для измерения соотношения объема мочи и остаточной мочи.

Объем остаточной мочи (введен катетер после PU):

До лечения - 1140 мл

6 день - 460 мл

12 день - 260 мл

16 день - 220 мл

19 день - 205 мл (после курса 3 раза в неделю)

27 день - 140 мл

31 день - 120 мл

40 день - 90 мл (после курса 2 раза в неделю)

45 день - 79 мл (после курса 1 раз в неделю)

57 день - 77 мл (после курса 1 раз в неделю)

65 день - 75 мл

70 день - 74 мл

84 день - 59 мл

Никаких побочных симптомов.

Комментарии: В результате лечения наступило выздоровление. Половая жизнь восстановилась, муж очень счастлив.

29. Тики (моргание). ***Больная K.G.,*** индийская девочка 8 лет

Обратилась с 6-месячной историей прогрессирующего вынужденного моргания, с частотой 30-40 раз в минуту. Осмотр офтальмолога аномалий не определил. Осмотрена терапевтом и по желанию отца, проведена компьютерная томография головного мозга - аномалий не выявлено.

Лечение: Больная прошла курс резонансной терапии. Показатели по ЭАФ 70-80 на большинстве точек, по ЭАФ подошел излучатель RV. Лечение проводилось ежедневно в течение 7 дней, затем неделей позже.

Результат: Ежедневное улучшение. Частота моргания уменьшилась до нормальной, как было раньше. Ремиссия сохранялась годом позже, на момент данной записи.

Ни единого побочного симптома не наблюдалось.

Комментарии: Вероятно, симптом был проявлением меняющихся химических процессов системы, состоящей их многих органов, за счет высокой электрической активности. В результате лечения наступило избавление от данного симптома.

30. Болезненный шрам от ожога соляной кислотой**. *Больной E.A.***, мужчина 50 лет, обратился с жалобой на очень болезненный шрам от ожога.

Анамнез: Больной получил производственную травму, взорвался поршень с соляной кислотой. В результате получил поражение кислотой 70% тела. Чудо, что он выжил, т.к. до этого не было ни одного свидетельства о случаях выживания при ожоге кислотой более 55%. Травма произошла за 8 месяцев до начала курса терапии. Больной был помещен в ICU на 28 дней, где было отмечено два эпизода "умирания". Чувствовал себя хорошо в течение 3-х месяцев, но справа на теле появилась усиливающаяся боль.

За два месяца до обращения в клинику Infra Life у больного была невыносимая усиливающаяся боль. Он описывал боль как постоянно режущую на правой стороне тела. Боль странно усиливалась при дожде, но больной чувствовал себя лучше, если находился в очень холодной кондиционируемой комнате. Поэтому большую часть времени он проводил в своей комнате. По

всему телу имелся толстый келоидный шрам, болезненный участок более теплый по сравнению с нормальной кожей.

Боль была такая сильная, что казалось, лучше умереть, чем жить с болью. Однако идеи суицида не возникало.

В течение двух последующих месяцев до обращения в клинику Infra Life больному ежедневно требовалась инъекция петидина по 100 мг и 2 таблетки дигидрокодеина каждые 4 часа.

Было начат пробный курс лечения ИК-излучателями ежедневно в течение 36 дней. Сразу после первого сеанса наблюдалось некоторое уменьшение интенсивности болей, но все еще ощущалось периодическое обострение. Доза дигидрокодеина была снижена до каждых 6 часов, а через 3 недели - до 8 часов. Через 6 недель потребность в медикаментах осталась только раз или два раза в неделю.

Потребность в инъекции становилась все меньше, обычно в дождливые дни.

Далее следуют дни, когда больной нуждался в инъекции петидина, начиная с первого дня курса терапии:

Да - день, когда больной получал инъекцию

Нет - день, когда не было нужды в инъекции

День 1 Да

День 2 Нет

День 3 Нет

День 4 Нет

День 5 Да

День 6 Нет

День 7 Нет

День 8 Нет

День 9 Да

День 10 Нет

День 11 Нет

День 12 Да

День 13 Нет

День 14 Да

День 15 Нет

День 16 Нет

День 17 Нет

День 18 Нет

День 19 Нет

День 20 Нет

День 21 Нет

День 22 Да

День 23 Да

День 24 Нет

День 25 Нет

День 26 Нет

День 27 Да

День 28 Да

День 29 Да

День 30 Нет

День 31 Нет

День 32 Нет

День 33 Нет

День 34 Нет

День 35 Нет

День 36 Нет (через 36 дней рекомендовано продолжить лечение дома двумя видами излучателей)

День 37 Да

После этого дня инъекция ему понадобилась только однажды на 44 день, затем необходимости не возникало, до ведения данной записи (3 месяца спустя).

Через три месяца чувство тепла на болезненном участке заметно снизилось и толщина келоида на руках, щеках и спине также уменьшилось. Темный келоид на руках посветлел и краснота на правой стороне туловища, которая болела, также стала меньше. Пациент очень доволен и получил еще два излучателя, чтобы сократить время, т.к. площадь поражения велика.

Никаких побочных симптомов.

Комментарии: лечение может применяться на любые келоидные шрамы с хорошим результатом. В данном случае терапия значительно снизила болезненность шрама, чего не достигалось никаким другим методом

31. Гипергидроз**.** ***Больной А***., мужчина 50 лет

Больной не имел особых симптомов, но пожелал пройти курс терапии в целях нормализации состояния организма после проверки по ЭАФ.

Одним из замеченных отклонений был гипергидроз: ладоней, конечностей и тела. Диагноз поставлен на основе физического осмотра. Ладони мокрые как будто только что побывали в воде. Насколько он помнит, такое состояние длится в течение 20-30 лет.

Показатели по ЭАФ на большинстве точек 70-85. Лечение было направлено на нормализацию показателей по ЭАФ.

Наблюдалась реакция на действие излучателя RV. На следующий день все показатели по ЭАФ были 50-60, а ладони и тело абсолютно сухими. Больной впервые почувствовал себя комфортабельно. Прошел 3 сеанса, когда обратился повторно через неделю все показатели были 45-50. Проведен краткий курс излучателями GI, ZB и KL. На следующий день показатели были 60-70 и гипергидроз возобновился. Применили излучатель RC когда показатели оставались на уровне 50-60. Более гипергидроз не появлялся. Больной пришел на проверку через 2 недели, показатели остались в норме, гипергидроз не отмечался. Через полтора месяца после первоначального курса его клиническое состояние оставалось в стадии ремиссии.

Побочных симптомов не наблюдалось.

Комментарии: Лечение подобного состояния основано целиком на показателях по ЭАФ. Когда показатели приходят в норму, ожидается, что состояние улучшилось, но оно может быть не совсем нормальным, поэтому необходим более длительный курс. Возможно, 7 дней дадут удовлетворительную реакцию на лечение. Данный случай рассматривается скорее как исключительный, чем обычный.

32. Боль в икроножной мышце**.** ***Больная N.***, женщина 42 года

Особых симптомов не наблюдалось, за исключением боли в правой икроножной мышце. Характер боли довольно тупая, приносящая дискомфорт, больше по утрам, так что больная не может полностью сгибать ноги. Усиления при ходьбе не отмечается, но ночью дискомфорт больше, массаж улучшения не приносит.

Проведен курс резонансной терапии, основанный на показателях по ЭАФ. В основном применялся излучатель ZB на область икры.

После первого сеанса боль полностью исчезла и больше не появлялась.

Ни единого побочного симптома не замечено.

33. Седина**.** ***Больной М. А.*** В., мужчина 51 год

Больной не имел особых симптомов, но пожелал пройти курс терапии в целях нормализации состояния организма. После проверки по ЭАФ, большинство показателей было выше нормы, около 60-75.

Лечение проводилось в основном излучателями RV, KL, GI и ZB. Курс проводился не регулярно, в общей сложности 10 сеансов в течение месяца.

Пациент почти полностью был седой.

Однажды через месяц с начала лечения пациент заметил, что все волосы стали темными. Все короткие или вновь растущие волосы также черного цвета.

Ни единого побочного симптома не замечено.

34. Ишемическая болезнь сердца**.** ***Больная H. S.***, женщина 80 лет

Страдает гипертонией в течение 15 лет, боли в груди в течение 7 лет. Врачи установили ишемическую болезнь сердца. К сожалению, не может принимать никаких лекарств. Больная пробовала различные медикаменты, но любые вызывают либо ухудшение работы сердца, либо повышение давления, вызывало чрезвычайную сонливость, головокружение, невозможность даже сидеть. Находилась в лежачем положении в течение целого дня.

Сильные боли за грудиной, тяжесть в груди, сопровождающаяся одышкой. Легкой движение при ходьбе, одевании, молитве, причиняет боль, проходящую после отдыха и легкого массажа спины. 3-4 раза в месяц ночью приступы, нуждается в посторонней помощи для массажа. Боль усиливается после незначительной физической активности. Такая картина наблюдается в течение последних 7 лет, приступы участились до 20 раз в день за последние 3-4 года. Получила 30-дневный курс ИК терапии, основные излучатели ZB, AK, GI на сердце и некоторые другие органы. До начала лечения АД было между 160-170/100-110.

Результат: На 3-й день лечения замечено улучшение, в день всего несколько приступов (боли в груди). С начала лечения ни одного сильного ночного приступа. Через 2 недели боли появлялись всего несколько раз в неделю и были более слабыми. АД снизилось до 150-160/80-90.

Через месяц больной рекомендовано продолжить лечение дома излучателями GI и ZB и приходить на проверку раз в две недели. С того времени состояние больной оставалось хорошим.

Побочные эффекты не наблюдались.

35. Воспаление подкожно-жировой клетчатки при СПИДе**.** ***Больной R.,*** мужчина 35 лет

Имеет положительные серореакции в течение 2-х лет, расценивается как больной СПИДом. У больного частые абсцессы и воспаления подкожно-жировой клетчатки, боли в суставах, несколько раз лечился стационарно. Обратился в госпиталь с жалобами на наличие абсцесса и воспаление подкожно-жировой клетчатки левой нижней конечности, сопровождающиеся высокой температурой в течение 2-х недель, беспокоят сильные боли в области сустава, его неподвижность. При осмотре общее состояние больного тяжелое, кожные покровы бледные, температура 39°C, не снижающаяся на фоне приема антибиотиков. Кожа левой ноги резко отечна, отек больше выражен в области коленного сустава, голени и стопы. На передней поверхности голени 2 язвы размеров 3х4 см, дно язв покрыто гнойным налетом. Поставлен диагноз септический артрит и воспаление подкожно-жировой клетчатки. Необходима была хирургическая резекция нарывов, но персонал не был заинтересован в этом, т.к. ожидалось длительное пребывание в больничной палате, а пациент не располагал средствами для длительной госпитализации. Жена отказалась помещать его в больницу, т.к. еще никто не знал, что он является носителем ВИЧ, и она боялась, что распространятся слухи. Больной отказался обратиться в больницу общего назначения, потому что жена должна заботиться о трех маленьких детях, а за ним некому ухаживать в палате. Ему дали антибиотики на несколько дней, и ожидали его возвращения на осмотр. После обсуждения с врачом жена согласилась применять ИК-излучатели дома согласно назначению. Больному предоставили пять ИК-излучателей: GI, ZB, KL, RC, RV, с указанием режима применения. Как только было начато лечение дома, температура нормализовалась (возможно, также за счет антибиотиков). Однако больной больше не обращался в больницу за антибиотиками, а продолжал лечение только ИК-излучателями, так что лечение может рассматриваться только как монотерапия. Лечение проводилось локальными излучателями. RV-s на все органы (головной и спинной мозг, сердце, печень, селезенку, почки, кишечник, легкие, миндалины) по 2-3 минуты 3 раза в день. Проводился 2 раза в день массаж позвоночника с использованием излучателя ZB-s. Одновременно проводилась терапия по нормализации микрофлоры кишечника, липидного обмена, стимуляции надпочечников 2 раза в день. На область язвы назначались RV-s и GI-s по 5-10 минут с постепенным увеличением экспозиции до 30 минут 2-3 раза в день. Результат: Общее состояние больного улучшалось ежедневно. Самочувствие улучшалось, температуры не было, улучшился аппетит. Отечность в области ноги и лимфостаз значительно уменьшились через 2 недели лечения, сохранялась незначительная отечность в области коленного сустава.

Клинически наблюдались явления септического артрита, однако боль значительно уменьшилась и больной смог ходить на костылях. В области подколенной ямки образовалась язва с гнойным отделяемым. Больной продолжает лечение локальными излучателями в домашних условиях, и есть признаки улучшения. Побочных симптомов не наблюдалось.


1


2


3


4

36. Воспаление подкожно-жировой клетчатки (или рыхлой соединительной ткани) под ногтем ***Больной A.F.,*** мальчик 6 лет

Проблема заключалась в абсцессе со свищом под ногтем на левом среднем пальце. Его отец врач и он просто наблюдал в надежде, что это может пройти спонтанно. Причина бездействия заключалась в том, что если начинать прием антибиотиков, его необходимо продолжать в течение определенного

времени, что может привести к диарее. Однако через три дня отек и боли немного увеличились.

Проведен курс ИК терапии, используемый излучатель - GI с длиной волны 22.5 мкм. Время экспозиции - 20 минут, перерыв полчаса, затем еще 20 минут. В тот же день 6 часами позже палец осмотрели и, к всеобщему удивлению, палец был абсолютно нормальным, безболезненным, без признаков воспаления.

Побочных симптомов не наблюдалось.

Комментарии: Излучатель GI является антибактериальным, его излучение прерывает около 10 химических процессов внутри патогенной бактерии. Без возможности деления бактерии погибают. Такой хороший результат наблюдался у многих пациентов с абсцессами воспалениями подкожно-жировой клетчатки, отитами, остеомиелитом и перитонитом, так что это не было неожиданным.

37. Воспаление подкожно-жировой клетчатки (или рыхлой соединительной ткани) большого пальца. ***Больная М.Н.***, женщина 32 года

Жалобы: Отек, боль, повышенная температура и болезненный очаг воспаления в средней части ногтя на правом большом пальце руки в течение 2-х дней. Возможно бактериальной этиологии, в дополнение грибковое инфицирование ногтя. Больная пожелала попробовать ИК-терапию. На большой палец воздействовали излучателем AF в течение часа.

Результат: На следующие день палец был абсолютно нормальным, без признаков воспаления.

Комментарии: Есть возможность спонтанной ремиссии. Однако по свидетельствам предыдущей истории болезни, у больной периодически возникали подобные проблемы, которые обычно длились в течение недели при приеме антибиотиков. Быстрое симптоматическое облегчение пришлось кстати, т.к. у больной много работы по дому.

38. Воспаление Ахиллова сухожилия**.** ***Больной Z.***, мужчина 33 года

Саднящая рана в области Ахиллова сухожилия в течение трех дней. Болезненность, местное повышение температуры, прихрамывающая походка из-за давления обувью. На место поражения применен излучатель GI на 40 минут. Сразу после 40 минут в данной области болезненность не ощущалась, прихрамывание исчезло.

Комментарии: Излучатель GI обладает противовоспалительным и антибактериальным действием.

39. Колики в животе и диарея**.** ***Больная P.N.***, девочка 7 лет

Жалобы на боли, колики в животе, диарею. Такое состояние продолжалось в течение часа и девочка плакала от боли. Проведено воздействие излучателем RV на 2 минуты, затем излучателем GI на 10 минут.

Результат: Боль полностью прошла и диарея немедленно прекратилась.

Побочных симптомов не наблюдалось.

Комментарии: Колики в животе и диарея, в большинстве случаев, возникают из-за вирусов или бактерий, которые считаются причиной в 90% подобных проблем. Значительное количество больных, страдающих от таких проблем, были пролечены данным методом и получены исключительно хорошие результаты. Симптоматическое облегчение и прекращение диареи наступает очень скоро, после двух или трех сеансов по 15 минут каждый час. Часто эффект наступает сразу после первого сеанса терапии.

40. Кашель, сопровождающийся рвотой при врожденном пороке сердца**.** ***Больной S.O.***, мальчик 5 лет

Пять врожденных аномалий сердца, включая VSD и ASD. Умеренные физические нагрузки приводят к периферическому и центральному цианозу. Была предложена хирургическая операция, даже при условии достижения временного и ограниченного улучшения. Родители отказались. В настоящий момент жалобы на хронический кашель, который в большинстве случаев сопровождается рвотой. Приступы рвоты не менее 10 раз в день. Куда бы ребенок не пошел родители всегда имеют при себе пластиковый пакет, т.к. от может закашляться и вырвать, особенно после еды. Семья обратилась в клинику, чтобы мальчик прошел курс резонансной ИК-терапии. Не ожидалось значительного улучшения его состояния, т.к. имеются структурные дефекты, однако родители решили попробовать. При лечении в основном применялись излучатели RV, RC, GI и ZB на грудь и область сердца.

41. Выпадение волос вследствие химиотерапии**.** ***Больной M.A.***, мальчик 1 год

Анамнез: У больного в течение нескольких дней была диарея, вследствие чего неоднократно посещали врача. В один из приемов врач провел УЗИ и обнаружил массивное поражение на внутренней стенке мочевого пузыря. Больного направили на дальнейшее обследование в Госпиталь Куала-Лумпура. Провели компьютерную томографию, которая выявила опухоль размером 2x2

см в мочевом пузыре. Провели цистоскопию и биопсию ткани, показавшую рабдомиосаркому.

Проведен полный курс химиотерапии, по завершении которого еще раз повторили компьютерную томографию и цистоскопию. Результат - только незначительное уменьшение размера опухоли. Планировалась операция, в итоге мальчик мог иметь недержание мочи в течение всей жизни. В результате химиотерапии у ребенка полностью выпали волосы, кожа стала глянцевой, и такое состояние продолжалось в течение 2-х месяцев до начала курса резонансной терапии, к которой отец обратился в качестве альтернативы.

Ребенка принесли в клинику Infra Life через 4 месяца после установления диагноза, где отцу объяснили, что не дается никаких гарантий, т.к. подобного случая в клинической практике не было. Однако так как принцип лечения рака одинаковый, отец пожелал попробовать. Ребенка лечили в основном излучателями RC, RV и на короткое время ZB через день в течение 2-х недель, рекомендовано продолжать дома излучателем RC.

Отцу также рекомендовали продолжать наблюдение у того же онколога, и если не будет изменений, решать по своему усмотрению.

Результат: Результат лечения опухоли еще не известен. Однако интересно, что через неделю после начала курса терапии у больного стали расти волосы. Рост волос был очень быстрым, что ощущалось и наблюдалось в течение нескольких дней. Через 2 недели больного выписали из больницы для продолжения лечения в домашних условиях. Длина волос увеличивалась. Неделей позже мальчик начал ходить.

Побочный эффект: В течение нескольких первых дней терапии ребенок спал больше обычного, замечено небольшое увеличение аппетита, пил молоко больше, чем обычно.

Результат лечения рака еще неизвестен на данный момент.

42. Мигрень. ***Больная 24 года***, не замужем

Обратилась с жалобами на мигрень в течение 12 месяцев. Пульсирующая головная боль, длящаяся обычно один день. Приступы, по крайней мере, 3 раза в неделю. Усиливающие факторы - быстро меняющаяся погода, например, жаркий день, сменяется дождливым. Кроме того, больная работает в банке, где довольно сильный кондиционер дует прямо на нее.

Лечение: 7 раз, в основном на нормализацию работы всех системных органов на основе показателей по ЭАФ.

Повторный осмотр через неделю, за последнюю неделю был один непродолжительный приступ меньшей силы. Осмотр через месяц показал, что головная боль прошла. Рекомендовано через 3-6 месяцев придти на лечение на несколько дней. Больная живет довольно далеко и не может регулярно являться на осмотры.
Никаких побочных симптомов не наблюдалось.

43. Мигрень. ***Больная S.***, женщина 35 лет

Жалобы на частые приступы мигрени, в среднем раз в 1-2 месяца в течение двух лет, которые участились на последний год. Каждый приступ длится несколько часов в течение дня, пульсирующая боль с одной стороны, сопровождающаяся тошнотой и рвотой. Частично улучшение наступает за счет приема мефенамовой кислоты. Когда начинается приступ, больная не может продолжать работу и ей нужно лечь.

Проведен курс ИК-терапии с использованием излучателей RV, ZB и GI, на действие которых отмечалась реакция по ЭАФ. Терапия поводилась каждый день, всего 10 сеансов.

Результат: Больная прекратила посещение, т.к. приступы прекратились и не появлялись в течение 3 месяцев. Рекомендовано приходить на осмотр 1 раз в 3 месяца и, возможно, понадобится лечение в течение нескольких дней, если будут отклонения показателей по ЭАФ. Повторно обратилась через 3 месяца по поводу легкого приступа после длительной поездки из Малаки. С тех пор приступы мигрени очень редкие и слабые.

Комментарии: Данный метод хорош для предотвращения возникновения приступов мигрени. У большинства больных наблюдается эффект излечения, но все же следует ожидать значительное облегчение в отношении меньшей частоты и силы приступа. Лечение данным методом применяется не во время приступа, т.к. оно может принести частичное облегчение только для уменьшения головной боли, но не лучше болеутоляющих препаратов. Терапия направлена на нормализацию состояния организма и кровообращения в спинном и головном мозге. Это медленный процесс и требует от 10 до 20 дней.

44. Мигрень с гипертонией**. *Больной R.,*** мужчина 45 лет

Жалобы на приступы сильной мигрени и повышение давления. Приступы мигрени 1-3 раза в неделю в течение 10 лет, гипертония в течение 5-6 лет. Приступы мигрени всегда внезапны и длятся 2-5 часов и так же внезапно проходят, сопровождаютсярвотой, дрожью, учащаются с недостатком сна.

Больной вынужден закрываться в кабинете и лежать в течение нескольких часов, после чего приступ внезапно прекращается. Были опробованы все виды предупреждения приступов, но безуспешно. Когда приступ начинается, никакие медикаменты не помогают, поэтому больной больше не принимает никаких мед. препаратов по этому поводу.

Кроме этого, больной принимает два вида препаратов по поводу гипертонии. За год до начала резонансной терапии, больной был помещен на неделю в больницу с артериальным давлением 220/130 даже во время сна. Выписан с лучшим контролем АД, его обычное АД на уровне 140-150/95-105. Пробовал разные медикаменты пока диастолическое давление не стало 90 мм. рт.ст На время обращения в клинику Infra-life Clinic, больной принимал Lecidiphil 8 мг/день (обычная доза 2 мг).

Показатели по ЭАФ - 80 на большинстве точек. Начали курс резонансной ИК-терапии, но проведено всего три сеанса из-за нехватки времени. Основными излучателями были RV, GI, KH и ZB.

Никаких побочных симптомов не наблюдалось.

Результат: С начала лечения приступов мигрени не было, даже когда больной спал всего несколько часов. На обратном пути был за рулем без остановки 9 часов, но приступа не было, вопреки его ожиданиям. Спустя две недели больной вернулся и продолжил лечение в течение еще 7 дней. Через месяц он прислал письмо, в котором говорит, что приступов не было. Прошло 5 месяцев с первого сеанса, и все еще не было ни одного приступа, АД сохраняется на уровне 120-130/70-80.

45. Длительное срастание перелома бедренной кости**.** ***Больной F.Y.***, мужчина 27 лет

Больной попал в автокатастрофу за 4 месяца до начала лечения, в результате чего получен перелом в середине правой бедренной кости. Два месяца спустя на месте перелома никакого срастания и незначительная костная мозоль. Было проведена костная трансплантация. Через 4 месяца появилась костная мозоль, но не посередине места перелома. Больной ходит на костылях и не может ничего поднимать.

Показатели по ЭАФ на большинстве точек 70-85. Терапию проводили в основном излучателями RC, RV, GI, ZB и KB. Показатели реагировали на излучатель RV, но каждое утро, когда больной приходил на сеанс терапии, показатель оставался на прежнем уровне.

Результат: Через 3 недели повторили рентген, показавший увеличение костной мозоли, а через 6 недель костная мозоль была хорошо сформирована, и больной смог ходить без костылей.

Никаких побочных симптомов не наблюдалось.

Комментарии: В течение первой недели терапии, основываясь на показателях по ЭАФ, замечено, что место перелома не реагирует на излучатель KB, который предназначен для остеогенеза. В данном случае предполагается, что проблема длительного срастания, заключается не в переломе как таковом, а в нарушениях функции многих органов, на что указывают показатели по ЭАФ.

46. Диабетическая ретинопатия**. *Больная Z.A.***, женщина 60 лет

Диабет в течение 15 лет, ухудшение зрения, периферическая нейропатия, чувство онемения в ногах и руках. В области большого пальца правой стопы имеется инфильтрат с выраженной гипермией, отечностью и очагом некроза в центре, однако чувства боли в области инфильтрата нет. Произведено дренирование с выделением 10 мл гноя.

Больную лечили ИК-терапией с применением в основном излучателей GI, ZB и KL.

Результат: Рана зажила, чувствительность на нижних конечностях значительно улучшилась. Чувство онемения на пальцах ног прошло на 90% по сравнению с начальным. Интересным наблюдением было то, что через 3 недели улучшилось зрение. Больная может читать, хотя она не могла этого делать в течение почти 8 лет до начала терапии. Никаких побочных симптомов не наблюдалось.

Комментарии: Излучатель ZB рекомендован к применению при диабетической ретинопатии. Так как он эффективен для лечения диабетической ретинопатии, то данный излучатель можно рекомендовать и для профилактики этого осложнения. Терапия очень легкая, всего по 1 минуте два-три раза в день, и возможно, 1 раз в день в целях профилактики.

47. Диабетическая ретинопатия, гипертония**. *Больной B.Y.***, мужчина 60 лет

Гипертония и диабет в течение 30 лет. Слабое зрение, не может читать. АД контролируется слабо, обычно АД от 150/100 до 170/110 за последние 30 лет. Когда больной обратился в клинику Infra Life, АД постоянно сохранялось на уровне 160-170/110 несмотря на максимальную дозу празозина, нифедипина и enalapril. Диастолическое давление в последние 20 лет никогда не было на

уровне 90 мм. рт. ст. Больной принимает высокие дозы glibenclimide и metformin по поводу диабета.

Проведен курс резонансной ИК-терапии, основные применяемые излучатели - GI, ZB, KL и AK.

Результат: АД значительно уменьшилось, стабилизировалось 130/70. Прием празозина прекращен, доза двух других препаратов от гипертонии снижена наполовину. АД чаще сохраняется на уровне 130/80 рано утором 120-130/70.

Зрение необычайно улучшилось, так, что больной может читать коран и газеты. Периферическая нейропатия на пальцах ног прошла на 90% по сравнению с начальным. Похудел на 9 кг с помощью диеты. Физическое состояние улучшилось, может ходить полчаса без чувства усталости.

Побочных эффектов нет. Улучшение физического состояния и потеря веса рассматриваются как положительные побочные эффекты, которые наблюдаются у большинства пациентов.

Комментарии: Излучатель ZB может быть применен для лечения диабетической ретинопатии. Так как он эффективен для лечения диабетической ретинопатии, то данный излучатель можно рекомендовать и для профилактики этого осложнения. Терапия очень легкая, всего по 1 минуте два-три раза в день, и возможно, раз день в целях профилактики. У 35 из 40 пациентов наблюдалось стабилизация АД. Снижение дозы или прекращение приема медикаментов также являются интересным феноменом. Однако вопрос как поддерживать АД с помощью ИК-излучателей, все еще находится под наблюдением.

48. Обострение хронического подагрического артрита. ***Больной Z.***, мужчина 34 года.

Жалобы на повышенный уровень мочевой кислоты, несмотря на соблюдаемую диету, и возобновляющуюся боль в плюснефаланговых суставах периодичностью раз в месяц в течение 2-х лет. Ко времени обращения в клинику Infra Life больной страдал от непрекращающихся болей в суставах в течение 2 месяцев. Из-за болей прихрамывает при ходьбе. Мочевая кислота 7-8 мг/dl. В течение 2 месяцев получает NSAIDs в инъекциях 4 раза в день и per os.

При осмотре суставы горячие, болезненные и опухшие. Боль пульсирующая, мешает спать и выполнять работу в дневное время.

Проведен курс резонансной ИК-терапии, с применением в основном излучателя GI.

Результат: Через 3 дня лечения боль заметно уменьшилась и через неделю суставы стали невоспаленными и абсолютно безболезненными.

4 месяца спустя, на дату написания данной записи, пациент все еще находится в стадии ремиссии.

49. Инсулинозависимый сахарный диабет**. *Больная,*** женщина 40 лет

Больная страдает инсулинозависимым диабетом, доза инсулина 50 ЕД два раза в день в течение последних 5 лет. Уровень глюкозы в крови 8-12, иногда до 14-16 ммоль/л.

Помещена в больницу с тонзилитом и высоким содержанием глюкозы до 14-16ммоль/л, несмотря на обычную дозу инсулина. Проведен курс резонансной ИК-терапии ежедневно в течение 7 дней, затем нерегулярно - 1 раз в 2-3 дня из-за загруженности на работе.

Результат: Содержание глюкозы в крови, которое проверили до инъекции инсулина, на уровне 4-6 ммоль/л. Доза сокращена до 30 ЕД, но содержание глюкозы сохранялось на уровне 5-6 ммоль/л. Через 2 недели ИК-терапия проводилась нерегулярно, только раз или два в неделю.

Никаких побочных симптомов не наблюдалось.

Комментарии: Резонансная терапия может применяться для лечения диабета I и II типа. У большинства больных получен хороший результат, вплоть до полного отказа от медикаментов, но требуется длительная продолжительность курса 2-3 месяца, что никто из пациентов не желает делать. Практика в Ташкенте также показывает, что дозу инсулина можно значительно снизить.

50. Диплопия миастения гравис**. *Больной J.T.,*** мужчина 50 лет

Больной страдает диплопией постоянно в течение 5 лет, иногда такой силы, что не может вести машину. Постоянно принимает pyridostigmine. Кроме того, у больного имеется липома размеров 5х6 см на правой стороне головы, и повышение АД до 160-170/100-110 несмотря на прием антигипертензивных препаратов.

Проведен курс резонансной ИК-терапии, основной излучатель, применяемый на область глаз - GI, выбраный на основе показателей по ЭАФ. Курс проводился 6 дней в неделю в течение 4-х недель, затем лечение продолжено в домашних условиях, применялись излучатели GI и ZB. Больной приходит на контрольный осмотр раз в две недели.
Результат: В течение 2-х месяцев с начала лечения диплопия больше не

появлялась. Еще неизвестно, будет ли рецидив или нет. АД немного снизилось, сохраняется на уровне 140-150/90-100, прием медикаментов снижен до 1 раза в день.

51. Серонегативный артрит**. *Больная Z.M.***, женщина 36 лет

Больная страдает от болей во многих суставах, особенно в коленных и мелких суставах кистей. По утрам скованность в суставах, абсолютная неспособность разогнуть колени, что продолжается в течение 4-х лет. Иногда не может ходить, боли мешают спать. Обследование хирургом-ортопедом показало, что в крови отклонений нет. Поставлен диагноз серонегативный артрит.

Проведен курс резонансной ИК-терапии, основные применяемые излучатели GI и ZB в течение месяца.

Результат: Боль заметно уменьшилась, нет скованности по утрам, нет болей в суставах в ночное время. По собственной оценке больной облегчение от болей составляет до 90% по сравнению с состоянием до лечения.

Через 2 месяца после прекращения лечения клиническое состояние сохранялось на том же уровне.

Комментарии: Данный метод терапии может дать симптоматическое улучшение при серонегативном артрите. Такой результат наблюдался у еще двух пациентов. Однако в любое время может возникнуть рецидив, так что рекомендовано длительное профилактическое применение излучателей GI и ZB.

52. Серонегативный артрит**. *Больная R.M.***, женщина 50 лет

Больная страдает от болей во многих суставах в течение 2 лет. Основной пораженный сустав -правый плечевой. Вследствие ограничения движений плечо стало "замороженным".

Проведен курс резонансной ИК-терапии, основные применяемые излучатели GI и ZB ежедневно в течение 3 недель.

Результат: Полное избавление от боли, достигнутое состояние поддерживается на момент ведения данной записи уже 8 месяцев .

Побочных симптомов не наблюдалось.

Примечание: Через 8 месяцев больная обратилась повторно по поводу появившейся в течение недели боли в правой крестцово-повздошной области. Боль прошла через неделю.

53. Повышенное содержание холестерина и липидный дисбаланс**.** ***Больная А.М.***, женщина 54 года

У больной повышенное содержание холестерина и соотношение общего холестерина к HDL-холестерину 6.1. Уровень холестерина сохраняется высоким на протяжении многих лет, уровень триглицеридов, LDL-холестерина также высокий.

Проведен курс резонансной ИК-терапии, основные применяемые излучатели GI и ZB на желчный пузырь.

Результат: Через неделю лечения произошло увеличение HDL-холестерина и нормализация уровня триглицеридов и LDL-холестерина. Соотношение общего холестерина к HDL-холестерину сократилось до 4.1 в течение недели, хотя оно сохранялось высоким на протяжении нескольких лет, несмотря на воздержание от пищи с высоким содержанием холестерина.

Побочных симптомов не наблюдалось.

Комментарии: С помощью данного метода терапии легко достигается нормализация уровня холестерина, лучше всего проводить лечение сразу после приема пищи.

54. Тиреотоксическая кардиомиопатия**.** ***Больная У.,*** 62 года, женщина.

Лечилась 2 года в терапевтической клинике в Johor Hospital. Однажды был приступ острой нехватки воздуха, сопровождающийся учащенным сердцебиением и ортопноэ. Больную поместили в больницу на две недели и поставили диагноз тиреотоксическая кардиомиопатия. Наблюдалась левожелудочковая сердечная недостаточность. Выписана на 8 день. Ортопноэ уменьшилось через несколько дней пребывания в больнице, но остальные симптомы, такие как боли в груди, обмороки, повышенная сонливость, учащенное сердцебиение, сохранялись в прежнем состоянии в течение 3 недель. Больная не могла стоять или ходить. Из-за сильной слабости, постоянное желание лежать, не могла сидеть более чем 5 минут, не могла самостоятельно принимать пищу. Кроме того, больная страдала запорами и бессонницей. Симптомы сохранялись вплоть до обращения в клинику Infra Life.

ЭКГ: Фибриляция предсердия

Эхо:Дилятация левого предсердия, утолщение митрального клапана, умеренная дистрофия миокарда левого желудочка и наполнение его на 52 %.

Начато лечение по следующему предписанию: T. Carbimazole 15 mg tds, T. Propnolol 40 mg bd, T. Fusemide 40 mg bd, T slow K, 2 bd, T. Digoxin 0.125 mg OD

Больная принимала данные препараты, но со дня выписки из больницы, она была прикована к постели из-за сильной слабости.

Основываясь на ее физическом состоянии, в клинике Infra Life опасались начинать ИК-терапию, т.к. результат мог быть непредсказуемым, и врачи не хотели брать на себя ответственность в случае ухудшения состояния. Однако семья настояла на пробном курсе резонансной ИК-терапии, потому что они чувствовали себя беспомощными, глядя на такое состояние больной.

ЭАФ показатели на большинстве точек низкие, ниже 10, много точек 0-12. На меридианах лимфатической системы, легких, толстом кишечнике, нервной системы, кровообращения, аллергии, дегенерации органов, сердца, тонкого кишечника около 0-20. На каждом из вышеперечисленных, по крайней мере, на одной точке зарегистрирован показатель '0'. На многих точках зарегистрированы показатели 0, 4, 6 или <10. На следующих меридианах показатели 12-30: поджелудочная железа, селезенка, печень, суставы, желудок, желчный пузырь, почки и мочевой пузырь. После применения излучателя ZB показатели на большинстве точек увеличились до 40, АД 95/65.

При подборе излучателей по ЭАФ больная не реагировала ни на какие излучатели, кроме общего ZB, при котором показатели увеличивались с 10 до 40 на меридианах дегенерации органов и кровообращения. Через 2 минуты показатели начали медленно снижаться и воздействие излучателем было прекращено на показателе 25. На следующий день, до начала лечения большинство показателей были более высокими на уровне 10-20, больная выдержала сеанс продолжительностью до 5 минут.

Через несколько часов после первого сеанса, дома больная смогла больше сидеть, хорошо спала и легко опорожнилась. После второго сеанса она смогла встать и пройти на короткое расстояние. К третьему сеансу показатели были 20-30 по сравнению с 10-20. После 5 сеансов больная смогла молиться стоя пол-молитвы и после 7 сеансов, смогла ходить и выстоять всю молитву.

После 10 сеансов больная чувствовала себя значительно лучше и смогла делать легкую работу по дому. Она почти полностью вернулась к своему первоначальному физическому состоянию. Лечение продолжено с периодичностью один раз в неделю, проведено 2 сеанса и прекращено. Замечено дальнейшее улучшение, чувствует себя хорошо, за исключением периодического учащенного сердцебиения. Последний раз больная пришла на последний осмотр 10 месяцами позже. С тех пор она находится в добром здравии.

55. Системная красная волчанка**.** ***Больная 37 лет***, замужем, 5 детей

Диагноз подтвержден терапевтом. Больная страдает от хронических рецидивирующих болей в суставах и язв в течение 3 лет. Дважды проходила лечение в стационарных условиях, где проводили парентеральное питание по причине невозможности глотать из-за сильных язв во рту и горле. Больная принимает преднизолон по 20 мг в течение 3 лет, без которого происходит усиление болей в суставах и ухудшение язв во рту. Вес тела 75 кг, в некоторой степени наблюдается "лунообразное лицо".

Проведена резонансная ИК-терапия в течение 5 дней. После второго дня лечения, в качестве реакции наблюдалась припухлость лица при нормальном уровне сывороточного белка, и небольшое усиление болей в суставах. Время воздействия ИК-излучателями уменьшили, припухлость уменьшилась на 5 день. Больная не продолжила лечение из-за наступившего улучшения. Произошла потеря массы тела за 2 месяца на 15 кг до 60 кг. Боли в суставах и язвы во рту полностью исчезли. Доза преднизолона была постепенно уменьшена до полной отмены препарата. Симптомов не было до наступления слабых рецидивирующих болей в суставах через 14 месяцев, после чего больная вновь начала принимать преднизолон по 5 мг и обратилась к нам в клинику. На дату настоящей записи больная проходит третий сеанс терапии.

56. Реваскуляризация роговицы из-за контактных линз**.** ***Больной***, мужчина 51 год

Наблюдающий офтальмолог рекомендовал больному пройти хирургическую операцию в Австралии как можно скорее. Больной обратился в клинику Infra Life для прохождения пробного курса резонансной терапии. Продолжал наблюдаться у того же офтальмолога еженедельно для определения реакции на лечение. Наблюдалось утоньшение вновь образованных кровеносных сосудов до состояния, когда они стали неопределяемыми. Роговица стала абсолютно нормальной. Кроме того, все седые волосы стали черными. У него также был шум в ушах в течение 20 лет из-за взрыва бомбы во время службы в армии. После курса терапии шум в ушах больше не появлялся.



56. Витилиго до лечения керамическими излучателями и после.

Витилиго. Пациент Ш. получил лечение ИК излучателями в течение 3 месяцев. До этого он принимал лечение в различных центрах по лечению витилиго, но без положительной динамики. После двух лет наблюдений, рецидива не наблюдается.



58. Базилиома. Динамика эпителизации язвы в процессе лечения ИК-излучателями совместно с криотерапией.

Вывод. Использование функциональной керамики позволило разработать безвредные для организма инфракрасные керамические излучатели, обладающие избирательным воздействием только на патологически

измененные органы и ткани, нормализующие обменные процессы на молекулярном уровне и устраняющие причину болезни, а не только её симптомы.

Более подробно с методом резонансной терапии можно ознакомиться, прослушав наши лекции. Ссылки и QR-код приводятся ниже.

Литература

Лекции Рахимова Р.Х. в YouTube



ЛИТЕРАТУРА

1. Р.Х.Рахимов, Е.В.Ким. Эффект импульсного изменения удельного сопротивления оксидной керамики. Доклады АН УзССР, N7,19-20,1990
2. Рахимов Р.Х., Ким Е.В. Эффект спектрального преобразования керамическими материалами. Доклады АН УзССР, N6, 18-19, 1990
3. Р.Х.Рахимов, Е.В.Ким. Керамические фильтры для установок сушки, оплавления и пайки печатных плат. Материалы 4-й Всесоюзной отраслевой конференции по технологии пайки и сварки материалов. Саратов,1991.
4. Р.Х.Рахимов, Е.В.Ким. Применение керамических материалов в установках сушки, оплавления и пайка. Материалы 4-й Всесоюзной отраслевой конференции по технологии пайки и сварки материалов. Саратов,1991.
5. Р.Х.Рахимов, Л.М.Ни, Е.В.Ким. Газонагреватели для технологических процессов на основе оксидной керамики. Материалы 4-й Всесоюзной отраслевой конференции по технологии пайки и сварки материалов. Саратов, 1991.
6. Р.Х.Рахимов, И.А.Золожкова, Е.В.Ким. Керамические ИК-преобразователи. Материалы 4-й Всесоюзной отраслевой конференции по технологии пайки и сварки материалов. Саратов, 1991
7. Р.Х.Рахимов, Е.В.Ким, И.А.Золожкова. Керамические излучатели для технологических процессов. Материалы 4-й Всесоюзной отраслевой конференции по технологии пайки и сварки материалов. Саратов, 1991
8. Р.Х.Рахимов, Е.В.Ким, И.А.Золожкова, Л.М.Ни. Комбинированный универсальный нагревательный элемент. Материалы 4-й Всесоюзной отраслевой конференции по технологии пайки и сварки материалов. Саратов, 1991
9. Е.В.Ким, Р.Х.Рахимов, И.А.Золожкова. Многослойные керамические элементы для технологических процессов. Материалы 4-й Всесоюзной отраслевой конференции по технологии пайки и сварки материалов. Саратов, 1991
10. Р.Х.Рахимов. Керамические фильтры для установок сушки, оплавления и пайки печатных плат. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С. 41
11. Р.Х.Рахимов. Высокотемпературные керамические нагреватели для работы в воздушной или окислительной среде. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.50
12. Р.Х.Рахимов. Высокотемпературные полупроводниковые материалы на основе хромов РЗЭ. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.51
13. Р.Х.Рахимов. Газонагреватели для технологических процессов на основе оксидной керамики. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.42
14. Р.Х.Рахимов. Керамические излучатели для технологических процессов. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.44
15. Р.Х.Рахимов. Керамические ИК-преобразователи. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.43
16. Р.Х.Рахимов. Комбинированный универсальный нагревательный элемент. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.45

17. Р.Х.Рахимов. Многослойные керамические элементы для технологических процессов. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.46
18. Р.Х.Рахимов. Новый метод стерилизации с использованием функциональной керамики. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.56
19. Р.Х.Рахимов. Получение оксидных материалов с заданными свойствами. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.49
20. Р.Х.Рахимов. Преобразование электрической энергии в импульсное излучение ИК-диапазона. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.55
21. Р.Х.Рахимов. Применение керамических материалов в установках сушки, оплавления и пайки. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.40
22. Р.Х.Рахимов. Устройства сушки, стерилизации, обогрева, гриль нового типа с активными элементами из функциональной керамики. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.47
23. Р.Х.Рахимов. Эффект импульсного изменения удельного сопротивления оксидной керамики. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.52
24. Р.Х.Рахимов. Эффект спектрального преобразования керамическими материалами. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.53
25. Р.Х.Рахимов, А.В. Мейке. «VisiualKinetics» - Пакет программ для химико-кинетических расчетов в материаловедении. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. С.54
26. K.H.K. Shodiev, R.K.H. Rakhimov. E.K. Asedova, T.T. Shakhabiddinov. The new in the therapy of atopic dermatitis: Infrared radiation. JEADV, VOL. 11. Supplement 2, September 1998
27. Т.Х.Каюмов, Р.Х.Рахимов, С.Р.Баймаков. К вопросу о профилактике спаечной болезни брюшной полости. Проблемы биологии и медицины, №4, 1998г.
28. R.Kh.Rakhimov. Ceramic emitter as an eliminator of free radicals. Oxidative Pathways in Health and Disease. Incorporating 8th Meeting of the Society for Free Radical Research (Australia). 30th Meeting of the Australia Society for Experimental Pathology. 32nd Meeting of Australia and New Zealand Enviromental Mutagen Society. 1-4 December, 1999
29. R.Kh.Rakhimov. Narrow-spectrum infrared radiation: a method for correction of immunodeficiencies. International jornal on immunoremabilitation, V.2, N3, May, 2000
30. R.Kh.Rakhimov. A Recombinator of Free Radicals in Complex Treatment of Endocrine Disorders. Program & Abstracts. The Endocrine society's 82nd Annual Meeting. June 21-24, 2000, 356, p.94
31. R.Rakhimov. Ceramic infrared emitters: a resonance method of influencing pathological processes. 13th International Congress on Photobiology and 28th Annual Meeting American Society for Photobiology. San Francisco, California. July 2000. C. 205
32. R.Rakhimov, Kh.Shadiev, T.Shahahiddinov, E.Asedova. Methods of resonance infrared therapy as a non-drug method to normalize the immune status of children with psorisasis

33. R.Kh.Rakhimov. Resonance Therapy by Means of Narrow-spectrum Ceramic Infrared Emitters: A New Approach to Preventing and Treating Diabetes Mellitus. Program & Abstracts. The Endocrine society's 82nd Annual Meeting. June 21-24, 2000, 353, p.93
34. T. Shahabiddinov, R. Rakhimov, E. Asedova, N. Ryanskay. The effect of resonance infrared therapy on blood T cells and skin lesions in psoriasis in children. JEADV (Journal of the European academy of dermatology and venerology) -Volume 14, Supplement 1, September 2000
35. R. Rakhimov, N. Tikhonova, A Zawawi. Threatment of trophic ulcers by exposure to narrow-range far-infrared radiation. JEADV (Journal of the European academy of dermatology and venerology) -Volume 14, Supplement 1, September 2000
36. Р.Х.Рахимов, В.П.Ермаков. Автоматическая система управления процессом сушки. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.202-204
37. Ш.Р.Мадьяров. Биопростективный метод концентрации, сушки и стерилизации биологических объектов в условиях континентального и влажного климата. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.74-76
38. М.Рузибакиев, З.И.Ахмеджанова, И.А.Остроумова, М.Т.Алимова. Влияние инфракрасного излучения на величину иммунного ответа и функциональное состояние тимоцитов крыс. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.76-78
39. Р.Х.Рахимов, З.И.Рихсиев. Возможности применения ИК-излучателей в спортивной медицине. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.111-112
40. Р.Х.Рахимов, З.И.Рихсиев. Возможности применения узкоспектральных ИК-излучателей при лечении больных ИБС. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.149-151
41. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Бахритдинов Д.В., Храмов Л.А. Вулканизация резин и полимеризация высокомолекулярных соединений. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.227-228
42. Р.Х.Рахимов. Выбор оптимального состава планируемого материала с комплексом заданных свойств. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.191-192
43. Р.Х.Рахимов, Н.Н.Тихонова, Н.В.Панфилова. Дальнее узкоспектральное инфракрасное излучение - способ лечения хронического холецистита. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.103-105
44. Р.Х.Рахимов. Инфракрасное излучение - мягкий подход к лечению болезней. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.79-82
45. Т.А.Бобомуратов, Х.М.Маткулов, З.А.Мухитдинов. Инфракрасное излучение - традиции и современность, применение его при различных патологических состояниях. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.138-141
46. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Гулямова Г, Махамедова М.А., Баймухамедова Н.Б. Использование керамики в медицине. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.262-263

47. Р.Х.Рахимов, Г.Н.Трофимова. Использование узкоспектрального излучения в лечении доброкачественных опухолей матки. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.117-119
48. Р.Х.Рахимов, М.А.Хасанова. Использование узкоспектральных керамических излучателей в лечении пневмоний. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.146-147
49. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Махамедова М.А., Гулямова Г., Храмов Л.А. Использование функциональной керамики в процессах термообработки. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.240-241
50. Р.Х.Рахимов. Керамические инфракрасные излучатели - резонансный метод воздействия на патологические процессы. XIII международный конгресс по фотобиологии. Сан - Франциско, Калифорния, июль, 2000
51. Р.Х.Рахимов. Керамические материалы с полупроводниковыми свойствами. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.183-184
52. Р.Х.Рахимов. Керамические преобразователи ИК-спектра. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.169-171
53. Рахимов Р.Х., Ахунджанов М.Б., Ахунджанова Г.З. Лечение больных с хроническим простатитом установкой РАЧ-1. Международная научная конференция “INFRA 2000”. Ташкент, 2000. Сборник статей
54. Р.Х.Рахимов, Н.Н.Тихонова, Dr.Zawawi Abdullah. Лечение бронхиальной астмы узкоспектральным ИК-излучением (результаты клинических наблюдений). Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.68-71
55. Р.Х.Рахимов, М.Б.Ахунджанов, Г.З.Ахунджанова. Лечение гангренозных поражений нижних конечностей ИК-излучателями. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.153-154
56. Р.Х.Рахимов, Ф.А.Усманова. Лечение остеохондроза методом резонансной терапии. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.115-117
57. Р.Х.Рахимов, Г.Н.Трофимова. Лечение хронического аднексита узкоспектральными керамическими излучателями. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.128-130
58. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н., Zawawi Abdullah. Лечении трофических язв дальним узкоспектральным инфракрасным излучением. Конгресс эндокринологов ENDO-2000, Торонто, Канада, июнь 2000
59. Р.Х. Рахимов, Х.К. Шадиев, Т.Т. Шахабиддинов, Е.А. Аседова. Метод резонансной ик-терапии как средство немедикаментозной иммуно-коррекции детей с псориазом. International jornal on immunoremabilitation, V.2, N3, May, 2000
60. С.Р.Баймаков, В.А.Хорошаев, А.Х.Янгиев, Т.Х.Каюмов. Морфогенез спайкообразования в брюшной полости при облучении инфракрасным излучением. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.106-109
61. Р.Х.Рахимов, Т.Х. Каюмов, С.Р. Баймаков О профилактике спаечной болезни брюшной полости. Проблемы биологии и медицины, №4, 2000 г
62. Р.Х.Рахимов, Г.Н.Трофимова,М.А.Хасанова, М.Б.Ахунджанов, Г.З.Ахунджанова, Ф.А.Усмонова. Описания клинических случаев эффективного лечения заболеваний

методом резонансной терапии узкоспектральными инфракрасными излучателями. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.154-162

63. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Елисеева Л.Л. Определение максимальной излучательной способности керамики в зависимости от концентраций клеев и связок. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.192-193
64. Р.Х.Рахимов, М.Б.Ахунджанов, Г.З.Ахунджанова. Опыт лечения аденомы предстательной железы узкоспектральными инфракрасными излучателями. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.122
65. Р.Х.Рахимов, М.Б.Ахунджанов, Г.З.Ахунджанова. Опыт лечения гриппа узкоспектральными инфракрасными (ИК) излучателями. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.125-126
66. Р.Х.Рахимов, Н.Н.Тихонова. Основные причины возникновения заболеваний и принципы их лечения дальним узкоспектральным инфракрасным излучением. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.83-100
67. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н. Основные причины заболеваний и принципы их лечения дальним узкоспектральным инфракрасным излучением. Международная научная конференция “INFRA 2000”. Ташкент, 2000. Сборник статей
68. Т.А.Бобомуратов. Оценка иммунологической эффективности инфракрасного излучения при остром бронхите у детей. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.100-103
69. Р.Х.Рахимов, Д.Р.Шадманова. Оценка эффективности лечения хронических энтероколитов и колитов методом резонансной терапии. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.133-134
70. Баймаков С.Р., Каюмов Т.Х., Рахимов Р.Х. Применение инфракрасного излучения для профилактики образования спаек в брюшной полости. Международная научная конференция “INFRA 2000”. Ташкент, 2000. Сборник статей
71. Р.Х.Рахимов. Применение системы импульсного преобразования энергии в кулинарии. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.219-220
72. Р.Х. Рахимов, А.Ш. Ваисов, Н.Н. Тихонова. Применение узкоспектрального инфракрасного излучения в терапии дерматозов. Новости дерматологии и венерологии, №3, 2000
73. Рахимов Р.Х., Ахунджанов М.Б., Ахунджанова Г.З. Применение узкоспектральных ИК-излучателей в лечении онкологических заболеваний. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.105-106
74. Р.Х.Рахимов, Г.И.Насырова. Применение узкоспектральных керамических излучателей в лечении эпидемического паротита. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.141-142
75. Р.Х.Рахимов. Принцип действия и области применения керамического излучателя. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.28-45
76. Рахимов Р.Х. Принцип действия и области применения керамического излучателя. Международная научная конференция:Innovation-2000, Бухара, 2000

77. Рахимов Р.Х., Ким Е.В., Золожкова И.А., Ни Л.М., Ермаков В.П., Махамедова М.А., Баймухамедова Н.Б., Атаманова М.У., Расулов Д.Ш. Принципы выбора керамических материалов ИК-излучателей для применения в медицине. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.199-201
78. Р.Х.Рахимов. Принципы разработки технологической цепи производства целевого материала. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.167-169
79. Р.Х.Рахимов, В.П.Ермаков. Приставка, усиливающая воздействия лечебных ламп. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.263-264
80. С.Р.Баймаков, Т.Х.Каюмов, Р.Х.Рахимов. Применение инфракрасного излучения для профилактики образования спаек в брюшной полости. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.123-125
81. Р.Х.Рахимов. Разработка системы расчета состава и технологии получения материалов с заданными свойствами на БСП. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.165-166
82. Р.Х.Рахимов, Е.А.Аседова. Резонансная терапия в комплексном лечении псориаза у детей. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.109-111
83. Dr.ZawawiAbdulah, Р.Х.Рахимов, Н.Н.Тихонова. Результаты клинических наблюдений за больными сахарным диабетом, получавшими лечение дальным узкоспектральным ИК-излучением. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.163-164
84. Dr.AbdulahZawawi. Результаты клинического наблюдения за больными раком получившими лечение узкоспектральным ИК-излучением. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.64-65
85. Б.Косаева. Результаты лечения больных методом резонансной терапии узкоспектральным инфракрасным излучением. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.119-121
86. А.М.Саидмурадов, Т.Р.Абдурасулова, Б.М.Маматов. Результаты лечения заболеваний методом резонансной терапии узкоспектральными инфракрасными излучателями. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.126-128
87. Рахимов Р.Х. Рекомбинация свободных радикалов в комплексной терапии эндокринных заболеваний. Конгресс эндокринологов ENDO-2000, Торонто, Канада, июнь 2000 июнь 2000
88. Р.Х.Рахимов. Система импульсного преобразования оптического излучения первичных источников. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С. 180-181
89. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Ибрагимов К.Н., Храмов Л.А. Стерилизация и утилизация госпитальных отходов. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.231-232
90. Рахимов Р.Х. Узкоспектральное инфракрасное излучение - способ коррекции иммунодефицитных состояний. International Journal, on immunorehabilitation - май, 2000
91. Р.Х.Рахимов, Е.А.Аседова. Узкоспектральный противовирусный керамический излучатель в терапии HerpesSimplex у детей Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.151-153

92. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Храмов Р.А. Установка «СТ». Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.260-261
93. Р.Х.Рахимов. Эффект импульсного изменения удельного сопротивления. Международная научная конференция «Infra-2000». Сборник научных статей. Т. 2000, С.171-174
94. R.Kh.Rakhimov, M.S.Saidov. Advanced materials. 17-21 September 2001, Islamabad, Pakistan. Solar-Radiation heating Photoluminescence and Application of Micrograin Ceramics with intergrain heterolayers
95. Р.Х.Рахимов. Синтез высокотемпературных оксидных материалов заданного стехиометрического состава на БСП. Гелиотехника, 2001, № 4, стр 87-91
96. Р.Х.Рахимов, М.С.Саидов. Солнечно-радиационный нагрев и импульсная фотолюминесценция микрозернистой керамики с межзеренными геторослоями. Гелиотехника, 2001, № 2, стр 71-74
97. Р.Х.Рахимов, М.С.Саидов. Керамика с энергетическим барьером и двухимпульсное температурное излучение. Гелиотехника. 2002. № 3. С.
98. R.Kh. Rakhimov, M.S. Saidov. Ceramic Solar Energy Converters and IR Therapy. Applied Solar Energy (Geliotekhina). 3. Vol. 38, 2002. Allerton Press, Inc. NewYork. p.71-74.
99. Р.Х.Рахимов, В.П. Ермаков. Автоматическая система управления процессом сушки. Труды III национальной конференции «Рост, свойства и применение кристаллов» 22-23 октяюря, Ташкент, 2002, стр.133-134
100. Р.Х.Рахимов, В.П. Ермаков, М.А. Махамедова. Использование функциональной керамики в процессах термообработки. Труды III национальной конференции «Рост, свойства и применение кристаллов» 22-23 октяюря, Ташкент, 2002, стр.135-136
101. Р.Х.Рахимов, М.С. Саидов. Керамика с энергетическим барьером и двухимпульсное температурное излучение. Труды III национальной конференции «Рост, свойства и применение кристаллов» 22-23 октяюря, Ташкент, 2002, стр.131-132
102. А.Л.Аляви, М.М.Каримов, Ш.Т.Гулямов. Использование инфракрасных излучателей с керамическим покрытием при комплексном лечении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Научно-практический журнал физиотерапия, бальнеология, реабилитация, Издательство Медицина, 4, 2003, С. 14-16
103. Рахимов Р.Х. К проблеме Арала. Инновация- 2003, Сборник научных статей, стр.328-329, Ташкент, 2003
104. Рахимов Р.Х., Завави А., Тихонова Н.Н. Лечение вирусных заболеваний. Пленарный доклад. Инновация- 2003, Сборник научных статей, стр.31-33, Ташкент, 2003
105. Рахимов Р.Х. и др. Метод «Инфра Р» терапии (с использованием излучателей узкоспектрального инфракрасного излучения дальнего диапазона) в лечении локализованных форм гнойно-воспалительных заболеваний у недоношенных новорожденных и детей раннего возраста. Ташкент, 2003.
106. Рахимов и др. Реабилиционное лечение больных холестатическими поражениями печени перенесших холецистэктомию. Ташкент, 2003
107. Ермаков В.П., Рахимов Р.Х. Теплоотводящая функциональная керамика в системах охлаждения. Инновация- 2003, Сборник научных статей, стр.92-94, Ташкент, 2003
108. R.Rakhimov, P.John. DIE NEUE S&Q-TECHNOLOGIE (SYSTEM STIR). Unabhangiges magasin der backranche. 10, 2003, p. 2-5.
109. P.John, R.Rakhimov. WIR REVOLUTIONIEREN DAS BACKEN. Unabhangiges magasin der backranche. 10, 2003, p. 6-7

110. Р.Х.Рахимов, М.С.Саидов Возможности использования солнечных емкостных коллекторов для нагрева воды, ИК-сушки и терапии. Гелиотехника, 2004 г., № 2, стр. 88-89
111. Р.Х.Рахимов. О возможном механизме возникновения сил гравитации. Математическая морфология электронный математический и медико-биологический журнал – Том 5. – Выпуск 2 – 2004
112. Р.Х.Рахимов, В.П.Ермаков. Определение максимальной излучательной способности керамик в зависимости от концентрации их со связующими. Гелиотехника, 2004, № 1, стр 71-72
113. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков, P.John. Применение функциональной керамики для охлаждения фотоэлементов. Ташкент, 2004, Материалы конференции посвященные 90 летию С.А.Азимова.
114. Рахимов Р.Х. Принципы разработки материалов с комплексом заданных свойств при синтезе на БСП. Ташкент, 2004, Материалы конференции посвященные 90 летию С.А.Азимова. стр. 176-178
115. Рахимов Р.Х. Принципы разработки материалов с комплексом заданных свойств. Ташкент, 2004, Материалы конференции посвященной 90 летию С.А.Азимова.
116. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков, P.John. Сушка автомобильного лака с применением функциональной керамики. Ташкент, 2004, Материалы конференции посвященной 90 летию С.А.Азимова стр. 175
117. Тихонова Н.Н. «Инфра Р» терапия при лечении пиелонефрита. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С.37-39
118. R.Kh. Rakhimov, M.S.Saidov. Development of ceramic coatings and application of their infrared radiation. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 204-211
119. Рахимов Р.Х. Влияние инфракрасного излучения на величину иммунного ответа и функциональное состояние тимоцитов крыс. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С. 28-30
120. Тихонова Н.Н. Комплексное использование ламп с керамическим покрытием. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С.31-33
121. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков. Конвейерная сушка овощей и фруктов при повышенной влажности воздуха Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 133-136
122. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков. Конвейерная сушка риса и кукурузы при повышенной влажности воздуха. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 125-130
123. Рахимов Р.Х. Некоторые механизмы развития диабета и их коррекция с помощью узкоспектрального инфракрасного излучения. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С.13-15
124. Рахимов Р.Х. О выборе компонентов при синтезе материалов с комплексом заданных свойств на БСП. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 196-199

125. Рахимов Р.Х., Шадманова Д.Р., Оценка эффективности лечения хронических энтероколитов и колитов методом резонансной терапии. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С.36-37
126. Р.Х. Рахимов. Преобразователи спектра на основе функциональной керамики. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение». Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 219-223
127. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н., Епишева Л.В.Применение дальнего узкоспектрального инфракрасного излучения при лечении вульгарных угрей. Карши. 2005. Актуальные вопросы дерматологии и венерологии. С.224-226
128. Рахимов Р.Х. Тихонова Н.Н. Применение дальнего узкоспектрального инфракрасного излучения при лечении вульгарных угрей. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С.41-43
129. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Применение керамических материалов в процессах стерилизации. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С.39-41
130. Алимов А.С., Рахимов Р.Х., Шадманова Д.Н., Применение узкоспектрального инфракрасного излучения при лечении заболеваний пародонта у больных с фоновой кардиоцеребральной патологией. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик анларнинг долзарб муаммолари» С.26-28.
131. Тихонова Н.Н., Рахимов Р.Х. Применение узкоспектрального инфракрасного излучения при лечении аллергодермитов. Карши. 2005. Актуальные вопросы дерматологии и венерологии. С.276-278
132. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков. Применение функциональной керамики в системах охлаждения. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 232-236
133. 133. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков, P.John. Применение функциональной керамики для охлаждения фотоэлементов. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 237-239
134. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков. Применение функциональной керамики для сушки красок, полимеризации высокомолекулярных соединений и вулканизации резин. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 228-232
135. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков. Применения функциональной керамики в процессах сушки макаронных изделий. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 118-123
136. Рахимов Р.Х. Принципы разработки материалов с комплексом заданных свойств. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение». Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 192-195
137. Тихонова Н.Н., Рахимов Р.Х., Абидова З.М. Результаты применения «Инфра Р» терапии при микозах. Карши. 2005. Актуальные вопросы дерматологии и венерологии. С.278-280
138. Тихонова Н.Н., Рахимов Р.Х., Результаты применения «Инфра Р» терапии при микозах. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С.33-35

139. Рахимов Р.Х. Синтез высокотемпературных оксидных материалов заданного стехиометрического состава на БСП. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 199-203
140. Рахимов Р.Х. Синтез многослойных оксидных материалов с использованием лучистого нагрева. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 212-213
141. Ермаков В.П., Рахимов Р.Х., Стерилизация и утилизация госпитальных отходов. Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С.30-31
142. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков, P.John. Сушка промышленных катализаторов и древесины с применением функциональной керамики. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 136-141
143. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков, P.John. Сушка фруктовых паст, специальных продуктов и кормов. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 130-132
144. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков. Транспортерная сушка сыпучих материалов. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 123-125
145. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Атаманова М., Установка «СТ» Самарканд, 2005, Сборник статей научно-практической конференции «Физика ва тиббий биологик фанларнинг долзарб муаммолари» С.43-45
146. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков, P.John. Фиксация и термообработка литейных форм. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение» Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 240-241
147. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков. Функциональная керамика в системах стерилизации. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение». Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 223-227
148. Р.Х. Рахимов, В.П. Ермаков. Эффект воздействия импульсных полей на элементы с различной валентностью. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение». Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 217-219
149. Рахимов Р.Х. Эффект импульсного изменения удельного сопротивления. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение». Ташкент 2005 г. 29-30 сентября стр 214-216
150. Рахимов Р.Х., Завави А., Тихонова Н.Н. Лечение вирусных заболеваний. Пленарный доклад. Инновация- 2003, Сборник научных статей, стр.31-33, Ташкент, 2003.
151. Рахимов Р.Х. Тор спектрли инфракизил нурларини диффуз ва таркалган перитонитларни даволашда куллаш. Тошкент, 2003.
152. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Саидов М.С. Керамические покрытия и возможность использования фотонной теплопроводности в солнечных сушилках. IV Республиканской конференций «Рост, свойства и применение кристаллов». Нукус, 2005, стр.86-87.

Книги

1. Рахимов Р.Х. Резонансная терапия Ташкент, “InfraR”, 1999, 44 стр.
2. Rustam Kh. Rakhimov. Infrared radiation – a mild approach to medical treatment Tashkent, “Янги аср авлоди”, 2000.
3. R. Rakhimov, N. Tikhonova**.** Resonance therapy Ceramic Materials and Methods of Their Application in Medicine Parti. Tashkent, “Янги аср авлоди”, 2000.
4. Рахимов Р.Х. и др. Инфракрасное излучение–мягкий подход к лечению болезней. Ташкент, “Янги аср авлоди”, 2000, 40стр.
5. Рахимов Р.Х. и др. Резонансная терапия. Ташкент, “Янги аср авлоди”, 2000, 160стр.
6. В.Н.Чеботин.Химическая диффузия в твердых телах. «Наука», 1989, 208стр.
7. Н.И.Ковалев, В.В.Усов. Рассказы о тайнах домашней кухни. М., «Химия», 1993, 336стр.
8. Внутренние болезни. Под ред. Б.И.Шулутко**,** Ленинград: Медицина, 1991.
9. Ляхович В.В., Цырлов И.Б. Структурные аспекты биохимии монооксигеназ. Новосибирск: Наука, 1978.
10. Мак-Мюррей У. Обмен веществ у человека. Москва: Мир, 1980.
11. Муратходжаев Н.К. Очерки современной онкологии. Ташкент: ФАН, 1996.
12. Популярная медицинская энциклопедия. Изд.3, Москва: Советская энциклопедия, 1991.
13. Розанцев Э. Г. Химия и жизнь 1986 №7, с. 24-27.
14. Новый справочник химика и технолога. Электродные процессы. Химическая кинетика и диффузия. Коллоидная химия,в 7 томах, под общей редакцией чл.-корр. Б.П. Никольского, С-Пб, 2004.
15. Фолль Р. Топографическое положение точек замера при электроиглотерапии. Том 1. Москва: ТЕХАРТ, 1993.
16. Шамбах Х. и др. Гормонотерапия. Москва: Медицина, 1988.
17. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н. Керамические материалы и их применение, часть 1. Ташкент, 2003, 186 стр.
18. Рахимов Р.Х. Керамические материалы и их применение. Часть 2, том 1. Видимый и невидимый свет. Ташкент, УзПФИТИ, 2003.
19. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н. Керамические материалы и их применение. Часть 2, том 2. Метод InfraR. Ташкент, УзПФИТИ, 2003.
20. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н. Керамические материалы и их применение. Часть 2, том 3. Новый взгляд на старые болезни. УзПФИТИ, Ташкент, 2003.
21. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н., Улугмурадов Н.Х. Резонансная терапия по методу Р.Рахимова Ташкент, 2003, 200 стр.
22. Р.Х.Рахимов, Н.Н.Тихонова. Керамические материалы и их применение. «ИНФРА Р» - терапия по методу Р.Рахимова. Москва, РУДН, 2004, 125 СТР.
23. Рахимов Р.Х. Основы «Инфра-Р» терапии по методу Р.Рахимова. Изд. «Фаргона», 2004, 155 стр.
24. Хенней Н. Химия твердого тела. М.: Мир, 1971. 223 с.
25. Гилевич М.П., Покровский И.И. Химия твердого тела. Мн.: Изд-во Университетское, 1985. 192 с.
26. Вест А. Химия твердого тела. Теория и приложение: В 2 ч. М.: Мир, 1988.
27. Моррисон С. Химическая физика поверхности твердого тела. М.: Мир, 1980. 488 с.
28. Чеботин В.Н. Физическая химия твердого тела. М.: Химия, 1982. 320 с.
29. Ковтуненко П.В. Физическая химия твердого тела. М.: Высш. шк., 1992. 470 с.
30. Джейкок М., Прафит Дж. Химия поверхностей раздела фаз. М.: Мир, 1984. 270 с
31. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н. Введение в «Инфра-Р» терапию по методу Р.Рахимова. Изд. «Фаргона», 2005, 205 стр.

32. Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н., Улугмурадов Н.Х. Р.Рахимов услуби асосидаги резонанс терапия. Изд. «Фаргона», 2005, 225 стр.
33. Рахимов Р.Х. Керамические материалы и их применение. часть 3. Результаты изучения воздействия узкоспектрального дальнего инфракрасного излучения методом резонансной терапии. Р. РАХИМОВА (МЕТОД «INFRAR») на течение различных болеваний. Изд. «Фаргона», 2005, 174 стр.
34. Микини В. Руководство по хлебопекарному и дрожжевому производству. С-Пб. 1912 г.

Патенты и Авторские свидетельства

1. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1190573 дата регистрации 08.07.1985 Способ получения липазы из семян хлопчатника. (Соавт.: Азимов С.А.)
2. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686814 дата регистрации 22.07.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент (Соавт.: Ким Е.В.)
3. Рахимов Р.Х.Авторское свидетельство СССР № 1686815 дата регистрации 22.07.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент (Соавт.: Ким Е.В., Атаманова М.У.)
4. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686816 дата регистрации 22.06.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент
5. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686817 дата регистрации 22.07.1990. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент (Соавт.: Ким Е.В.)
6. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686818 дата регистрации 22.07.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент (Соавт.: Ким Е.В.)
7. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686819 дата регистрации 22.06.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент (Соавт.: Ким Е.В.)
8. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686820 дата регистрации 22.07.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент (Соавт.: Ким Е.В., Золожкова И.А.)
9. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686821 дата регистрации 11.01.1990. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент
10. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686822 дата регистрации 22.06.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент
11. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686823 дата регистрации 22.07.1991 Высокотемпературный керамический нагревательный элемент (Соавт.: Ким Е.В., Баймухамедова Н. Б.)
12. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1686824 дата регистрации 22.07.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент (Соавт.: Ким Е.В., Ни Л.М.)
13. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1692114 дата регистрации 15.07.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент (Соавт.: Ким Е.В.)
14. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1693861 дата регистрации 22.07.1991. Высокотемпературный керамический нагревательный элемент
15. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1722007 дата регистрации 22.11.1991. Шихта для получения керамического материала (Соавт.: Ни Л.М.)
16. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1736118 дата регистрации 22.01.1992. Высокотемпературный электропроводящий керамический материал (Соавт.: Золожкова И.А.)

17. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 257110 дата регистрации 01.07.1987 (Соавт.: Азимов С.А., Абдурахманов Б.А.)
18. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 267656 дата регистрации 04.01.1988 (Соавт.: Азимов С.А., Абдурахманов Б.А.)
19. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 268949 дата регистрации 01.02.1988 (Соавт.: Азимов С.А.)
20. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 275808 дата регистрации 01.06.1988 (Соавт.: Азимов С.А., Золожкова И.А.)
21. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 281612 дата регистрации 01.09.1988 (Соавт.: Азимов С.А., Золожкова И.А.)
22. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 281867 дата регистрации 01.09.1988
23. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 283174 дата регистрации 03.10.1988
24. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 283179 дата регистрации 03.10.1988
25. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 286688 дата регистрации 02.01.1989
26. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 288388 дата регистрации 01.02.1989
27. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 297764 дата регистрации 03.07.1989
28. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 704080 дата регистрации 21.08.1979. Способ получения липазы (Соавт.: Азимов С.А.)
29. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 780736 дата регистрации 18.07.1980. Донорная примесь (Соавт.: Нигматов И., Гафуров Б.Л., Аскаров М.А.)
30. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 900644 дата регистрации 21.09.1981. Способ получения липазы (Соавт.: Азимов С.А.)
31. Рахимов Р.Х. Евразийский патент № 001194 дата регистрации 30.08.2000. Способ лечения организма пациента
32. Рахимов Р.Х. Евразийский патент № 001411 дата регистрации 16.11.2000. Способ лечения организма пациента «Рахимов RC»
33. Рахимов Р.Х. Евразийский патент № 001874 дата регистрации 22.10.2001. Керамический материал, испускающий инфракрасное излучение
34. Рахимов Р.Х. Евразийский патент № 001965 дата регистрации 22.10.2001. Электропроводящий керамический материал
35. Рахимов Р.Х. Патент СССР № 1839730 дата регистрации 1.07.1991. Способ стерилизации предметов
36. Рахимов Р.Х. Патент СССР № 1839627 дата регистрации 13.10.1992. Стерилизатор (Соавт.: Егай Б.А.)
37. Рахимов Р.Х. Патент СССР № 1839722 дата регистрации 30.12.1993. Способ выпечки узбекских лепешек (Соавт.: Ким Е.В.)
38. Рахимов Р.Х. Патент СССР № 1839729 дата регистрации 30.12.1993. Устройство для стерилизации предметов (Соавт.: Ким Е.В., Алиева С.Н., Арифова Д.А.)
39. Рахимов Р.Х. Патент СССР № 1839730 дата регистрации 30.12.1993. Способ стерилизации предметов
40. Рахимов Р.Х. Патент СССР № 1839731 дата регистрации 30.12.1993. Устройство для стерилизации предметов (Соавт.: Ким Е.В., Сахаров Б.А., Родкевич А.С., Дзекановский В.В.)
41. Рахимов Р.Х. Патент СССР № 1839732 дата регистрации 30.12.1993. Способ стерилизации предметов
42. Рахимов Р.Х. Патент СССР № 1839733 дата регистрации 30.12.1993. Устройство для стерилизации предметов

43. Рахимов Р.Х. Патент РУз № IAP 01975 дата регистрации 12.05.2000. Инфракизил нур таратувчи сопол материал
44. Рахимов Р.Х. Патент РУз № IAP 01998 дата регистрации 30.08.2000. Электр утказувчи сопол материал
45. RustamK. Rakhimov. Патент США № 5,472,720 дата регистрации 5.12.1995. Treatment of materials with infrared radiation (Соавт.: Elena V. Kim)
46. RustamK. Rakhimov. Патент США № 5,350,927 дата регистрации 27.09.1994. Radiation emitting ceramic materials and devices containing same (Соавт.: Elena V. Kim)
47. RustamRakhimov Патент США № US 6,200,501 B1 дата регистрации 13.03.2001. Electroconductive ceramic material
48. RustamRakhimov Патент США № US 6,251,306 B1 дата регистрации 26.06.2001. Infrared radiation emitting ceramic material
49. Rustam Khakimovich Rakhimov Патент США № US 6,379,377 B1 дата регистрации 30.04.2002. Use of infrared radiation in the treatment of oncological disorders
50. RustamRakhimov Турецкий патент № TR 1999 03163 T2 дата регистрации 15.05.1998. Kizil otesi radyasyon yayici seramik malzeme
51. RustamRakhimov Турецкий патент № TR 2000 00240 B дата регистрации 21.12.2000. Elektro-iletken seramik malzeme
52. RustamRakhimov Эстонский патент № NR 00196 дата регистрации 19.03.1999. Puidujapuidutoodetekuivatamiseseade (Соавт.: MihhailZenov, AleksanderRodkevich, VadimDzekanovski, VladimirDembinski)
53. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 5224 дата регистрации 05.11.1997. Электр утказувчи сополли материал
54. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 5636 дата регистрации 21.04.1998. Бемор организмини даволаш усули
55. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 6010 дата регистрации 23.09.1999. «Рахимов RC» бемор организмини даволаш усули
56. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 6005 дата регистрации 29.10.1999. Материаллар ва предметларни стериллаш усули ва уни амалга ошириш учун курилма
57. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 5223 дата регистрации 24.11.1997. Сополли материал
58. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 6033 дата регистрации 07.10.1999. Сополли материал
59. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 6032 дата регистрации 07.10.1999. Сополли материал
60. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 2320 дата регистрации 13.12.1994. Утга чидамли сопол материал
61. Кашин Н.А., Хорн В.Н., Кашин Д.Н., Посредников Н.И., Юшков А.Н. Патент на промышленный образец № 39439 дата регистрации 30.08.1993. Шкаф сушильный
62. Кашин Н.А., Хорн В.Н., Кашин Д.Н., Посредников Н.И., Юшков А.Н. Патент на промышленный образец № 39438 дата регистрации 30.08.1993. Шкаф сушильный
63. Rakhimov Rustam, John Peter. Европейский патент. № 05002949.5 от 11.02.05 Ceramic compostion and light source for processing plastic materials

Интернет:

1. Продукт и его первичная обработка. http://kuking.net/8_680.htm
2. http://kuking.net

3. http://www.kulina.ru
4. http://www.indianspices.ru
5. http://www.nebolei.ru
6. http://www.shpilka.ru
7. http://www.cooking-book.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ВЕДЕНИЕ.....2

МЕХАНИЗМ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ.....4

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ИХ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА.....8

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЛЛАГЕН И ТРОМБЫ.....15

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРИНЦИПЫ ИХ ЛЕЧЕНИЯ ДАЛЬНИМ УЗКОСПЕКТРАЛЬНЫМ ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ.....44

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ.....54

МОРФОГЕНЕЗ СПАЙКООБРАЗОВАНИЯ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ.....70

ЛЕЧЕНИЕ АМЕНОРЕИ.....80

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЕТОДОМ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ УЗКОСПЕКТРАЛЬНЫМ ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ.....86

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕТОДОМ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ УЗКОСПЕКТРАЛЬНЫМИ ИНФРАКРАСНЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ..93